Médecine

Corrigé des 706 questions

Questions • Propositions • Réponses • Explications • Sources

Les questions sont numérotées de 1 à 706. Pour les questions à choix multiples, toutes les lettres retenues sont indiquées. Pour les questions à choix doubles : A = Vrai ; B = Faux.

Les cas cliniques précèdent les séries concernées. Les explications distinguent les informations établies des situations nécessitant des données cliniques ou un référentiel national daté.

Repères de lecture

1–66 Tuberculose

67–88 Insuffisance respiratoire et oxygénothérapie

89–106 Œdème aigu du poumon et cardiologie

107–129 Asthme et sémiologie respiratoire

130–174 Pathologies digestives

175–177 Ponction d’ascite

178–195 Diabète et troubles métaboliques

196–203 Trachéotomie

204–241 Infections et études cliniques

242–278 Démarche de soins infirmiers

279–303 Transfusion et accidents d’exposition

304–344 VIH et traitements antirétroviraux

345–372 Appareil urinaire

373–384 Escarres et sondage urinaire

385–503 Sémiologie générale

504–530 Questions cliniques et traitement du VIH

531–574 Infections sexuellement transmissibles questions vrai ou faux

575–602 Infections sexuellement transmissibles questions à choix multiples

603–642 Maladies infectieuses

643–666 Situations cliniques diverses

667–706 VIH et traitements antirétroviraux deuxième série

Tuberculose

Question 1 — L’IDR explore l’hypersensibilité immédiate à la tuberculine :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’IDR explore une hypersensibilité retardée, à médiation cellulaire.

Source : CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

Question 2 — La forme méningée de la tuberculose est la plus fréquente :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La localisation pulmonaire est la plus fréquente.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 3 — La coinfection par le virus de l'hépatite B est un des facteurs susceptibles d’augmenter le risque de développer une tuberculose en cas d’infection tuberculeuse latente :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le VIH, la dénutrition et les immunosuppresseurs sont des facteurs établis ; le VHB seul n’est pas un facteur classique équivalent.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 4 — C'est le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La tuberculose est due au complexe Mycobacterium tuberculosis, dont le bacille de Koch.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 5 — La tuberculose est une maladie virale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : C’est une infection bactérienne, non virale.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 6 — La tuberculose se retrouve surtout dans les pays en voie de développement.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La charge de la maladie est particulièrement élevée dans les pays à ressources limitées.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 7 — Il y a l'émergence de souches multi résistantes de la tuberculose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Des souches résistantes, notamment à l’isoniazide et à la rifampicine, circulent.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 8 — La tuberculose humaine, toutes espèces du complexe tuberculeux confondues, se transmet exclusivement par voie aérienne.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La transmission humaine habituelle est aérienne ; le mot « seulement » exclut les rares autres transmissions du complexe tuberculeux.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 9 — Le bacille de la tuberculose pénètre les voies inférieures respiratoires où il sera phagocyté par les lymphocytes T CD4.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les premiers phagocytes impliqués sont les macrophages alvéolaires, non les lymphocytes CD4.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 10 — La tuberculose peut se disséminer par voie sanguine ou lymphatique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La dissémination peut être lymphatique et hématogène ; ces deux voies sont distinctes.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 11 — Lors de la tuberculose, il y a obligatoirement un syndrome inflammatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Un syndrome inflammatoire biologique n’est pas constant.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 12 — L'échec d'un traitement d'une pneumonie avec altération de l'état général doit évoquer la tuberculose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une toux persistante et une altération de l’état général malgré un traitement doivent faire rechercher une tuberculose.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 13 — Le diagnostic de certitude de la tuberculose consiste à faire 3 prélèvements des expectorations spontanées matinales sur 3 jours consécutifs.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La confirmation repose sur la détection du bacille, notamment par test moléculaire ; trois prélèvements ne constituent pas à eux seuls un diagnostic.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 14 — L'intradermoréaction (IDR) à la tuberculine est un diagnostic de l'immunocompétence d'une personne à la tuberculose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’IDR recherche une sensibilisation tuberculeuse ; elle ne mesure pas globalement l’immunocompétence.

Source : CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

Question 15 — La lecture de l'IDR se fait 48 heures après l'injection de tuberculine.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La fenêtre de lecture recommandée est de 48 à 72 heures ; 48 heures en fait partie.

Source : CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

Question 16 — Un masque aux normes FFP2 est conseillé pour les soignants et visiteurs.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un appareil respiratoire FFP2 adapté protège contre les particules infectieuses aériennes.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 17 — Non traitée, la tuberculose est mortelle dans 100% des cas.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La létalité sans traitement est importante, mais n’atteint pas systématiquement 100 %.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 18 — La tuberculose n'est pas une maladie à déclaration obligatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La tuberculose relève de la notification et de la surveillance sanitaire nationale.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 19 — Le schéma classique de six mois pour une tuberculose sensible associe quatre antibiotiques pendant deux mois puis deux pendant quatre mois.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le schéma classique d'une tuberculose sensible est 2HRZE/4HR ; d'autres schémas existent selon le cas.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 40, antituberculeux ; connaissances complémentaires pour les schémas thérapeutiques.

Question 20 — L'Isoniazide et la Rifampicine sont un exemple d'antibiotiques utilisés.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'isoniazide et la rifampicine font partie des antituberculeux de première ligne.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 40, antituberculeux ; connaissances complémentaires pour les schémas thérapeutiques.

Question 21 — Le BCG est le vaccin contre la tuberculose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le BCG protège surtout les jeunes enfants contre les formes graves.

Source : OMS, Tuberculosis, fiche du 24 mars 2026.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

Question 22 — En Côte d'Ivoire, le BCG a été supprimé du calendrier vaccinal à partir de 2007.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Cette affirmation française ne s'applique pas au PEV ivoirien, où le BCG est recommandé dès la naissance.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 23 — La fièvre, les sueurs nocturnes et la toux accompagnée d'expectorations parfois teintées de sang font partie des symptômes de la tuberculose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Toux persistante, fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement et parfois hémoptysie sont évocateurs.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 24 — L’injection de l’intradermoréaction se fait dans la partie médiane de la face interne de l’avant-bras.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’injection est intradermique sur la face interne de l’avant-bras.

Source : CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

Question 25 — La tuberculose touche principalement le cœur.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La tuberculose touche principalement les poumons.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 26 — La tuberculose se développe particulièrement chez les personnes vivant dans la pauvreté.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Précarité, promiscuité et dénutrition favorisent exposition et progression vers la maladie.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 27 — Le lavage simple des mains contribue efficacement à la prévention de la tuberculose nosocomiale :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’hygiène des mains reste nécessaire, mais ne suffit pas contre la transmission aérienne ; ventilation et protection respiratoire sont essentielles.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 28 — La tuberculose doit être systématiquement recherchée chez toute personne vivant avec le VIH (PVVIH) :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un dépistage régulier des symptômes de tuberculose est indiqué chez les PVVIH.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 29 — En raison de la gravité de la co-infection, tout malade dépisté tuberculeux de nos jours doit faire obligatoirement l'objet d'un counseling en vue du test de dépistage VIH, même sans son consentement :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le dépistage VIH nécessite information et consentement ; la co-infection ne justifie pas un test imposé.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 30 — Une contamination par le BK peut avoir pour origine(s) :

A. Le sol des étables

B. L'eau de boisson

C. L'expectoration d'un tuberculeux pulmonaire

D. Les urines d'un tuberculeux pulmonaire

Réponse : C

Explication : Les aérosols émis par un malade atteint de tuberculose pulmonaire contagieuse transmettent le bacille.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 31 — Lors de la dissémination de la tuberculose par les voies bronchiques, les signes cliniques sont les suivants, sauf un. Lequel ?

A. Toux

B. Hémoptysie

C. Douleur thoracique et dyspnée

D. Fièvre vespérale

E. Hypersthénie

Réponse : E

Explication : L'asthénie, et non l'hypersthénie, accompagne habituellement la tuberculose.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 32 — Les personnes à risques de la tuberculose sont :

A. Les sujets nés en zone endémique

B. Les sujets vivants dans le luxe

C. Les patients porteurs d'une immunodépression (VIH)

Réponse : A, C

Explication : La provenance d'une zone de forte incidence et l'immunodépression sont des facteurs de risque.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 33 — La stratégie DOTS recommandée par l'OMS dans la lutte antituberculeuse consiste à:

A. Une chimiothérapie sous observance directe

B. Une chimiothérapie sous observance indirecte

C. Une chimiothérapie sans observance directe

Réponse : A

Explication : Le DOTS comprend un traitement de courte durée avec soutien de l’observance, historiquement sous observation directe.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 34 — La proportion exacte des décès de PVVIH attribuables à la tuberculose en Afrique subsaharienne peut-elle être déterminée sans année ni population de référence ?

A. Oui : toujours la moitié.

B. Oui : toujours le tiers.

C. Oui : toujours le quart.

D. Non : il faut des données datées et une population définie.

Réponse : D

Explication : Une proportion de décès exige une année, une population et une source ; aucune fraction universelle ne peut être retenue.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 35 — Le sujet est immunocompétent si l'IDR est :

A. inférieure à 5 mm

B. inférieure à 10 mm

C. supérieure à 10 mm

D. L’IDR ne mesure pas à elle seule l’immunocompétence générale.

Réponse : D

Explication : Aucun seuil d’IDR ne permet à lui seul de déclarer un sujet immunocompétent.

Source : CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

Question 36 — Des facteurs favorisant la survenue de la tuberculose pulmonaire suivants, un est autrui. Lequel ?

A. La promiscuité et l’habitat insalubre

B. L’absence de vaccination par le BCG

C. Le terrain allergique

D. Le mauvais état nutritionnel

E. Le bas niveau socio-économique

Réponse : C

Explication : Le terrain allergique n’est pas un facteur classique de tuberculose ; le BCG protège surtout des formes graves de l’enfant.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 37 — Quelle proposition décrit correctement la prise en charge de la tuberculose extrapulmonaire ?

A. Une corticothérapie systématique

B. Un drainage radioguidé systématique si inoculum important

C. Un drainage chirurgical systématique si inoculum important

D. Une durée parfois prolongée selon la localisation, notamment neuroméningée.

E. Un isolement protecteur de la transmission aéroportée

Réponse : D

Explication : Certaines localisations, notamment neuroméningées ou ostéoarticulaires, nécessitent un traitement prolongé ; les gestes et corticoïdes ne sont pas systématiques.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 38 — La tuberculose maladie est dépistée par :

A. Un test sanguin IGRA

B. Une IDR

C. La présence de BAAR

D. Un PET scan avec une fixation métabolique importante (SUV > 25)

E. La présence de granulome(s) avec nécrose

Réponse : C, E

Explication : La bactériologie et une histologie évocatrice étayent le diagnostic ; BAAR et granulome ne sont pas absolument spécifiques.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 39 — La tuberculose latente est

A. Dépistée par un test sanguin IGRA

B. Dépistée par une IDR

C. Confirmée par la présence de BAAR

D. Dépistée systématiquement avant l’administration de biothérapie

E. La présence de granulome avec nécrose

Réponse : A, B, D

Explication : IDR et IGRA recherchent l’infection ; le dépistage est particulièrement important avant certains traitements biologiques immunosuppresseurs.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 40 — L'infection tuberculeuse latente :

A. Est une forme clinique contagieuse

B. Se caractérise par des cultures positives des prélèvements

C. S'accompagne d'une IDR à la tuberculine et de tests IGRA positifs

D. Se caractérise par un titre élevé d’anticorps dirigés contre Mycobacterium tuberculosis

E. Evolue dans 90% des cas vers une maladie tuberculeuse

Réponse : C

Explication : L’infection latente est asymptomatique et non contagieuse ; IDR ou IGRA peuvent être positifs, sans progression inéluctable.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 41 — En cas de suspicion de tuberculose pulmonaire quels sont les analyses bactériologiques à prescrire en priorité :

A. Un examen cytobactériologique des crachats en spécifiant « recherche de mycobactéries »

B. Trois examens cytobactériologiques des crachats en spécifiant (recherche de mycobactéries)

C. Une hémoculture standard systématique à la place du prélèvement respiratoire.

D. Un test moléculaire rapide validé sur les crachats, complété selon le contexte par culture et recherche de résistance.

E. Une hémoculture en spécifiant la recherche de mycobactéries car la tuberculose pulmonaire s'accompagne régulièrement d'une bactériémie

Réponse : D

Explication : Le test moléculaire rapide sur prélèvement respiratoire est prioritaire ; il ne doit pas être présenté comme toujours plus sensible que la culture.

Source : OMS, Tuberculosis, fiche du 24 mars 2026.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

Question 42 — Parmi les affirmations suivantes concernant Mycobacterium tuberculosis, laquelle est fausse ?

A. C'est un pathogène strict

B. C'est une bactérie dont le réservoir est hydrique

C. C'est une bactérie à transmission strictement interhumaine

D. La structure de sa paroi lui confère une résistance naturelle à de nombreux antibiotiques

E. C'est une bactérie à croissance lente

Réponse : B

Explication : Le réservoir de M. tuberculosis est principalement humain, non hydrique.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 43 — Le mode de transmission du bacille tuberculeux se produit

A. Par contact avec des surfaces contaminées par du bacille tuberculeux

B. Au cours de rapports sexuels

C. De personne à personne par l'air

D. Par piqûre d'insecte

E. Par transfusion

Réponse : C

Explication : La transmission habituelle se fait par inhalation de particules infectieuses en suspension dans l'air.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 44 — Le risque de transmission du bacille tuberculeux est d'autant plus élevé en cas de :

A. BAAR visibles à l'examen microscopique des produits d'expectoration

B. Méningite tuberculeuse

C. Proximité et longue exposition avec la source de contamination

D. TB pulmonaire non excavée

E. Retard dans l'instauration du traitement antituberculeux du malade contagieux

Réponse : A, C, E

Explication : Forte charge bacillaire, proximité prolongée et retard thérapeutique augmentent la transmission.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 45 — La tuberculose est une maladie :

A. A germe bactérien

B. A germe viral

C. A déclaration obligatoire

D. A déclaration obligatoire facultative

E. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, C

Explication : La tuberculose est bactérienne et soumise à notification sanitaire.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 46 — Le diagnostic de la tuberculose extra-pulmonaire se base sur :

A. Les signes cliniques

B. L'examen bactériologique des expectorations

C. La radiologie pulmonaire

D. Le test tuberculinique

E. L'analyse microbiologique ou histologique d'un prélèvement du site atteint.

Réponse : A, E

Explication : Le diagnostic dépend de la localisation et repose sur un prélèvement du site atteint, avec biologie moléculaire, culture ou histologie.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 47 — Le diagnostic de la tuberculose est évoqué devant :

A. Une asthénie

B. Un amaigrissement

C. Une forte épistaxis

D. Une toux persistante

Réponse : A, B, D

Explication : Asthénie, amaigrissement et toux persistante sont évocateurs.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 48 — La vaccination contre la tuberculose est faite :

A. Dans les 24 heures qui suivent la naissance

B. Durant le premier mois qui suit la naissance

C. Au troisième mois

D. Au 9ème mois

Réponse : A

Explication : En Côte d'Ivoire, le BCG se propose dès la naissance ; un rattrapage suit les règles du PEV.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 49 — Le diagnostic de certitude de la tuberculose repose sur :

A. La radiographie pulmonaire

B. La bronchoscopie pulmonaire

C. L’examen bactériologique des crachats

D. L’IRM pulmonaire

E. L’IDR à la tuberculine

Réponse : C

Explication : La confirmation est bactériologique, notamment moléculaire ou par culture ; la radiographie seule ne suffit pas.

Source : OMS, Tuberculosis, fiche du 24 mars 2026.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

Question 50 — Le vaccin contre la tuberculose se compose de :

A. Germes vivants atténués

B. Germes inactivés entiers

C. Polysaccharides

D. Protéines

Réponse : A

Explication : Le BCG est un vaccin vivant atténué dérivé de M. bovis.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 51 — Vous veillez à la qualité des soins et à la sécurité des utilisateurs du service de SMI, dites comment vous conservez le vaccin B.C.G :

A. Au réfrigérateur entre +2 et +8 °C, à l’abri de la lumière.

B. Au réfrigérateur entre 0 et +12°

C. Au congélateur à -20°

D. Au réfrigérateur entre 0 et +18°

E. Au congélateur à -5°

Réponse : A

Explication : La conservation au niveau du service se fait entre +2 et +8 °C, à l’abri de la lumière ; respecter aussi les règles après reconstitution.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 52 — Au retour d’un tuberculeux après interruption du traitement, les éléments à évaluer sont :

A. Son état d’immunité

B. Le degré de rémission de la maladie au cours du traitement précédent

C. L’état de conscience du patient

D. La sensibilité du bacille aux médicaments

Réponse : A, B, D

Explication : Il faut réévaluer le terrain, l’histoire du traitement et les résistances ; l’examen clinique complet reste nécessaire.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 53 — Au retour d’un tuberculeux après l’abandon du traitement, un des gestes suivants est à éviter. Lequel ?

A. Faire 3 frottis d’expectoration

B. Renouveler le traitement immédiatement

C. Résoudre si possible, le problème qui a causé l'interruption

D. Ne pas donner de traitement en attendant les résultats

Réponse : B

Explication : Éviter de reprendre aveuglément le même schéma ; réévaluer rapidement le patient et rechercher une résistance.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

Étude de cas clinique 1 Mr P (25 ans) est embauché en tant qu'infirmier dans un centre hospitalier. Sa visite médicale révèle une IDR à la tuberculine positive (10 mm d'induration) et un test IGRA négatif. Mr P ne se plaint de rien, son auscultation est normale et n'a aucun antécédent. La radiographie pulmonaire systématique, réalisée par la médecine du travail, est normale.

Question 54 — Mr P a-t-il une tuberculose ?

A. Oui, car son IDR est positive

B. Non, il a une infection latente tuberculeuse car son IDR est positive

C. Aucun argument de maladie active n'est établi ; une réaction liée au BCG est possible mais non prouvée par ces seuls tests.

D. Oui, car son IGRA est négatif

Réponse : C

Explication : En l'absence d'argument de maladie active, une réaction liée au BCG est possible ; l'IDR positive et l'IGRA négatif ne permettent toutefois pas de l'affirmer seuls.

Source : CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

Question 55 — Le rôle de l'infirmier dans le traitement de la tuberculose est :

A. Dispensation supervisée anti tuberculeux (DOTS)

B. Surveillance des constantes (T°, Poids, FR)

C. Notification des effets secondaires au médecin

D. Education thérapeutique

E. Contrôles bactériologiques aux échéances du protocole national applicable.

F. Toutes réponses sont justes

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Le suivi comprend médicaments, surveillance, éducation et contrôles bactériologiques selon le protocole national applicable.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 56 — Le rôle de l'infirmier dans la prévention de la tuberculose est le suivant sauf un. Lequel ?

A. CCSC du malade pour respect des mesures d'hygiène

B. Mise en place des mesures préventives en salle d'hospitalisation (port de masque, friction SAH…)

C. Information accompagnant ou gardien du malade

D. Pose du diagnostic pour le malade

Réponse : D

Explication : Le diagnostic médical ne se confond pas avec les actions infirmières de prévention et d’éducation.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 57 — La vaccination par le BCG est contre-indiquée en cas de :

A. Diabète

B. Eczéma en période suivante

C. SIDA maladie

D. Réaction cutanée tuberculinique positive

Réponse : C

Explication : Le BCG vivant est contre-indiqué en cas d’immunodéficience importante ; les situations de VIH exigent les critères nationaux.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 58 — Le taux de perte tolérée pour le vaccin BCG est estimé à :

A. Un taux inférieur à 50%

B. Un taux inférieur à 25%

C. Un taux inférieur à 20%

D. Un taux inférieur à 10%

E. La cible exacte doit être vérifiée dans le référentiel PEV daté et selon le conditionnement.

Réponse : E

Explication : Un taux de perte cible dépend du conditionnement et des normes du programme ; aucune valeur universelle ne doit être inventée.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

Étude de cas clinique 2 M. Tango est un patient tuberculeux. Il est hospitalisé dans une chambre seule avec la porte toujours fermée. Il sort très peu. Et reçoit son épouse et ses enfants régulièrement. M. Tango va recevoir une intradermoréaction.

Question 59 — Quelle précaution doit observer M. Tango avant de sortir de la chambre : les réponses exactes est requise)

A. Porter un masque englobant le nez et la bouche

B. Se laver les mains en sortant de la chambre

C. Porter des vêtements de protection

Réponse : A

Explication : Le patient contagieux porte un masque médical lors des déplacements ; les soignants portent une protection respiratoire adaptée.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 60 — Parmi les mesures suivantes, indiquer celle qui concerne le personnel de soins :

A. Limiter les déplacements

B. Mettre des affichettes sur la porte du patient

C. Eviter les examens à risque comme la fibroscopie bronchique

Réponse : B

Explication : La signalisation des précautions fait partie des mesures organisationnelles ; les examens nécessaires ne sont pas interdits par principe.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 61 — Le matériel nécessaire au recueil des crachats pour l'examen cytobactériologique est constitué des éléments suivants sauf un, lequel ?

A. Un pot stérile à usage unique

B. Les gants à usage unique

C. Une seringue à usage unique

D. Des bavettes à usage unique

Réponse : C

Explication : Une seringue n'est pas nécessaire au recueil spontané des expectorations ; le personnel doit disposer d'une protection respiratoire adaptée.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 62 — Le prélèvement gastrique pour recherche de tuberculose recueille les sécrétions bronchiques dégluties. Dans quelles conditions le réalise-t-on ?

A. Être à jeun pendant 24 h

B. Après le jeûne nocturne, tôt le matin, avant le lever, selon le protocole.

C. Se lever de bonne heure pour la réalisation du prélèvement

D. Être prévenu très tôt le matin

Réponse : B

Explication : Le prélèvement gastrique est réalisé tôt, à jeun après la nuit et avant le lever ; un jeûne de 24 heures n'est pas requis.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 63 — La seringue pour l'injection de l'intradermoréaction est spécifique et a une contenance de :

A. 0,1 ml

B. 1 ml

C. 2 ml

Réponse : B

Explication : Une seringue à tuberculine de 1 ml permet de mesurer précisément le volume injecté.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 64 — La seringue pour l'injection de l'intradermoréaction est graduée en

A. 100ème de ml

B. 10ème de ml

C. 1000ème de ml

Réponse : A

Explication : La graduation au centième de millilitre permet de mesurer 0,1 ml.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 65 — Quel aspect immédiat témoigne d'une injection intradermique correcte de tuberculine ?

A. Distension des pores de la peau produisant une papille à type de peau de lézard

B. Distension des pores de la peau produisant une papille à type de peau d'orange

C. Induration de la peau au point d'injection

Réponse : B

Explication : La papule en peau d'orange témoigne de l'injection intradermique ; la dose reste mesurée par la seringue.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 66 — Quelles sont les utilisations actuelles pertinentes des tests tuberculiniques ?

A. Dépister l'infection tuberculeuse

B. Sélectionner les sujets à vacciner

C. Recueillir des données épidémiologiques sur la tuberculose

D. Contrôler la réaction des sujets vaccinés

E. Déclarer la maladie

F. Faire la prévention

Réponse : A, C

Explication : Les tests recherchent une infection et peuvent contribuer à des études ; ils ne contrôlent pas la protection conférée par le BCG.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, tuberculose, immunologie et vaccination ; justification non localisée dans les cours consultés.

Insuffisance respiratoire et oxygénothérapie

Question 67 — Parmi ces signes, lequel évoque le plus directement une hypoxémie dans une insuffisance respiratoire aiguë ?

A. la douleur thoracique

B. les marbrures

C. une somnolence

D. la cyanose

E. un flapping tremor

Réponse : D

Explication : Parmi ces signes, la cyanose évoque une hypoxémie ; la définition repose surtout sur les échanges gazeux et la gazométrie.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 68 — Une ventilation alvéolaire insuffisante correspond à :

A. D'une hyperventilation

B. D'une atteinte du système nerveux

C. D'une hypoventilation

D. D'une perturbation de la circulation à l'intérieur des poumons

Réponse : C

Explication : Une ventilation alvéolaire insuffisante peut entraîner hypoxémie et hypercapnie.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 69 — Tout ce qui entrave de façon importante les échanges gazeux entre l'air et le sang provoque une insuffisance respiratoire. Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui est un problème de soins actuel chez un tel malade :

A. Intolérance au sevrage de la ventilation assistée

B. Risque d'altération de la fonction respiratoire

C. Mode de respiration inefficace

Réponse : C

Explication : Le mode respiratoire inefficace décrit un problème actuel, contrairement à un simple risque.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

Étude de cas clinique 3 Un homme de 55 ans, hypertendu, est adressé aux urgences pour une difficulté respiratoire intense. Son histoire a commencé 15 heures auparavant par une douleur thoracique latérale gauche, rapidement suivie de frissons, de toux, puis d'une sensation d'essoufflement de repos qui va en s'aggravant. Il a très mal dormi, avec une fièvre à 39°C malgré une prise d'aspirine. A l'examen, on constate une fréquence respiratoire à 45 par minute, une cyanose intense. Sa température est à 40°C. Le patient a du mal à répondre aux questions, il est confus et somnolent. A l'auscultation pulmonaire, le médecin note des râles crépitants dans les deux champs pulmonaires et un souffle tubaire à gauche.

Question 70 — Parmi les propositions suivantes, laquelle indique surtout le syndrome infectieux plutôt qu'un critère direct de défaillance respiratoire ou circulatoire ?

A. Polypnée à 45/min

B. Cyanose intense

C. Atteinte neurologique

D. Température à 40°C

E. Hypotension à 95/60 mm Hg

F. Bradycardie

Réponse : D

Explication : La fièvre élevée oriente vers la cause infectieuse ; polypnée, cyanose, troubles neurologiques, hypotension et bradycardie sont préoccupants.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 71 — Donner la définition exacte de la polypnée dans les propositions suivantes :

A. Augmentation de la ventilation minute

B. Diminution de la ventilation minute

C. Augmentation de la fréquence respiratoire, généralement supérieure à 20 cycles/minute chez l'adulte au repos.

D. Diminution de la fréquence respiratoire < 15 c/min

Réponse : C

Explication : Chez l'adulte, la tachypnée correspond généralement à une fréquence supérieure à 20/min ; 25/min est déjà anormal.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 72 — La pneumonie communautaire est une cause probable de cette insuffisance respiratoire aiguë. Quels arguments cliniques soutiennent cette hypothèse ?

A. Hypotension à 95/60 mm Hg chez un hypertendu, tachycardie à 140/min, atteinte neurologique

B. Début brutal, syndrome infectieux, douleur thoracique et toux, souffle tubaire et râles crépitants

C. Troubles de la conscience et flapping tremor, état de choc, retentissement viscéral majeur

Réponse : B

Explication : Fièvre, douleur thoracique, toux, souffle tubaire et crépitants orientent vers une pneumonie.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 73 — Les examens complémentaires simples que pourrait demander le médecin pour préciser la cause de ce tableau d'insuffisance respiratoire :

A. Hémocultures, examen des crachats

B. NFS et gazométrie

C. ECG ; radiographie du thorax

Réponse : A, B, C

Explication : Imagerie, gaz du sang, bilan inflammatoire et prélèvements microbiologiques peuvent être utiles, sans retarder la stabilisation.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 74 — Le contrôle gazométrique est utile avant la prescription d'oxygène pour :

A. Éviter d'assécher l'oropharynx et la glotte

B. Disposer d'un gaz du sang de référence

C. Ne pas irriter les fosses nasales

Réponse : B

Explication : La gazométrie donne une valeur initiale si réalisable ; elle ne doit jamais retarder l'oxygène en cas d'hypoxémie sévère.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 75 — Une privation complète d'oxygène dans les tissus est appelée :

A. Hypoxémie

B. Hypercapnie

C. Anoxie

D. Dyspnée

Réponse : C

Explication : L'anoxie est la privation d'oxygène tissulaire ; la diminution est appelée hypoxie.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 76 — Une expectoration est caractérisée par :

A. Sa consistance

B. Sa forme

C. Son origine

D. Sa topographie

Réponse : A

Explication : Les expectorations se décrivent notamment par quantité, consistance, couleur et odeur.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 77 — Tout ce qui entrave de façon importante les échanges gazeux entre l'air et le sang provoque une insuffisance respiratoire. Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui est un problème de soins actuel chez un tel malade :

A. Intolérance au sevrage de la ventilation assistée

B. Risque d'altération de la fonction respiratoire

C. Mode de respiration inefficace

Réponse : C

Explication : Il s'agit d'un problème respiratoire actuel, et non d'un simple risque.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 78 — L'hématose est la transformation normale du sang veineux chargé en CO2, en sang artériel riche en O2 :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'hématose associe oxygénation du sang et élimination du dioxyde de carbone.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 79 — L'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer son rôle d'hématose détermine une insuffisance respiratoire :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'insuffisance respiratoire correspond à une défaillance des échanges gazeux.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 80 — Les résultats de la gazométrie d'un malade indiquent que la transformation du sang veineux, chargé en CO2, en sang artériel riche en O2 se fait lentement, le médecin soupçonne dans ce cas une IRA :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une gazométrie ne décrit pas une transformation « lente » ; il faut interpréter PaO2, PaCO2 et pH avec le contexte.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 81 — Un patient insuffisant respiratoire devient inconscient, respire spontanément et vomit. En attendant la prise en charge des voies aériennes, la position latérale de sécurité est adaptée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La PLS convient à une personne inconsciente qui respire spontanément ; une personne consciente est positionnée selon sa tolérance respiratoire.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 82 — Mettre un malade en position demi-assise permet de faciliter l'expectoration :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La position demi-assise facilite habituellement la ventilation et l'expectoration si elle est tolérée.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 83 — Un malade insuffisant respiratoire reçoit de l'O2 de façon inconsidérée, il risque de convulser :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'oxygène non titré expose surtout à l'hyperoxie et parfois à l'hypercapnie ; les convulsions ne sont pas le risque habituel d'une oxygénothérapie normobare.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 84 — Un malade insuffisant respiratoire prend des AINS sans avis du médecin. L'examen que vous réalisez pour son suivi est le Taux de Prothrombine :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le TP n'est pas la surveillance spécifique des AINS ; on surveille notamment saignements digestifs et fonction rénale.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 85 — L'intérêt de l'examen qu'est la gazométrie est d'évaluer l'importance de l'insuffisance respiratoire :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les gaz du sang permettent d'apprécier hypoxémie, hypercapnie et équilibre acido-basique.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

Étude de cas clinique 3 Un homme de 55 ans, hypertendu, est adressé aux urgences pour une difficulté respiratoire intense. Son histoire a commencé 15 heures auparavant par une douleur thoracique latérale gauche, rapidement suivie de frissons, de toux, puis d'une sensation d'essoufflement de repos qui va en s'aggravant. Il a très mal dormi, avec une fièvre à 39°C malgré une prise d'aspirine. A l'examen, on constate une fréquence respiratoire à 45 par minute, une cyanose intense. Sa température est à 40°C. Le patient a du mal à répondre aux questions, il est confus et somnolent. A l'auscultation pulmonaire, le médecin note des râles crépitants dans les deux champs pulmonaires et un souffle tubaire à gauche.

Question 86 — Le patient est de plus en plus dyspnéique, puis devient inconscient. Le médecin décide d'un traitement par oxygène. L'oxygénothérapie consiste à enrichir en oxygène le mélange inhalé :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'oxygénothérapie augmente la fraction d'oxygène du mélange inspiré.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 87 — L'oxygène est prescrit toujours en continu, par l'intermédiaire que d'une sonde nasale :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le dispositif, le débit et la durée dépendent de la prescription et de l'objectif de saturation.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 88 — L'inconvénient de l'administration de l'oxygène par lunette est l'assèchement des fosses nasales :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une sécheresse nasale peut survenir sous lunettes à oxygène.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Œdème aigu du poumon et cardiologie

Situation clinique

Étude de cas clinique 4 Un homme de 35 ans se présente aux urgences médicales de l'Hôpital général d'Aboisso pour dyspnée. Il y a deux mois, se sont installés des œdèmes des membres inférieurs et une dyspnée survenant initialement à l'effort. Depuis quelques jours, le patient est asthénique. Au cours des 48 dernières heures il a eu deux épisodes de « voile noir devant les yeux ». La dyspnée est permanente depuis quelques heures, associée à une orthopnée et une sensation d'étouffement. À l'examen clinique sont retrouvés : sueurs, angoisse accusée, pouls irrégulier à 105/min, pression artérielle à 110/60 mm Hg, T° à 37 °C, œdèmes des membres inférieurs, déclives, blancs et indolores, turgescence spontanée des jugulaires. Fréquence respiratoire à 35/min, râles crépitants dans l'ensemble des champs pulmonaires, cyanose des extrémités. Il est sous oxygène par sonde nasale à 7 L/min. Le patient n'a pas d'autre antécédent notable. La radiographie du thorax montre une cardiomégalie avec hypertrophie ventriculaire gauche.

Question 89 — Quel est le diagnostic le plus probable ?

A. Œdème aigu pulmonaire

B. Asthme

C. Embolie pulmonaire

Réponse : A

Explication : Orthopnée, crépitants diffus et cardiomégalie évoquent un OAP cardiogénique, ici avec signes de congestion droite associés.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 90 — Quels éléments constituent des critères généraux de gravité d'un OAP, lorsqu'ils sont présents ?

A. Œdèmes des membres inférieurs, déclives, blancs et indolores, turgescence spontanée des jugulaires

B. Cyanose des extrémités, les troubles de la conscience, tachycardie, l'importance de l'hypoxémie, l'hypercapnie

C. Dyspnée à l'effort, permanente avec asthénie, présence sous oxygène

Réponse : B

Explication : Cyanose, hypoxémie et troubles neurologiques sont des critères de gravité ; plusieurs éléments de cette proposition ne sont pas mesurés dans le texte.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 91 — A l'accueil d'un cas d'œdème aigu du poumon, il faut veiller à :

A. L'installation du patient en chambre individualisée

B. L'installation du patient en position décubitus dorsal

C. L'installation du patient en position ½ assise, jambes pendantes

D. Surveillance des paramètres vitaux tous les ¼ d'heure puis toutes les ½ heure

Réponse : C, D

Explication : Installation demi-assise et surveillance rapprochée sont nécessaires ; les jambes pendantes dépendent de la tolérance hémodynamique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 92 — Quels examens peuvent être utiles dans le bilan d'un OAP selon le contexte ?

A. Radiographie thoracique

B. Numération Formule Sanguine

C. Examen cardiogramme (ECG)

D. Gaz du sang

Réponse : A, B, C, D

Explication : Ces quatre examens peuvent être utiles ; aucun n'est un intrus systématique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 93 — L'œdème aigu pulmonaire se manifeste

A. Par une détresse respiratoire aiguë

B. Par une insuffisance cardiaque gauche

C. Par la survenue à l'effort

D. Par un signe d’accompagnement comme l’hémoptysie

Réponse : A, D

Explication : Détresse respiratoire et expectoration rosée peuvent révéler l’OAP ; l’insuffisance gauche en est une cause, pas un symptôme.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 94 — Parmi les symptômes de l’œdème aigu du poumon, on note :

A. Une difficulté respiratoire grave et soudaine avec suffocation

B. Une orthopnée

C. Des expectorations spumeuses et rosées

D. Pouls faible et rapide

Réponse : A, B, C, D

Explication : Dyspnée aiguë, orthopnée, expectoration spumeuse et tachycardie sont possibles.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 95 — L’orthopnée

A. Survient à l’orthostatisme

B. Survient à l’effort

C. Survient en décubitus

D. Marque un signe d’insuffisance cardiaque

Réponse : C, D

Explication : L’orthopnée apparaît en position couchée et s’améliore en position assise ; elle oriente notamment vers l’insuffisance cardiaque.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 96 — Donnez la définition de palpitation

A. Il s’agit donc d’une perception anormale et déplaisante des battements cardiaques ressentis plus forts et/ou plus rapides.

B. Il s’agit donc d’une vision anormale et déplaisante des battements cardiaques ressentis plus forts et/ou plus rapides.

C. Il s’agit donc d’une déplaisance des battements cardiaques ressentis plus forts et/ou plus rapides.

Réponse : A

Explication : Les palpitations sont la perception anormale de ses propres battements cardiaques.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 97 — Après analyse et interprétation de vos données reçues de l’auxiliaire de soins infirmiers, vous vous rendez compte que certaines données manquent devant une symptomatologie de palpitations. Vous décidez de mener un interrogatoire. Cet interrogatoire permettra de préciser

A. Les antécédents personnels et familiaux du patient

B. Prise médicamenteuse

C. Les caractéristiques des palpitations

D. Facteurs déclenchants et les facteurs atténuants

E. Signes d’accompagnement

F. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : L’interrogatoire précise terrain, médicaments, caractéristiques, déclencheurs et signes associés.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 98 — Quels examens peuvent être utiles devant des palpitations, l’ECG étant prioritaire et les autres guidés par le contexte ?

A. L’ECG

B. L’échographie cardiaque

C. EEG

D. Radiographie pulmonaire

Réponse : A, B

Explication : L’ECG est indispensable ; l’échographie dépend du contexte. La radiographie n’est pas systématique pour des palpitations isolées.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 24–28, insuffisance cardiaque.

Question 99 — Parmi ces propositions concernant la physiopathologie de l’OAP, lesquelles sont vraies ?

A. L’OAP est une inondation des alvéoles pulmonaires

B. Il y a une augmentation de la pression dans l’oreillette droite

C. Il y a une dysfonction du ventricule gauche

D. Il y a une dysfonction du ventricule droit

E. Il y a une augmentation de la pression dans l’oreillette gauche

Réponse : A, C, E

Explication : L’OAP cardiogénique associe inondation alvéolaire et élévation des pressions gauches, souvent liée au ventricule gauche.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 24–28, insuffisance cardiaque.

Question 100 — Des facteurs favorisent la survenue d’un OAP suivants, un est autrui. Lequel ?

A. Une poussée d'HTA

B. Des erreurs diététiques

C. Une surinfection pulmonaire

D. Des troubles du rythme

E. Une hypercholestérolémie

Réponse : E

Explication : L’hypercholestérolémie est un facteur cardiovasculaire de fond, non un déclencheur aigu classique d’OAP.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 101 — Quelles sont les étiologies possibles de l’OAP ?

A. Insuffisance cardiaque gauche

B. Pneumothorax

C. Angor

D. Insuffisance cardiaque droite

E. Pneumopathie

Réponse : A, C, E

Explication : Insuffisance gauche, ischémie myocardique et pneumopathie peuvent provoquer ou déclencher un œdème pulmonaire selon le mécanisme.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 102 — Parmi ces signes, lequel n'est pas habituel dans un OAP et peut évoquer un épuisement respiratoire tardif ?

A. Une bradypnée

B. Une douleur thoracique

C. Une polypnée

D. Une expectoration mousseuse

E. Des râles crépitants

Réponse : A

Explication : La bradypnée n'est pas habituelle ; une douleur thoracique peut accompagner une cause ischémique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 103 — Parmi ces propositions concernant le traitement de l'OAP, lesquelles sont vraies ?

A. Les vasodilatateurs veineux permettent la diminution de la précharge

B. Le patient doit être allongé

C. Un antihypertenseur peut être utilisé

D. Les traitements médicamenteux permettent la réduction des pressions de remplissage du ventricule droit

E. Les diurétiques sont utilisés

Réponse : A, C, E

Explication : Diurétiques et vasodilatateurs réduisent la congestion selon la pression artérielle ; le décubitus strict aggrave souvent la dyspnée.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 104 — Parmi le rôle de l'infirmier en phase aiguë de l'OAP consiste à :

A. Mettre le patient en position demi-assise, jambes pendantes

B. Mettre le patient en position demi-assise, jambes surélevées

C. Surveiller la diurèse pour bilan d'entrée/sortie à l'aide d'une sonde à demeure

D. Mettre en route l'oxygénothérapie par sonde nasale sur prescription médicale

Réponse : A, C, D

Explication : Position adaptée, surveillance de la diurèse et oxygène si indiqué relèvent de la prise en charge ; le sondage n'est pas automatique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Question 105 — Un apport excessif de liquide par voie veineuse (perfusion) peut entraîner des dangers. Lesquels ?

A. Troubles électrolytiques

B. Œdème aigu pulmonaire

C. Trouble de conscience

D. Insuffisance rénale

Réponse : A, B, C

Explication : La surcharge peut entraîner œdème pulmonaire, désordres électrolytiques et retentissement neurologique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 24–28, insuffisance cardiaque.

Question 106 — Dans un épanchement pleural liquidien on peut observer,

A. Une hypersonorité

B. Une matité d'un hémithorax

C. Une abolition des vibrations vocales

D. Un souffle tubaire

E. Des râles crépitants en foyer unilatéral

Réponse : B, C

Explication : L'épanchement pleural liquidien donne typiquement matité et diminution des vibrations vocales.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 8–10, œdème aigu du poumon ; connaissances complémentaires pour les mesures de surveillance.

Asthme et sémiologie respiratoire

Question 107 — Indiquer les deux signes annonciateurs d'une crise d'asthme

A. Sensation de gêne respiratoire

B. Bruits à l'inspiration, sifflements + éternuements associés

C. Sensation de poitrine serrée liée à l'obstruction bronchique

D. Augmentation du débit expiratoire par rapport à l'état de base

Réponse : A, C

Explication : Gêne respiratoire et oppression thoracique sont évocatrices ; les sifflements sont surtout expiratoires.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l'appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 108 — Des composantes physiopathologiques suivantes trois sont de l'asthme. Lesquelles ?

A. Un œdème bronchique

B. Une hyposécrétion bronchique

C. Une diminution de l'hyperréactivité bronchique

D. Une hypersécrétion bronchique

E. Un bronchospasme

Réponse : A, D, E

Explication : Œdème, mucus et bronchospasme réduisent le calibre bronchique.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 109 — Quelles propositions ne décrivent pas habituellement l’obstruction bronchique d’une crise d’asthme ?

A. Une augmentation de la pression intrathoracique

B. Une réduction du calibre bronchique

C. Une augmentation du calibre bronchique

D. Une augmentation de l'hyperréactivité bronchique

E. Une diminution de la pression intrathoracique

Réponse : C, E

Explication : Une augmentation du calibre et une diminution de pression intrathoracique ne décrivent pas l’obstruction de la crise.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 110 — Un des éléments suivants est un intrus aux signes d’un patient en crise d’asthme. Lequel ?

A. Bradypnée

B. Oppression thoracique

C. Respiration sifflante

D. Toux

E. Dyspnée

Réponse : A

Explication : La crise entraîne habituellement une tachypnée ; une bradypnée peut signaler un épuisement tardif.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 111 — Quels sont les signes de gravité définissant un asthme aigu grave ?

A. Débit expiratoire de pointe > 150 l/min

B. Impossibilité de parler

C. Fréquence respiratoire < 30/min

D. Tachycardie > 120/min

E. Tirage inspiratoire

F. Toutes les réponses sont justes

Réponse : B, D, E

Explication : Impossibilité de parler, tachycardie et tirage sont graves ; le DEP doit être exprimé en pourcentage de la valeur attendue.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 112 — Lesquels des traitements sont pour l’asthme aigu grave ?

A. Oxygénothérapie

B. Nébulisations de bronchodilatateurs

C. Corticothérapie selon l'état du patient

D. β2 mimétiques IV systématiques en première intention avant les traitements inhalés

E. Du bromure d’ipratropium peut être associé au bronchodilatateur inhalé.

Réponse : A, B, C, E

Explication : Oxygène titré, bronchodilatateurs inhalés, corticoïdes systémiques et ipratropium constituent les mesures usuelles ; les bêta-2 IV ne sont pas de routine.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 113 — Parmi les propositions suivantes, deux signent l’asthme. Lesquelles ?

A. Une inflammation chronique des alvéoles pulmonaires

B. Une prévalence de 15% dans la population générale

C. La présence de symptômes à type de toux, de dyspnée et de sifflements paroxystiques et récidivants

D. Une épreuve fonctionnelle respiratoire toujours anormale, même en dehors des crises

E. Une hyperréactivité bronchique

Réponse : C, E

Explication : Symptômes variables récidivants et hyperréactivité bronchique caractérisent l’asthme.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 114 — Parmi les propositions suivantes, indiquez les trois signes de gravité à rechercher devant une exacerbation de l’asthme.

A. Agitation

B. Difficultés à la parole

C. Cyanose

D. Débit expiratoire de pointe supérieur à 30%

E. Fréquence cardiaque à 60 battements / minute

Réponse : A, B, C

Explication : Agitation, difficultés à parler et cyanose sont des signes de sévérité.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 115 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont pour le traitement de l’exacerbation d’asthme.

A. La prise de corticoïdes par voie systémique

B. L'utilisation d'antibiotiques

C. L'utilisation de β2 mimétiques de courte durée d'action par voie orale

D. L'utilisation de β2 mimétiques de courte durée d'action par voie inhalée

E. Peut nécessiter la mise sous oxygénothérapie

Réponse : A, D, E

Explication : Bronchodilatateurs inhalés, corticoïdes systémiques et oxygène si nécessaire ; pas d’antibiotique systématique.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 116 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles relèvent du rôle propre de l’infirmière devant une crise d’asthme.

A. Prendre la saturation en oxygène

B. Prendre la fréquence respiratoire

C. Installer le patient en position allongée

D. Mettre le patient sous oxygène

E. Appeler le médecin

Réponse : A, B, E

Explication : Évaluer SpO2 et fréquence respiratoire, alerter et installer demi-assis ; l’oxygène suit prescription ou protocole d’urgence.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 117 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ? Les signes de gravité d’une crise d’asthme sont :

A. Une fréquence respiratoire supérieure à 30 mouvements par minute

B. Une fréquence respiratoire égale à 20 mouvements par minute

C. Le patient réclame la position allongée

D. Une impossibilité de parler

E. Une toux grasse

Réponse : A, D

Explication : Tachypnée importante et impossibilité de parler constituent des signes de gravité.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 118 — Hors crise aiguë grave, quels objectifs peuvent relever de l’éducation ou de la rééducation respiratoire d’un asthmatique ?

A. Éliminer les sécrétions bloquées dans les bronches

B. D'apprendre à mieux maîtriser son souffle

C. Se détendre lors de l'apparition d'une gêne respiratoire

D. De gérer l'angoisse

E. D'augmenter la fréquence respiratoire

Réponse : B, C, D

Explication : L’éducation respiratoire et la relaxation peuvent aider hors urgence ; la kinésithérapie ne traite pas une crise aiguë grave.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 119 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des conseils de prévention pour éviter l’apparition d’une nouvelle crise d’asthme ?

A. Adapter son environnement sans allergène

B. Arrêter tout sport ou activités régulières

C. Éviter de sortir si pollution atmosphérique

D. Ne pas se faire vacciner contre la grippe

E. Arrêter son traitement devant l'amélioration de la symptomatologie

Réponse : A, C

Explication : Réduire les expositions déclenchantes et poursuivre le traitement de fond ; l’activité physique adaptée reste recommandée.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 120 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont pour un patient asthmatique :

A. Est forcément allergique

B. Peut avoir un trouble ventilatoire obstructif non réversible

C. A des symptômes de survenue paroxystique

D. A une hyperréactivité bronchique

E. Présente généralement un trouble ventilatoire obstructif réversible

Réponse : B, C, D, E

Explication : L’asthme n’est pas forcément allergique et peut évoluer vers une obstruction partiellement fixée.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 121 — Parmi les propositions suivantes du traitement de l’asthme, lesquelles sont vraies ?

A. L'éviction des allergènes possible

B. Les bronchoconstricteurs dans la crise d'asthme

C. L'antibiothérapie dans la crise d'asthme

D. La corticothérapie inhalée dans l'asthme persistant

E. Les bronchodilatateurs dans la crise d'asthme

Réponse : A, D, E

Explication : Éviction des déclencheurs, corticoïdes inhalés et bronchodilatateurs selon le plan thérapeutique.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 122 — Parmi les propositions suivantes relatives aux principaux signes de l’asthme aigu grave, lesquelles sont vraies ?

A. L'hypercapnie

B. L'hypocapnie

C. La cyanose

D. Le tirage sus-sternal

E. La bradypnée

Réponse : A, C, D, E

Explication : Hypercapnie et bradypnée évoquent l’épuisement ; cyanose et tirage sont également graves.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 123 — Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont du mécanisme contribuant à l’obstruction bronchique dans l’asthme.

A. L'hypersécrétion de mucus

B. L'œdème et l'inflammation de la muqueuse bronchique

C. Bronchospasmes et l'hyperréactivité

D. La vasodilatation des bronches

E. L'hyposécrétion de mucus

F. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, B, C

Explication : Mucus, inflammation et bronchospasme concourent à l’obstruction.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 124 — Les actions infirmières pour un patient asthmatique portent sur les propositions suivantes. Lesquelles sont vraies ?

A. L'adaptation du nombre de prises d'aérosol en fonction de l'état respiratoire

B. L’observance au traitement

C. Les effets secondaires aux thérapeutiques

D. Les exacerbations de crises

E. La température

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : L’infirmier surveille symptômes, observance et tolérance ; l’ajustement médicamenteux suit le plan prescrit.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 125 — Parmi les propositions suivantes concernant l’asthme, indiquez les les réponses exactes.

A. Il est caractérisé par une inflammation chronique des voies aériennes

B. Il est caractérisé par une oppression thoracique

C. Il est caractérisé par une hyperréactivité bronchique

D. Il est caractérisé par une hypotrophie musculaire

E. Il est caractérisé par une hyposécrétion des voies bronchiques

Réponse : A, B, C

Explication : Inflammation bronchique, oppression et hyperréactivité sont caractéristiques.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 126 — Sur quels éléments repose la prise en charge d’une crise d’asthme aiguë grave ?

A. La kinésithérapie respiratoire

B. L'administration de corticoïdes par voie générale

C. L'administration d'antibiotiques

D. Les aérosols de bronchodilatateurs

E. L'administration d'anticoagulants

Réponse : B, D

Explication : La crise grave nécessite bronchodilatateurs inhalés et corticoïdes systémiques, avec oxygène et réévaluation.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 127 — Les éléments de surveillance lors de l’oxygénothérapie reposent sur :

A. La coloration du faciès et des extrémités

B. La fréquence des symptômes atypiques

C. L’activité cardiaque

D. L’état du flacon barboteur et de la sonde

E. La gazométrie

F. La température

Réponse : A, C, D, E

Explication : Surveiller aussi SpO2, fréquence respiratoire et conscience ; l’humidification n’est pas systématique.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 128 — Quelle proposition donne la définition la plus complète de l’origine du sang rejeté lors d’une hémoptysie ?

A. De l’estomac

B. Des poumons et des bronches

C. Du carrefour aéro-digestif

D. Des bronches

Réponse : B

Explication : L’hémoptysie vient des voies respiratoires sous-glottiques ; la proposition D est incluse dans B.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 129 — Les crachats hémoptysiques sont les crachats rouges ou noirâtres parfois striés de sang qui ont la même valeur sémiologique que les hémoptysies de moyenne abondance s’il existe des signes d’anémie aiguë :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’aspect des crachats ne remplace pas l’évaluation de l’abondance et du retentissement respiratoire ou circulatoire.

Source : Connaissances complémentaires — pneumologie, sémiologie respiratoire et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Pathologies digestives

Question 130 — L’ulcère gastroduodénal (UGD) est une maladie chronique récidivante définie anatomiquement par un des critères suivants :

A. Perte de substance pariétale ne dépassant pas la sous-muqueuse

B. Perte de substance franchissant la musculaire muqueuse et atteignant au moins la sous-muqueuse.

C. Absence d’altération vasculaire

D. Siège préférentiel au niveau des zones de moindre épaisseur

Réponse : B

Explication : L’ulcère franchit la musculaire muqueuse et atteint au moins la sous-muqueuse ; il ne doit pas être confondu avec une simple érosion.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 131 — L’ulcère du tube digestif se localise au niveau :

A. Du duodénum

B. Du bulbe

C. De l’estomac

D. De l’appendice

Réponse : A, B, C

Explication : L’ulcère gastroduodénal siège dans l’estomac ou le duodénum, notamment dans le bulbe duodénal.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 132 — Les assertions exactes concernant l’ulcère gastrique sont :

A. Est associé généralement à une sécrétion acide élevée

B. Est favorisé par des altérations de la barrière muqueuse

C. Est principalement dû à Helicobacter pylori

D. Est plus nettement influencé par des facteurs psychoaffectifs que l’ulcère duodénal

Réponse : B, C

Explication : Altération des défenses muqueuses, H. pylori et AINS sont déterminants ; l’hypersécrétion n’est pas constante.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 133 — Trois des caractères suivants s’appliquent à la douleur d’un ulcère gastroduodénal. Lesquels ?

A. Elle est perçue comme une crampe

B. Elle est calmée par l’alimentation

C. Elle est volontiers nocturne

D. Elle est permanente pendant la journée

E. Elle est calmée par les antéflexions

Réponse : A, B, C

Explication : La douleur ulcéreuse typique est crampoïde, rythmée par les repas, parfois nocturne et calmée par l’alimentation.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 134 — Le diagnostic clinique d’un ulcère gastrique peut être rendu difficile par :

A. L’absence de tout symptôme

B. La fréquence des symptômes atypiques de type dyspepsie

C. La ressemblance avec une douleur pancréatique

D. La grande fréquence des complications révélatrices de l’affection

E. L’absence d’un syndrome ulcéreux typique

Réponse : A, B, E

Explication : L’ulcère gastrique peut être silencieux ou atypique ; la clinique seule ne suffit pas.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 135 — L’examen complémentaire de premier choix pour le diagnostic de l’ulcère gastroduodénal est :

A. L’échographie abdominale

B. La fibroscopie

C. Le transit baryté gastroduodénal

D. L’abdomen sans préparation

E. La tomodensitométrie

Réponse : B

Explication : L’endoscopie digestive haute visualise l’ulcère et permet des biopsies si nécessaire.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 136 — Parmi les facteurs étiologiques suivants, quels sont les deux qui apparaissent actuellement les plus importants concernant l’ulcère gastroduodénal :

A. L’hérédité

B. Le tabac

C. Le stress

D. La prise d’AINS ou d’acide salicylique

E. Infection à Helicobacter pylori

Réponse : D, E

Explication : Les principales causes sont H. pylori et les AINS, dont l’aspirine.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 137 — Les mesures hygiéno-diététiques à enseigner à une personne atteinte de l’ulcère gastroduodénal consistent à :

A. Arrêter le tabac et éviter l’alcool ainsi que les aliments déclenchant personnellement les symptômes.

B. Prendre les repas dans le calme et à heures régulières

C. Bien laver les mains avant chaque repas

D. Bien mâcher les aliments

E. Prendre assez d’épices au cours des repas

Réponse : A, B, C, D

Explication : Éviter tabac, alcool et irritants mal tolérés ; l’éradication d’H. pylori et les IPP restent fondamentaux.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 138 — L’hématémèse se définit comme :

A. Un rejet de sang rouge par voie anale

B. Un rejet de sang rouge par la bouche lors d’un effort de vomissement

C. Un rejet de sang provenant des bronches lors d’un effort de toux

D. Un rejet de sang noirâtre par voie anale

Réponse : B

Explication : L’hématémèse est un vomissement de sang rouge ou digéré provenant du tube digestif haut.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 139 — En présence d'une hématémèse grave par ulcère duodénal, l'importance de l'hémorragie sera au mieux appréciée par :

A. La quantité de sang rejetée

B. L'importance de la quantité de sang nécessaire pour rétablir et maintenir une tension correcte

C. L'agitation du sujet

D. La fréquence respiratoire

E. La soif

Réponse : B

Explication : Le retentissement hémodynamique et les besoins de réanimation sont plus fiables que le volume vomi seul.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 140 — Indiquez les gestes en urgence que vous poserez devant une hémorragie digestive :

A. Mise en place d'une voie veineuse de bon calibre

B. Détermination du groupe sanguin et du facteur rhésus

C. Correction d'une hypovolémie avec des macrolides

D. Surveillance du patient

E. Prévention des troubles de la déglutition

F. Identification du patient

Réponse : A, B, D, F

Explication : Alerte, voies veineuses, bilan prétransfusionnel et surveillance sont prioritaires ; les macrolides ne corrigent pas l'hypovolémie.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 141 — Le bilan biologique de l'hématémèse doit comporter les éléments suivants, sauf un. Lequel ?

A. Une numération formule sanguine

B. Un groupe sanguin

C. Une urée – créatinine

D. ASAT – ALAT

E. Un TCK – TP

Réponse : D

Explication : Les transaminases ne sont pas le marqueur prioritaire d'une hémorragie ulcéreuse, mais peuvent être utiles selon le terrain.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 142 — Un homme de 67 ans sans antécédent personnel ou familial est adressé en consultation de gastroentérologie par son médecin traitant pour rectorragies, faux besoins et ténesme. Parmi les examens complémentaires suivants, lesquels vous semblent adaptés à réaliser en première intention afin de permettre un diagnostic étiologique de certitude

A. Test Hémoculture

B. Rectoscopie

C. Coloscopie

D. IRM pelvienne

E. Manométrie ano-rectale

Réponse : B, C

Explication : L'endoscopie avec biopsies recherche une lésion colorectale ; un test de sang occulte n'est pas adapté à une rectorragie visible.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 143 — Indiquer parmi les propositions suivantes, un antécédent familial de gastroentérologie :

A. Immunodépressif depuis quelques années

B. Cancer du rectum découvert chez le grand-père

C. Paludisme détecté au cours de la consultation

Réponse : B

Explication : Un cancer rectal chez un ascendant est un antécédent familial digestif.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 144 — La fibroscopie digestive est un examen qui permet de diagnostiquer :

A. L’ulcère gastrique

B. L’ulcère duodénal

C. L’ulcère de l’œsophage

D. Une péritonite, sans examen de la cavité abdominale.

Réponse : A, B, C

Explication : La fibroscopie visualise œsophage, estomac et duodénum ; les varices sont des dilatations veineuses, non des ulcères.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 145 — Devant une diarrhée avec selles glaireuses et sanglantes le médecin suspecte une amibiase colique. Quels examens permettent de faire le diagnostic :

A. L’hémoculture

B. La coproculture des selles

C. L’examen parasitologique des selles

D. La sérologie de l’amibiase

Réponse : C

Explication : L’examen parasitologique est utile ; antigène ou PCR peuvent différencier E. histolytica d’espèces non pathogènes.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 146 — On parle d’une diarrhée persistante lorsqu’elle dure :

A. 7 jours et plus

B. 10 jours et plus

C. 14 jours et plus

D. 15 jours et plus

Réponse : C

Explication : Une diarrhée persistante dure au moins 14 jours.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 147 — Les paramètres qui doivent être surveillés dans les premières heures d'une réhydratation chez un patient présentant une déshydratation avec collapsus sont :

A. La modification du pli cutané

B. La fréquence des selles

C. La tension artérielle

D. La diurèse

Réponse : A, B, C, D

Explication : Surveiller réhydratation, pertes, pression artérielle et reprise de la diurèse, avec état de conscience et pouls.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 148 — Les précautions à prendre pour la conservation de l'eau javellisée

A. Mettre l'eau de javel dans un flacon opaque

B. Conserver systématiquement toute solution diluée pendant sept jours, quelles que soient les conditions.

C. Ne pas mélanger l'eau javellisée avec d'autres détergents

D. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, C

Explication : Conserver à l'abri de la lumière, sans mélange ; les solutions diluées sont préparées fraîches selon le protocole, souvent chaque jour.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 149 — Le traitement de première intention de la diarrhée du voyageur doit comporter :

A. Des antiseptiques intestinaux

B. Une hydratation

C. Un apport en glucose

D. Des antibiotiques

E. Un apport en sodium

Réponse : B, C, E

Explication : La réhydratation orale apporte eau, glucose et électrolytes ; antibiotiques réservés aux indications.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 150 — Le risque de dissémination des infections alimentaires peut être réduit par : les réponses exactes

A. L'hygiène des mains

B. La filtration systématique de l'eau de robinet

C. Le respect des règles de conservation des aliments

D. Le respect des règles de préparation des aliments

E. L'achat des fruits et légumes en grandes surfaces

Réponse : A, C, D

Explication : Hygiène des mains et sécurité de préparation et conservation réduisent le risque.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 151 — Quelle présentation peut évoquer une diarrhée fonctionnelle, après recherche des signes d'alarme ?

A. Diarrhée hypo-électrolytique indolore à prédominance matinale ou post-prandiale

B. Affection colique associée à une diarrhée chronique

C. Céphalées accompagnées de nausées et vomissements parfois

D. Notion de dysenterie post-prandiale précédée de constipation

Réponse : A

Explication : Une diarrhée fonctionnelle matinale ou postprandiale peut être révélatrice ; le côlon irritable exige aussi des douleurs abdominales récurrentes.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 152 — Laquelle des affections suivantes est une étiologie du reflux gastro-œsophagien

A. La gastrite

B. L'ulcère

C. La sclérodermie

D. La régurgitation

Réponse : C

Explication : La sclérodermie peut altérer la motricité et le sphincter inférieur de l'œsophage.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 153 — Le diagnostic du syndrome du côlon irritable est

A. Radiographique

B. Biologique

C. Radioscopique

D. Clinique

Réponse : D

Explication : Le diagnostic repose sur les symptômes et l'absence de signes d'alarme, avec examens ciblés si indiqués.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 154 — Le lavage gastrique permet de réduire :

A. La basicité du toxique absorbé

B. L'acidité du toxique absorbé

C. La qualité du toxique absorbé

D. La quantité du toxique absorbé

Réponse : D

Explication : Il vise à retirer une partie du toxique encore présent dans l'estomac ; il n'est presque jamais systématique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 155 — Le lavage gastrique est indiqué si le délai d'ingestion du toxique dure moins de :

A. Une heure, uniquement dans de rares intoxications graves après avis spécialisé.

B. 05 heures

C. 06 heures

D. 07 heures

Réponse : A

Explication : Le lavage gastrique n’est envisagé que dans de rares intoxications graves, habituellement dans l’heure, après avis spécialisé.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 156 — Dans quelle situation un lavage gastrique peut-il exceptionnellement être envisagé après avis spécialisé ?

A. Ingestion très récente d’une dose potentiellement mortelle d’un toxique non caustique, avec voies aériennes protégées si nécessaire.

B. Empoisonnement par substance caustique

C. Hémorragie digestive

D. Hémorragie gastrique

Réponse : A

Explication : L’absence de caustique ne suffit pas : gravité, délai, risque d’inhalation et protection des voies aériennes doivent être évalués.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 157 — L’aspiration digestive est indiquée dans le syndrome :

A. Ascitique

B. Dysentérique

C. Douloureux

D. Subocclusif

Réponse : D

Explication : Une décompression digestive peut être indiquée en cas d’occlusion ou de syndrome subocclusif.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 158 — La cholécystite aiguë est une inflammation de l’organe suivant :

A. La rate

B. La vésicule biliaire

C. Le pancréas

D. Le foie

Réponse : B

Explication : La cholécystite est une inflammation de la vésicule biliaire.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 159 — L’hémorragie digestive est un incident du lavage gastrique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un traumatisme muqueux peut entraîner un saignement lors d’un lavage gastrique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 160 — La gastrite est généralement traitée par la suppression de certains aliments irritants et des habitudes alimentaires :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Ces mesures contribuent au traitement, mais il faut aussi traiter la cause et recourir aux médicaments indiqués.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 66–69, gastrites.

Question 161 — Le pyrosis postural est une manifestation typique du reflux gastro-œsophagien :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le reflux peut être favorisé par le décubitus ou l’antéflexion.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 66–69, gastrites.

Question 162 — Les vomissements postprandiaux précoces révèlent la présence d’une sténose ulcéreuse :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La sténose pylorique donne plutôt des vomissements alimentaires tardifs de stase.

Source : Connaissances complémentaires de gastroentérologie, stase gastrique et sténose pylorique. La formulation « précoces » du cours Médecine L2 .pdf, p. 74, ne décrit pas le tableau typique de rétention.

Question 163 — La giardiase est une infection bactérienne de l'intestin grêle responsable d’une diarrhée :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Giardia est un protozoaire parasite, non une bactérie.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 164 — Dans une dysenterie bacillaire la transmission se fait de façon directe ou indirecte :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La transmission est féco-orale, directe ou via eau, mains et aliments contaminés.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 165 — LA DIARRHÉE AIGUË :

A. Est l'évacuation de plus de 4 selles liquides par jour depuis moins de deux semaines

B. Est habituellement bénigne et résolutive en moins de trois jours

C. Représente un motif de consultation moins fréquent en médecine générale

D. Peut être grave en cas de déshydratation importante et de terrains particuliers

E. Ne nécessite pas dans la majorité des cas la première intention de la prescription d'examens biologiques et du traitement anti-infectieux

Réponse : B, D, E

Explication : La définition usuelle est au moins trois selles molles ou liquides par jour pendant moins de 14 jours.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 166 — Au cours d'une diarrhée aiguë, dans le(s)quel(s) de ces cas la réalisation d'examens biologiques est-elle nécessaire ?

A. Diarrhée sous antibiotiques s'accompagnant de fièvre

B. Syndrome dysentérique

C. Fièvre inférieure à 38,5°C et vomissement

D. Déshydratation sévère

Réponse : A, B, D

Explication : Dysenterie, contexte antibiotique fébrile et déshydratation sévère justifient une exploration adaptée.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 167 — Le traitement de toute diarrhée aiguë doit comporter :

A. Des antiseptiques intestinaux

B. Une réhydratation

C. Des apports alimentaires importants en glucose / amidon

D. Des apports alimentaires en sodium

E. Des conseils d'hygiène

Réponse : B, D, E

Explication : Réhydratation, compensation des électrolytes et hygiène sont essentielles ; pas d'excès imposé de glucose.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 168 — Les signes de gravité d'une diarrhée sont :

A. L'hypertension artérielle

B. La déshydratation

C. La perte de poids

D. La fièvre

E. La soif intense

Réponse : B, C, D, E

Explication : La gravité dépend de la déshydratation, de sa rapidité, du terrain et d'une fièvre importante ou de signes invasifs.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 169 — Des complications suivantes une est autrui lors de vomissements aigus chez l'adulte :

A. Rupture de l'œsophage

B. Déchirure du bas œsophage (syndrome de Mallory-Weiss)

C. Insuffisance rénale

D. Dénutrition

E. Pneumopathie par inhalation

Réponse : D

Explication : La dénutrition concerne surtout les vomissements prolongés ; les autres complications peuvent être aiguës.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 170 — Hématémèse se définit comme :

A. Des selles avec du sang

B. Des vomissements de sang

C. Des crachats avec du sang

D. De la salive avec du sang

Réponse : B

Explication : L'hématémèse correspond à des vomissements sanglants.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 171 — Quel est le rôle du recueil du contenu gastrique dans une exploration digestive ?

A. Diagnostiquer à lui seul la cause d'une anémie

B. Remplacer l'endoscopie après une hémorragie digestive

C. Permettre l'analyse du liquide gastrique dans des indications sélectionnées

D. Visualiser directement les varices œsophagiennes

Réponse : C

Explication : Le tubage permet un prélèvement de contenu gastrique. Il ne visualise pas les lésions et ne remplace pas l'endoscopie ni les biopsies.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 172 — Pour la formulation du diagnostic infirmier par rapport à la constipation, la justification première est :

A. Le changement dans les habitudes d'élimination intestinale

B. La diminution intestinale de la fréquence des selles

C. L'émission de selles dures et sèches

Réponse : A

Explication : Le diagnostic tient compte d'un changement du transit, de la consistance et des difficultés d'exonération.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 173 — Quelle caractéristique est typique d’une dysphagie obstructive organique ?

A. Capricieuse

B. Permanente

C. Intermittente

D. Indolore

E. Mérycisme

F. Paradoxale

Réponse : B

Explication : Une dysphagie organique obstructive est typiquement progressive et d’abord prédominante sur les solides ; la douleur n’est pas un critère obligatoire.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 174 — Quelles sont les deux manifestations typiques du reflux gastro-œsophagien ?

A. Régurgitations acides.

B. Trachéite

C. Torsion

D. Sténose

E. Pharyngite

F. Pyrosis

Réponse : A, F

Explication : Les manifestations typiques sont pyrosis et régurgitations acides ; la brûlure épigastrique seule n’est pas équivalente au pyrosis.

Source : Connaissances complémentaires — gastroentérologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Ponction d’ascite

Question 175 — Quels sont les trois repères qui renseignent directement sur la pression artérielle et sur l’importance de l’ascite avant une ponction ?

A. La température

B. La tension artérielle

C. La fréquence respiratoire

D. Le périmètre ombilical

E. L’état de conscience

F. Le poids du patient

Réponse : B, D, F

Explication : Pression artérielle, poids et périmètre abdominal sont des repères utiles ; les autres constantes sont aussi évaluées selon le contexte.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 46–56, cirrhose et ascite ; connaissances complémentaires pour les gestes infirmiers.

Question 176 — La position du malade dans la ponction d’ascite est :

A. Décubitus latéral droit

B. Décubitus dorsal

C. Décubitus latéral gauche

D. Décubitus ventral

Réponse : B

Explication : La ponction se réalise habituellement en décubitus dorsal ou légèrement incliné, selon le site et le protocole.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 46–56, cirrhose et ascite ; connaissances complémentaires pour les gestes infirmiers.

Question 177 — Quel accident circulatoire peut compliquer une ponction évacuatrice d'ascite ?

A. Convulsion

B. Perte de connaissance

C. Déshydratation

D. Collapsus cardiovasculaire

Réponse : D

Explication : Une défaillance circulatoire peut compliquer une évacuation importante, notamment sans compensation adaptée.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 46–56, cirrhose et ascite ; connaissances complémentaires pour les gestes infirmiers.

Diabète et troubles métaboliques

Question 178 — Un homme de 67 ans diabétique consulte pour vomissements et douleurs abdominales intenses, l'examen est normal hormis une hernie inguinale droite connue depuis 3 ans et irréductible. Quelle sera votre action ?

A. Vous suspectez en premier lieu une acidocétose

B. Vous suspectez en premier lieu une hypoglycémie

C. Appeler un chirurgien pour hernie étranglée

D. Prescrire un jeûne et une perfusion

E. Surveiller la glycémie

Réponse : C, E

Explication : Une hernie irréductible avec douleurs et vomissements impose un avis chirurgical urgent ; contrôler aussi la glycémie.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 179 — Devant une hypoglycémie avec altération de la conscience, quelles solutions glucosées IV peuvent être utilisées selon le protocole et l'accès veineux ?

A. Resucrage per os

B. La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 30%

C. La perfusion en flash de sérum bicarbonaté à 14%

D. La perfusion de sérum glucosé hypertonique à 10%

Réponse : B, D

Explication : Ne rien donner par la bouche si conscience altérée ; glucose IV titré ou glucagon selon accès et protocole.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 180 — L’acidocétose diabétique survient principalement :

A. Chez les personnes diabétiques de type I

B. Chez les personnes diabétiques de type II

C. En cas de diabète gestationnel

D. Aucune réponse n’est juste

Réponse : A

Explication : L’acidocétose est surtout associée au type 1, mais peut aussi survenir dans le type 2.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 65–66, diabète et médicaments antidiabétiques.

Question 181 — L’acidocétose diabétique s’annonce par :

A. Une polypnée de Kussmaul

B. Un vomissement en jet

C. Un trouble de la conscience

D. Une sécheresse cutanéo-muqueuse

Réponse : A, C, D

Explication : Kussmaul, déshydratation et troubles neurologiques évoquent une acidocétose ; le vomissement en jet n’est pas spécifique.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 182 — Pour le suivi du diabète, les dosages suivants sont nécessaires :

A. Le dosage de la créatinine

B. Le dosage de la glycémie post-prandiale

C. Le dosage de la glycosurie

D. Le dosage de l’hémoglobine glyquée

E. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, B, D

Explication : HbA1c, glycémies et fonction rénale sont utiles ; la glycosurie ne suffit pas au suivi moderne.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 183 — Un diabétique conscient, capable d’avaler, présente une hypoglycémie confirmée ou fortement suspectée. Quelle action immédiate est adaptée ?

A. Donner du sucre

B. Injecter de l’insuline en sous-cutané

C. Donner des sulfamides hypoglycémiants

D. Injecter de l’insuline et donner des sulfamides hypoglycémiants

Réponse : A

Explication : Si l’hypoglycémie est suspectée et le patient conscient, contrôler rapidement et donner du sucre ; conscience altérée : voie parentérale.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 184 — Les complications aiguës du diabète sont :

A. Le coma hyperosmolaire

B. Le coma hypoglycémique

C. L’obésité

D. Le goitre

Réponse : A, B

Explication : Les décompensations hyperosmolaires et l’hypoglycémie sont aiguës ; ajouter l’acidocétose dans la révision.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 185 — Parmi les complications du diabète, on note :

A. Les rétinopathies

B. Les néphropathies

C. La phlébite

D. L’hypertension artérielle

Réponse : A, B

Explication : Rétinopathie et néphropathie sont des complications microvasculaires classiques ; l’HTA est souvent associée.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 186 — Les signes d’une hypoglycémie sont :

A. La moiteur des mains

B. Sueurs froides, pâleur du visage et des extrémités

C. Tremblement des extrémités

D. Tachycardie avec palpitations

Réponse : A, B, C, D

Explication : Les signes adrénergiques comprennent sueurs, pâleur, tremblements et palpitations.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 187 — Pour éviter les hypoglycémies, on conseille aux personnes diabétiques de :

A. Sauter des repas ou des collations

B. Avoir au moins 3 sucres et une collation à portée de main

C. Connaître les mesures à adopter lors d’une activité physique

D. Respecter les traitements prescrits, leurs dosages et leurs horaires

Réponse : B, C, D

Explication : Adapter alimentation, activité et traitement et disposer d’un resucrage rapide.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 188 — La réalisation de la glycémie capillaire

A. Correspond au taux de glucose pris par dextro

B. Sert dans la surveillance du diabétique

C. Donne le taux exact du glucose dans le sang

D. Sert à dépister un trouble biologique

Réponse : A, B, D

Explication : La glycémie capillaire est une estimation utile au dépistage et à la surveillance ; sa précision dépend du matériel et des conditions.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 189 — Quels sont les trois tableaux classiques de coma associés au diabète ou à son traitement ?

A. Le coma acido-cétosique

B. Le coma par acidose lactique

C. Le coma hyperosmolaire

D. Le coma hypoglycémique

Réponse : A, C, D

Explication : Acidocétose, état hyperosmolaire et hypoglycémie sont les trois tableaux classiques ; une acidose lactique est aussi possible dans certains contextes.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 190 — Quelle proposition concernant l'acidocétose diabétique est fausse ?

A. Une urgence médicale

B. Une décompensation exclusivement observée dans le diabète de type II.

C. Marquée par une hyperglycémie

D. Marquée par une cétonémie

Réponse : B

Explication : L'acidocétose n'est pas propre au type 2 ; elle peut toucher les deux types, surtout le type 1.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 191 — Parmi les signes cliniques de l'acidocétose diabétique, on note :

A. Une dyspnée acidosique de Kussmaul avec une mauvaise haleine

B. Une déshydratation importante

C. L'obnubilation de la conscience avec signes de pré-coma

D. L'hyperthermie

Réponse : A, B, C

Explication : Kussmaul, déshydratation et altération de conscience sont possibles ; une fièvre évoque notamment un facteur infectieux.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 192 — L'insuline est une hormone sécrétée par :

A. Le foie

B. La rate

C. Le pancréas exocrine

D. Le pancréas endocrine

Réponse : D

Explication : L'insuline est sécrétée par les cellules bêta des îlots pancréatiques.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 65–66, diabète et médicaments antidiabétiques.

Question 193 — Devant le diabète insipide, l’infirmier doit surveiller :

A. Le dosage de la T3, de la T4 et la TSH

B. La présence des symptômes d’un ralentissement physique et psychique

C. L’augmentation de la néoglucogenèse hépatique

D. La polyurie, la soif, la polydipsie, la température, l’agitation, l’angoisse, liés à la déshydratation

Réponse : D

Explication : Le diabète insipide entraîne des pertes d’eau importantes et un risque de déshydratation.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 194 — Dans le diabète insipide il est noté :

A. Une polyphagie et une polyurie

B. Une polydipsie et une polyphagie

C. Une polyphagie, une polydipsie et une polyurie

D. Une polyurie et une polydipsie

Réponse : D

Explication : Il associe principalement polyurie et polydipsie, sans hyperglycémie nécessaire.

Source : Connaissances complémentaires — diabétologie et physiologie endocrinienne ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 195 — Les principaux conseils à donner à un adulte diabétique non insulinodépendant consistent à :

A. Pratiquer le sport régulièrement

B. Éviter les sucreries

C. Suivre régulièrement le traitement

D. Adopter une alimentation riche en glucides

E. Éviter la torpeur

Réponse : A, B, C

Explication : Activité adaptée, alimentation équilibrée et observance sont essentielles ; éviter une restriction glucidique excessive ou un régime riche en sucres libres.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 65–66, diabète et médicaments antidiabétiques.

Trachéotomie

Question 196 — La trachéotomie est une

A. Incision chirurgicale de la trachée temporaire

B. Incision chirurgicale de la trachée définitive

C. Incision chirurgicale de la trachée temporaire ou définitive

D. Nécessite le port permanent d’une canule en double jeu

Réponse : C

Explication : La trachéotomie crée un abord de la trachée ; sa durée dépend de l’indication et ne se confond pas avec une trachéostomie après laryngectomie.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 197 — Les indications de la trachéotomie transitoire sont :

A. Ventilation artificielle prolongée

B. Insuffisance respiratoire chronique évoluée, surtout de type restrictif

C. Difficultés de sevrage de la ventilation mécanique

D. Obstacle laryngé, troubles de déglutition avec inhalation

Réponse : A, C, D

Explication : Ventilation prolongée, échec de sevrage et obstruction haute peuvent nécessiter un abord temporaire.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 198 — Les indications de la trachéotomie définitive sont :

A. Traumatisme facial

B. Anomalies définitives du carrefour oro-pharyngé avec troubles de déglutition

C. Maladies neuromusculaires

D. Insuffisance respiratoire chronique évoluée, surtout de type restrictif

Réponse : B, C, D

Explication : Des anomalies persistantes ou maladies évoluées peuvent conduire à une trachéotomie de longue durée, après évaluation spécialisée.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 199 — Les soins locaux d’une trachéotomie

A. Nécessitent un lavage chirurgical des mains pendant les premières 48h

B. Se font à la demande du patient

C. Nécessitent un lavage antiseptique après les premières 48h

D. Se font 1 à 2 fois par jour

Réponse : D

Explication : Soins réguliers et à la demande selon souillure ; l’hygiène des mains et l’asepsie ne reposent pas sur un seuil de 48 heures.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 200 — Parmi les risques d’une trachéotomie, on note :

A. Décanulation accidentelle

B. Vomissement

C. Obstruction de la canule par un bouchon muqueux

D. Fausses routes par inhalation

E. Somnolence

F. Lésion de la trachée

Réponse : A, C, D, F

Explication : Décanulation, obstruction, inhalation et lésions trachéales sont des complications possibles.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 201 — En cas de trachéotomie, le changement de la canule interne se fait :

A. Quotidiennement

B. 2 fois par jour

C. Aussi souvent que nécessaire

D. En cas de sécrétions abondantes

Réponse : C, D

Explication : L'entretien ou le remplacement de la chemise interne suit les sécrétions, le modèle et le protocole.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 202 — Les objectifs de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A. La libération des voies aériennes pour améliorer la ventilation

B. La prévention de la formation d'un bouchon muqueux

C. La régulation des paramètres

D. La prévention d'une pneumopathie d'inhalation

Réponse : A, B

Explication : L'aspiration retire les sécrétions et prévient l'obstruction ; elle ne prévient pas à elle seule toute fausse route.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 203 — Les complications de l'aspiration trachéo-bronchique sont :

A. La désaturation

B. Les lésions traumatiques

C. La douleur

D. L'arrêt cardiaque

Réponse : A, B, C, D

Explication : Hypoxémie, traumatisme, douleur et stimulation vagale avec bradycardie voire arrêt sont possibles.

Source : Connaissances complémentaires — soins de trachéotomie ; justification non localisée dans les cours consultés.

Infections et études cliniques

Question 204 — Dans toutes les maladies infectieuses, l'homme malade est l'unique réservoir de germes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les réservoirs peuvent être humains, animaux ou environnementaux ; la maladie doit être précisée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 205 — La phase d'état de la bilharziose à Schistosoma mansoni est dominée par les manifestations intestinales et hépatospléniques :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : S. mansoni provoque une schistosomiase intestinale et parfois hépatosplénique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 206 — Les tréponématoses sont un groupe d'affections parasitaires causées par des tréponèmes :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les tréponèmes sont des bactéries spirochètes, non des parasites au sens du cours de parasitologie.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 207 — La syphilis secondaire est très contagieuse :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les lésions de la syphilis secondaire contiennent de nombreux tréponèmes et sont contagieuses.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 208 — La rage humaine se transmet habituellement d’une personne à une autre lors des contacts sociaux ordinaires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La rage est une zoonose transmissible ; la transmission interhumaine habituelle n’est pas observée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 209 — Toute amibiase intestinale se manifeste obligatoirement par une dysenterie amibienne.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La dysenterie amibienne est une forme symptomatique de l’amibiase ; toute amibiase intestinale n’est pas dysentérique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 210 — Les bilharzioses sont des affections parasitaires dues à des vers plats, appelés bilharzies ou schistosomes :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les schistosomes sont des trématodes, vers plats parasites.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 211 — La syphilis secondaire est très contagieuse :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La syphilis secondaire est très contagieuse.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 212 — La rage humaine se transmet habituellement d’une personne à une autre lors des contacts sociaux ordinaires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La transmission se fait surtout par la salive d’un animal infecté ; pas par les contacts sociaux usuels.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 213 — Toute amibiase intestinale se manifeste obligatoirement par une dysenterie amibienne.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’amibiase peut être asymptomatique ou non dysentérique ; les deux termes ne sont pas strictement synonymes.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 214 — Les médicaments sont l’une des causes fréquentes d’hépatite aiguë :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une hépatite peut être médicamenteuse, toxique, virale ou d’une autre cause.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 215 — La syphilis secondaire est le stade de l'invasion et de la dissémination du tréponème :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le stade secondaire correspond à une dissémination systémique du tréponème.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 216 — La syphilis peut se compliquer d’atteintes cardiovasculaires et neurologiques.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La syphilis peut atteindre cœur, vaisseaux et système nerveux ; la neurosyphilis peut survenir à divers stades.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 217 — Les atteintes cardiovasculaires font partie de la syphilis tertiaire, tandis qu’une atteinte neurologique peut survenir à plusieurs stades.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les atteintes cardiovasculaires sont tardives ; les atteintes neurologiques ne sont pas exclusivement tertiaires.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 218 — L'hépatite B est une infection sexuellement transmissible :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le VHB se transmet notamment par voie sexuelle, sanguine et périnatale.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 219 — Indiquez le médicament à ne pas administrer chez un patient souffrant d’une hépatite parmi ceux-ci

A. Aspégic 1 g en IVD x 2 fois/jour

B. Vogalène 1 ampoule en IVD x 2 fois/jour

C. Clamoxyl 1 g en IVD 2 fois/jour

D. Vitamine C 1000 mg/jour

Réponse : A

Explication : L’aspirine augmente le risque hémorragique ; en hépatopathie, la prescription doit tenir compte de la coagulation et de la gravité.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 220 — Laquelle des affirmations suivantes est exacte :

A. Le virus de l’hépatite E est un virus enveloppé et excrété dans les selles

B. Le virus de l’hépatite A est un virus sans enveloppe, transmis par voie sanguine

C. Le virus de l’hépatite C est strictement humain, dont la voie de contamination est parentérale

D. Le virus de l’hépatite B est un virus défectif qui dépend du virus de l’hépatite D pour sa multiplication

Réponse : C

Explication : Le VHC est principalement transmis par le sang ; c’est le VHD qui dépend du VHB.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 221 — L’objectif du traitement de l’hépatite chronique est de :

A. Diminuer l’activité de la maladie et prévenir l’évolution vers la cirrhose et ses complications

B. Éviter tous les facteurs potentiellement aggravants de l’hépatopathie

C. Arrêter la réplication et favoriser l’immunisation contre les virus concernés

D. Prévenir les complications et éradiquer le virus par une trithérapie antibiotique

Réponse : A, B

Explication : Les objectifs sont le contrôle de la maladie et la prévention de la cirrhose ; l’éradication dépend du virus et du traitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 222 — Relevez parmi les affirmations suivantes la mesure prophylactique à observer en cas d’hépatite virale :

A. Placer une sonde à demeure pour recueillir les urines

B. Éviter les petites blessures qui constituent des portes d’entrée du virus

C. Prélever du sang le matin à jeun pour le bilan biologique

D. Préparer une feuille de surveillance et de température

Réponse : B

Explication : Prévenir l’exposition au sang et utiliser du matériel sécurisé ; les mesures dépendent aussi du virus.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 223 — Laquelle des affirmations ci-après est exacte :

A. Le vaccin de l’hépatite B protège contre les hépatites C et E

B. Le vaccin contre l’hépatite B confère une immunité après la 2ème injection

C. La vaccination de masse contre l’hépatite B est faite en cas de risque élevé de contamination

D. La vaccination de masse contre l’hépatite B est faite même en cas de risque moins élevé de contamination

Réponse : D

Explication : La vaccination universelle contre le VHB ne se limite pas aux seuls sujets déjà exposés à un haut risque.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 224 — Laquelle des affirmations suivantes est exacte :

A. Le virus de l’hépatite E est un virus enveloppé et excrété dans les selles

B. Le virus de l’hépatite A est un virus sans enveloppe, transmis par voie sanguine

C. Le virus de l’hépatite C est strictement humain, dont la voie de contamination est parentérale

D. Le virus de l’hépatite B est un virus défectif qui dépend du virus de l’hépatite D pour sa multiplication

Réponse : C

Explication : Le VHC est surtout transmis par voie parentérale ; le VHD dépend du VHB et non l'inverse.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 225 — L'objectif du traitement de l'hépatite chronique est de :

A. Diminuer l'activité de la maladie et prévenir l'évolution vers la cirrhose et ses complications

B. Éviter tous les facteurs potentiellement aggravants de l'hépatopathie

C. Arrêter la réplication et favoriser l'immunisation contre les virus concernés

D. Prévenir les complications et éradiquer le virus par une trithérapie antibiotique

Réponse : A, B

Explication : Réduire l'activité de l'hépatite et éviter les facteurs aggravants ; le traitement est antiviral selon l'étiologie.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 226 — Relevez parmi les affirmations suivantes la mesure prophylactique à observer en cas d'hépatite virale :

A. Placer une sonde à demeure pour recueillir les urines

B. Éviter les petites blessures qui constituent des portes d'entrée du virus

C. Prélever du sang le matin à jeun pour le bilan biologique

D. Préparer une feuille de surveillance et de température

Réponse : B

Explication : Prévenir les expositions au sang et respecter les précautions standard.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 227 — Laquelle des affirmations ci-après est exacte :

A. Le vaccin de l'hépatite B protège contre les hépatites C et E

B. Le vaccin contre l'hépatite B confère une immunité après la 2ème injection

C. La vaccination de masse contre l'hépatite B est faite en cas de risque élevé de contamination

D. Le rôle de l'infirmier dans les hépatites virales se situe dans les mesures prophylactiques

Réponse : D

Explication : L'éducation et la prévention font partie du rôle infirmier ; le vaccin VHB ne protège pas contre VHC ou VHE.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

M. AZIO, 43 ans, ouvrier à la SURCAF 2, père de 03 enfants dont un en classe d'examen, est admis en médecine à la période pré-ictérique d'une hépatite virale. Les investigations cliniques et paracliniques entreprises révèlent qu'il s'agit de l'hépatite B, contractée lors d'une transfusion sanguine pour anémie post-hémorragique. Son taux d'hémoglobine se chiffrait à 5 g/dl et il pesait 55 kg. Ce matin, M. AZIO est anxieux. Vous conseillez aux membres de sa famille des mesures préventives.

Question 228 — Quels sont les deux signes qui caractérisent la phase pré-ictérique de l'hépatite virale ci-après ?

A. Arthralgie

B. Diarrhée

C. Vertige

D. Asthénie

E. Sudation

F. Insomnie

Réponse : A, D

Explication : Asthénie et arthralgies sont possibles avant l’apparition de l’ictère.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 37–45, hépatites virales.

Question 229 — Le type de sang qu’a reçu M. AZIO est du :

A. Sang O négatif

B. Sang AB négatif

C. Sang iso-groupe iso-rhésus

D. Sang O positif

Réponse : C

Explication : Le choix habituel est un produit compatible, de préférence iso-groupe iso-rhésus après contrôles prétransfusionnels.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 37–45, hépatites virales.

Question 230 — Le volume qui a été transfusé à M. AZIO est :

A. 3040 ml

B. 2340 ml

C. 4320 ml

D. 3240 ml

E. Impossible à calculer sans objectif d’hémoglobine, type de produit et règle de calcul.

Réponse : E

Explication : Le taux d’hémoglobine cible n’est pas fourni ; aucun volume unique ne peut être calculé à partir du poids et de l’Hb initiale seuls.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 231 — Quel accident de surcharge M. AZIO peut-il présenter au cours d’une transfusion trop rapide ou trop volumineuse ?

A. Insuffisance cardiaque

B. Œdème aigu des poumons

C. Insuffisance respiratoire

D. Hyperhydratation

Réponse : B

Explication : L’OAP de surcharge est un accident possible d’une transfusion trop rapide ou trop volumineuse.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 37–45, hépatites virales.

Question 232 — La vaccination contre l’hépatite B est une des mesures préventives que vous conseillez aux membres de la famille de M. AZIO qui acceptent de se vacciner. Quelle est la précaution principale que vous observerez avant :

A. Assurer l’hygiène de vie et environnementale

B. Faire une sérothérapie

C. Dépister les membres de la famille

D. Utiliser du matériel à usage unique

Réponse : C

Explication : Un dépistage des contacts peut être proposé, sans retarder inutilement la vaccination ; du matériel stérile à usage unique est toujours indispensable.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 37–45, hépatites virales.

Question 233 — Lequel des diagnostics infirmiers suivants est en rapport avec la personne de M. AZIO

A. Hépatite virale reliée à la transfusion sanguine due à l'anémie

B. Anxiété reliée à l'hépatite virale aggravée par son hospitalisation

C. Incapacité d'assumer ses responsabilités parentales reliée à son hospitalisation

D. Anxiété reliée à la crainte de perdre son emploi

Réponse : B

Explication : L'anxiété liée à la maladie et à l'hospitalisation est étayée par le texte ; une crainte précise de licenciement n'est pas rapportée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 234 — En rapport avec ce diagnostic infirmier, le besoin de M. AZIO est le besoin :

A. D'apprendre

B. De se récréer

C. De communiquer avec ses semblables

D. De s'occuper en vue de se sentir utile

Réponse : C

Explication : Exprimer ses inquiétudes et recevoir une information adaptée relèvent du besoin de communiquer.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 235 — L'objectif de soin à court terme chez M. AZIO relativement à ce besoin est :

A. Que l'anxiété de M. AZIO se dissipe dans 08 heures

B. Que M. AZIO retrouve les membres de sa famille dans les 12 heures

C. Que M. AZIO soit informé de la situation de ses enfants au bout de 3 heures

D. Que M. AZIO reprenne ses activités dans une semaine

Réponse : A

Explication : L'objectif doit viser une diminution mesurable de l'anxiété ; un délai de réévaluation est fixé.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

Étude de cas Monsieur Digbeu Tape Valentin, instituteur de son état, est affecté à l'EPP Providence I. Pour se rapprocher de son lieu de travail il loue une maison près d'un grand caniveau à Lobikro. Depuis quelques jours il sent des myalgies diffuses, des frissons, et parfois des nausées. Pour ne pas tomber dans les paumes il se rend dans la pharmacie de son quartier et achète un remontant (MAG II AMPOULE BUVABLE). Deux jours après il présente les signes suivants : fièvre à 39°C, sueurs, céphalées, vomissements et constipation. Ne sachant que faire il se rend au centre de santé où vous exercez comme infirmier.

Question 236 — Quelle hypothèse diagnostique principale faut-il vérifier chez M. DIGBEU, en l’absence de critère de gravité identifié ?

A. Fièvre typhoïde

B. Paludisme simple

C. Paludisme grave

D. Méningite purulente

Réponse : B

Explication : Sans critère de gravité, un accès fébrile confirmé parasitologiquement correspond à un paludisme simple.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 237 — Parmi les germes suivants, lequel est en cause ? Se référer au texte

A. Pneumocoque

B. Plasmodium

C. Salmonelle

Réponse : B

Explication : Le paludisme est dû à un parasite du genre Plasmodium.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 238 — Parmi les examens demandés par le médecin, lequel est à propos ?

A. Goutte épaisse

B. NFS

C. Widal et Félix

Réponse : A

Explication : La goutte épaisse ou un test rapide recherche le parasite ; la NFS évalue notamment l’anémie.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 239 — Le médecin décide de le mettre en observation avec un SGI 5% de 500 ml pendant 8h, quel doit être le débit de cette perfusion ? Utiliser un perfuseur de 20 gouttes/ml.

A. 20 gouttes/mn

B. 21 gouttes/mn

C. 22 gouttes/mn

D. 23 gouttes/mn

Réponse : B

Explication : Avec un perfuseur de 20 gouttes/ml : 500 × 20 ÷ (8 × 60) = 20,83, soit 21 gouttes/minute.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 240 — Le paludisme peut être contracté par

A. Ingestion d’aliments parasités

B. Transfusion de dérivés sanguins

C. Transmission placentaire

Réponse : B, C

Explication : Une transmission transfusionnelle ou maternofœtale est possible, en plus de la transmission par l’anophèle.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 241 — Parmi les signes suivants d’une méningite purulente, deux sont du syndrome infectieux, lesquels ?

A. Fièvre à 39-40°C

B. Raideur de la nuque

C. Convulsions

D. Signes de Kernig positifs

E. Pouls rapide

Réponse : A, E

Explication : Fièvre et tachycardie relèvent du syndrome infectieux ; raideur et Kernig relèvent du syndrome méningé.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et raisonnement clinique ; justification non localisée dans les cours consultés.

Démarche de soins infirmiers

Question 242 — Pour une perfusion de sérum glucosé iso 500 cc + paluject 8 cc + HPV 4 cc à faire passer en 3 heures 15 minutes, choisir la bonne réponse : Calcul théorique avec un perfuseur de 20 gouttes/ml ; les compatibilités médicamenteuses sont vérifiées séparément.

A. 53,36 gouttes/minute

B. 52,51 gouttes/minute

C. 51,52 gouttes/minute

D. 50,75 gouttes/minute

Réponse : B

Explication : Volume total 512 ml, durée 195 min ; à 20 gouttes/ml : 512 × 20 ÷ 195 = 52,51 gouttes/minute.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 243 — Quels conseils sont pertinents chez une personne recevant une corticothérapie systémique prolongée à dose immunosuppressive ?

A. Les vaccinations à germes vivants sont proscrites

B. Le patient doit éviter les efforts physiques

C. La patiente en grossesse doit consulter son médecin

D. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, C

Explication : Évaluer vaccination et grossesse avec le médecin ; une activité adaptée est utile, sans arrêt brutal d’une corticothérapie prolongée.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 244 — La démarche de soins correspond à :

A. Un processus dynamique de résolution de problème centré sur la personne soignée

B. Un outil qui assure les transmissions médicales

C. Un instrument de travail qui se traduit par un plan de soins

D. Un outil qui assure la délégation médicale

E. Une suite ordonnée d'opérations finalisées, une prestation de soins individualisés

Réponse : A, C, E

Explication : La démarche de soins est un raisonnement clinique structuré centré sur la personne, concrétisé par un plan de soins.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 245 — Les étapes de la démarche de soins infirmiers sont essentiellement :

A. Recueil et analyse de données

B. Formulation des objectifs de soins

C. Mise en œuvre des actions appropriées

D. Évaluation des actions en vue des réajustements nécessaires

Réponse : A, B, C, D

Explication : Recueil, analyse et diagnostic précèdent objectifs, interventions et évaluation.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 246 — Vous menez un interrogatoire auprès d'un malade dans l'optique d'une planification des activités de soins. Quels sont les éléments que doit comporter votre démarche ?

A. Identification de la personne, situation familiale et socioprofessionnelle

B. Date et motif d'entrée et prise en charge sociale

C. Antécédents médicaux et chirurgicaux et particularités physique, psychique, motrice

D. Histoire contextuelle et événements significatifs

E. État de santé à ce jour et traitements

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Ces données contextualisent la situation de santé et les ressources de la personne.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 247 — Quelles sont les étapes nécessaires à la collecte de données ?

A. Entrevue

B. Examen physique

C. Observation

D. Planification des interventions

Réponse : A, B, C

Explication : Entretien, examen et observation alimentent le recueil ; la planification intervient ensuite.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 248 — Les principes fondamentaux de l'éthique professionnelle en soins infirmiers sont :

A. Le respect de l'autonomie

B. La bienfaisance

C. La malfaisance

D. La justice

Réponse : A, B, D

Explication : Les principes sont autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 249 — Les avantages de la démarche de soins infirmiers (DSI) sont :

A. Uniformisation du vocabulaire technique employé par le personnel infirmier

B. Renforcement de la sécurité du patient

C. Évaluation et amélioration de la qualité des soins prodigués

D. Amélioration de l'encodage informatisé des données de santé

Réponse : A, B, C

Explication : Un vocabulaire commun et des soins individualisés améliorent sécurité et qualité ; l'informatisation n'est pas une condition de la démarche.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 250 — Le projet de soins ou planification des interventions :

A. Fait suite à l'analyse des données recueillies sur un patient

B. Consiste à établir un plan d'actions formalisé par un plan de soins

C. Est synonyme de la planification des soins

D. Est un outil d'évaluation de la démarche des soins

E. Est un outil de la collecte des données

Réponse : A, B, C

Explication : La planification traduit l'analyse et les diagnostics en objectifs et actions organisées.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 251 — Dans la planification des soins, il faut tenir compte de :

A. Besoins fondamentaux insatisfaits

B. Signes cliniques

C. Diagnostic infirmier

D. Diagnostic médical

Réponse : A, B, C, D

Explication : Les besoins, signes et diagnostics médicaux et infirmiers éclairent la planification.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 252 — Le diagnostic infirmier :

A. Signifie l'énoncé d'un jugement clinique

B. Est un outil de suivi thérapeutique

C. Sert de base pour choisir les interventions de soins

D. Est un outil d'évaluation de l'efficacité des soins

Réponse : A, C

Explication : Le diagnostic infirmier est un jugement clinique qui guide le choix des interventions infirmières.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 253 — Le diagnostic infirmier

A. Dépend du diagnostic médical

B. Se réfère aux problèmes du patient

C. Relève du rôle propre de l'infirmier

D. Est posé en collaboration avec le médecin

Réponse : B, C

Explication : Il décrit les réponses humaines à la situation et relève du jugement infirmier ; il ne se réduit pas au diagnostic médical.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 254 — Cochez parmi les éléments suivants, les paramètres qui interviennent dans l'énoncé d'un diagnostic infirmier :

A. Le problème infirmier réel

B. Le problème potentiel (ou problème risque)

C. L'étiologie (ou cause)

D. Les facteurs de risques

E. Les signes ou manifestations cliniques

F. Toutes les réponses ne sont pas exactes

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Le diagnostic réel associe problème, cause et manifestations ; le diagnostic de risque comporte problème potentiel et facteurs de risque.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 255 — L'objectif de soin se formule avec :

A. Un verbe d'état

B. Un verbe d'action

C. N'importe quel verbe

D. Un auxiliaire

Réponse : B

Explication : Un verbe observable et mesurable permet d'évaluer l'atteinte de l'objectif.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 256 — Un objectif de soins infirmiers relève :

A. De la fin que l'on veut atteindre pour le client

B. De l'indépendance du client dans la satisfaction de ses besoins

C. De la personne soignée et du diagnostic infirmier

Réponse : A, B, C

Explication : L'objectif précise un résultat souhaité pour la personne, en lien avec le diagnostic et l'autonomie.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 257 — L’objectif de soins infirmiers se présente comme suit :

A. Identité, capacité, atteinte souhaitée, délai

B. Présentation de la personne, résultat que l’on souhaite atteindre

C. Capacité de la personne à atteindre l’objectif

Réponse : A

Explication : La formulation précise la personne, la capacité ou le résultat attendu et le délai.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 258 — Un objectif de soin est :

A. Un sujet unique

B. Une recommandation de l’institution de soin

C. Une fin que l’on veut atteindre pour le client

D. Un idéal pour le malade

Réponse : C

Explication : Un objectif est un résultat à atteindre pour la personne soignée.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 259 — Les sources de difficultés identifiées par Virginia Henderson se composent de ce qui suit, sauf une. Laquelle ?

A. Manque de connaissance

B. Environnement inadéquat

C. Manque de force physique

D. Manque de volonté

Réponse : B

Explication : Les trois sources classiques de Henderson sont manque de force, de volonté ou de connaissances.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 260 — Le nouveau-né GG est en bonne santé. L’infirmier lui administre 1 mg de vitamine K1 en intramusculaire. Cet acte de soins figure dans les rôles :

A. Propres

B. Délégués

C. Collaboration

D. Conseils et prévention

Réponse : B

Explication : L’administration médicamenteuse s’inscrit dans une prescription ou un protocole autorisé, avec une finalité préventive.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 261 — Le nouveau-né GG est malade. L’infirmier va au laboratoire pour récupérer le résultat de l’hémoculture. Cet acte de soins figure dans les rôles :

A. Propres

B. Délégués

C. Collaboration

D. Conseils et prévention

Réponse : C

Explication : Le recueil d’un résultat de laboratoire contribue à la collaboration dans la prise en charge.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 262 — BZ, 5 minutes de vie, présente une cyanose des extrémités, des geignements, est tout mou, une respiration irrégulière et un pouls au cordon ombilical de 68 battements/minute. Il y a combien de données de dépendance :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Réponse : D

Explication : Cinq données anormales sont décrites : cyanose, geignements, hypotonie, respiration irrégulière et bradycardie.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

M. AZIO, 43 ans, ouvrier à la SURCAF 2, père de 03 enfants dont un en classe d’examen, est admis en médecine à la période pré-ictérique d’une hépatite virale. Les investigations cliniques et paracliniques entreprises révèlent qu’il s’agit de l’hépatite B, contractée lors d’une transfusion sanguine pour anémie post-hémorragique. Son taux d’hémoglobine se chiffrait à 5 g/dl et il pesait 55 kg. Ce matin, M. AZIO est anxieux. Vous conseillez aux membres de sa famille des mesures préventives.

Question 263 — Chez M. AZIO, décrit dans l’étude de cas, quel diagnostic infirmier est directement étayé par l’anxiété et l’hospitalisation ?

A. Asthénie reliée à la transfusion sanguine due à l’anémie

B. Anxiété reliée à l’hépatite virale aggravée par son hospitalisation

C. Incapacité d’assumer ses responsabilités parentales reliée à son hospitalisation

D. Anxiété reliée à la crainte de perdre son emploi

Réponse : B

Explication : Plusieurs diagnostics sont plausibles ; le choix exige les données du patient et ses manifestations.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 264 — Le plan de soins est :

A. Un document écrit, établi par l’infirmier et qui comporte la liste de tous les soins requis par un client en réponse à ses besoins

B. Une fiche de soins écrite par l’infirmier et qui comporte la liste de toutes les prescriptions médicales requises par un client en réponse aux symptômes qu’il présente

C. Une fiche navette écrite par l’infirmier et qui comporte la liste de tous les paramètres vitaux requis par un client en réponse aux éléments de surveillance

Réponse : A

Explication : Le plan de soins organise l’ensemble des soins requis, au-delà de la seule prescription médicale.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 265 — Le Plan de Soins (cochez la réponse fausse) :

A. Tient compte de la prescription médicale

B. Tient compte des besoins prioritaires du client

C. Tient compte des ressources disponibles

D. Tient compte des caractéristiques propres

E. Tient compte des particularités individuelles

F. Est interchangeable

Réponse : F

Explication : Le plan est individualisé et n'est pas interchangeable entre patients.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 266 — Le plan de soins a pour avantages :

A. L'individualisation des soins

B. D'assurer la continuité des soins

C. De communiquer avec le malade

D. De supervision des soins

Réponse : A, B, D

Explication : Il favorise individualisation, continuité et supervision ; il facilite aussi les transmissions entre professionnels.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 267 — Le plan de soins conseillé par l'OOAS comprend :

A. 7 rubriques

B. 5 rubriques

C. 8 rubriques

D. 9 rubriques

E. Le nombre exact dépend du modèle OOAS daté utilisé ; le modèle doit être précisé.

Réponse : E

Explication : Le nombre de rubriques dépend du modèle OOAS enseigné ; le document correspondant est nécessaire pour choisir un chiffre.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 268 — Le plan de soins est un outil qui permet de communiquer

A. Les problèmes diagnostiqués chez le patient

B. Les objectifs d'interventions infirmières

C. La démarche de l'évaluation des soins

D. Les modalités d'amélioration de la qualité des soins

Réponse : A, B, C, D

Explication : Le plan rend visibles problèmes, objectifs, interventions et modalités d'évaluation et d'amélioration.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 269 — Parmi les éléments à considérer dans un plan de soins, on note :

A. Diagnostiquer le problème

B. Identifier les besoins

C. Planifier les soins

D. Évaluer l'activité infirmière

E. Assurer les transmissions infirmières

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Ces éléments participent à l'organisation et à la continuité des soins.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 270 — Le dossier infirmier permet de :

A. Diagnostiquer les problèmes du patient : diagnostic infirmier

B. Identifier les besoins du patient

C. Planifier les soins

D. Contrôler la présence du personnel infirmier

Réponse : A, B, C

Explication : Le dossier renseigne besoins, diagnostics et planification ; il ne remplace pas le registre de présence du personnel.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 271 — Le dossier de soins infirmiers est un moyen pour :

A. Évaluer les soins infirmiers

B. Planifier les soins infirmiers

C. Contrôler la présence des infirmiers

D. Assurer une continuité des soins

E. Assurer les transmissions infirmières

Réponse : A, B, D, E

Explication : Le dossier assure traçabilité, évaluation, planification et transmissions.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 272 — Indiquez les quatre éléments de la préparation psychologique

A. Saluer le patient

B. Accueillir le patient

C. Identifier le patient

D. Surveiller le soin fait

E. Se présenter au patient

F. Expliquer le soin à faire

Réponse : A, B, E, F

Explication : Accueil, salutation, présentation et explication du soin favorisent la confiance ; vérifier l'identité reste indispensable à la sécurité.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 273 — Des fonctions suivantes lesquelles appartiennent à l'agent de santé

A. La fonction de surveillance

B. La fonction administrative

C. La fonction thérapeutique

D. La fonction d'encadrement

E. La fonction d'évaluation

F. La fonction de recherche

Réponse : A, B, C, D, E, F

Explication : Surveillance, administration, soins, encadrement, évaluation et recherche font partie des fonctions professionnelles selon le poste.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 274 — La formulation de l'objectif de soins se fait à partir de la deuxième partie du diagnostic infirmier :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'objectif vise d'abord la résolution du problème ; les interventions agissent notamment sur les causes ou sources de difficulté.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 275 — Pour déterminer des activités conformes au diagnostic infirmier, l'infirmier doit se baser sur la source de difficulté :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les actions doivent répondre au problème et aux sources de difficulté identifiées.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 276 — L'analyse des données recueillies sur un patient se fait selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson en classant en deux types de données :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le modèle distingue notamment les manifestations d'indépendance et de dépendance.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 277 — La formulation du diagnostic infirmier intervient après l'interprétation des données :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le diagnostic résulte du recueil, de l’analyse et de l’interprétation des données.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 278 — Le diagnostic infirmier se fait selon les besoins fondamentaux :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Dans le modèle de Henderson, l’analyse des besoins fondamentaux aide à formuler les diagnostics.

Source : Connaissances complémentaires — démarche de soins et modèle de Virginia Henderson ; justification non localisée dans les cours consultés.

Transfusion et accidents d’exposition

Question 279 — La (les)quelle(s) des transfusions suivantes est (sont) compatible(s) :

A. La transfusion d’hématies O à un receveur A, B, AB

B. La transfusion d’hématies AB à un receveur B

C. La transfusion d’hématies A à un receveur AB

D. La transfusion d’hématies AB à un receveur O

Réponse : A, C

Explication : Les hématies O n’apportent ni antigène A ni B ; les hématies A peuvent être reçues par un sujet AB, sous réserve des autres compatibilités.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 280 — En cas d’erreur de groupe sanguin lors d’une transfusion, la conséquence est :

A. Un accident infectieux

B. Un accident hémolytique

C. Un accident allergique

D. Un accident hypovolémique

Réponse : B

Explication : Une incompatibilité ABO peut provoquer une hémolyse aiguë grave.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 281 — Les précautions à prendre avant de démarrer une transfusion sanguine sont :

A. Vérifier la température du malade

B. Contrôler la glycémie

C. Vérifier la date de péremption du sang

D. Faire un test d’hypersensibilité

E. Mesurer la pression artérielle

F. Vérifier le groupe inscrit sur la poche de sang

Réponse : A, C, E, F

Explication : Vérifier identité, compatibilité, produit, péremption et constantes ; le test d’hypersensibilité n’est pas un contrôle transfusionnel.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 282 — Devant quels signes, devez-vous arrêter la transfusion de votre malade

A. Une légère augmentation de sa température

B. Un prurit diffus

C. Une polyurie

D. Sensation de douleur abdominale

E. Une polyphagie

F. Des céphalées

Réponse : A, B, D, F

Explication : Tout symptôme nouveau faisant suspecter une réaction impose interruption et évaluation immédiates.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 283 — Vous devez transfuser un patient de groupe A+ et vous disposez du culot globulaire AB+, B+ et O+. Quel culot globulaire utiliserez-vous ?

A. Le culot globulaire AB+

B. Le culot globulaire O+

C. Le culot globulaire AB+ et O+

D. Le culot globulaire B+

Réponse : B

Explication : Le concentré O+ est compatible ABO avec un receveur A+ sous réserve de la RAI et des contrôles.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 284 — En cas de transfusion de concentrés de globules rouges, le « seuil transfusionnel » est à :

A. 12 g/dl d’hémoglobine chez la femme

B. 18 g/dl d’hémoglobine chez l’homme

C. 7 g/dl d’hémoglobine chez les patients sans antécédent particulier

D. 10 g/dl en cas de pathologie cardiaque

Réponse : C

Explication : Un seuil restrictif autour de 7 g/dl est usuel chez l’adulte stable ; terrain cardiaque et situation aiguë modifient la décision.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 285 — Dans le cadre de la transfusion, le groupe AB

A. Contient des antigènes anti-A sur ses hématies

B. Ne contient normalement ni anticorps anti-A ni anticorps anti-B dans son plasma.

C. Contient des antigènes anti-B sur ses hématies

D. Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies

Réponse : B

Explication : Le plasma AB ne contient normalement pas d’anti-A ni d’anti-B ; il peut contenir d’autres anticorps.

Source : American Society of Hematology, Blood Safety and Matching, rubrique plasma. https://www.hematology.org/education/patients/blood-basics/blood-safety-and-matching

Question 286 — Avec un transfuseur calibré à 15 gouttes/ml, combien de gouttes correspondent à 1 ml de produit sanguin ?

A. 10 gouttes

B. 15 gouttes

C. 20 gouttes

D. 23 gouttes

Réponse : B

Explication : Le calcul suppose ici un transfuseur calibré à 15 gouttes/ml ; le facteur réel doit toujours être lu sur le dispositif.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 287 — La transfusion de plaquettes est indiquée pour :

A. Stopper une hémorragie

B. Prévenir une hémorragie

C. Traiter l’aplasie qui suit une chimiothérapie

D. Traiter une anémie

Réponse : A, B

Explication : Les plaquettes préviennent ou traitent certains saignements liés à une thrombopénie ou thrombopathie ; elles ne guérissent pas l’aplasie.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 288 — Parmi les risques et complications transfusionnels, on note :

A. Les risques immunologiques

B. Les risques infectieux

C. Les problèmes de surcharge

D. Les problèmes métaboliques

Réponse : A, B, C, D

Explication : Les complications peuvent être immunologiques, infectieuses, circulatoires ou métaboliques.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 289 — Parmi les accidents de la transfusion, on note :

A. Le choc hémolytique

B. Le choc hémodynamique

C. Le choc anaphylactique

D. Accident de surcharge

Réponse : A, C, D

Explication : Hémolyse, anaphylaxie et surcharge sont des accidents reconnus ; « choc hémodynamique » est trop imprécis.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 290 — Les accidents transfusionnels immunologiques hémolytiques immédiats surviennent suite à :

A. Une erreur ABO

B. Une erreur d'étiquetage de la poche de sang

C. Un syndrome fébrile post-transfusionnel

D. Non-respect de la procédure de compatibilité pré-transfusionnelle

Réponse : A, B, D

Explication : Une erreur ABO, d'étiquetage ou de contrôle peut conduire à une hémolyse immunologique.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 291 — Chez un sujet de groupe O, quel est l'antigène (Ag) de son groupe O.

A. Ag A

B. Ag B

C. Ag AB

D. Aucun

Réponse : D

Explication : Le groupe O ne porte ni antigène A ni B ; d'autres antigènes, notamment H et Rh, existent.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 292 — Pour une transfusion de culot globulaire, le critère qui fait que le groupe « O » est un donneur universel est qu'il :

A. Contient des antigènes anti-A sur ses hématies

B. Ne contient ni antigène A ni antigène B sur ses hématies.

C. Contient des antigènes anti-B sur ses hématies

D. Contient des antigènes anti-A et anti-B sur ses hématies

Réponse : B

Explication : Les hématies O n'ont pas d'antigène A ni B ; « universel » ne dispense jamais des contrôles et des autres compatibilités.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 293 — En cas de suspicion d'effet indésirable lors d'une transfusion :

A. Arrêter la transfusion

B. Retirer la voie veineuse et appeler le médecin

C. Poursuivre la surveillance sans arrêter la transfusion

D. Se référer à la procédure d'hémovigilance

Réponse : A, D

Explication : Arrêter le produit, conserver l'accès veineux avec un dispositif adapté, alerter et appliquer la procédure d'hémovigilance.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 294 — Cochez le premier geste à faire devant un accident transfusionnel :

A. Placer le malade en position assise

B. Arrêter la transfusion

C. Administrer au malade des anticoagulants

D. Réchauffer le malade

E. Faire un cross match

Réponse : B

Explication : Le premier geste est l'arrêt immédiat de la transfusion, puis l'alerte et l'évaluation.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 295 — Pour un patient groupe A, vous disposez de plasma frais congelé AB et O. Quel plasma frais congelé utiliserez-vous ?

A. Le plasma frais congelé AB

B. Le plasma frais congelé O

C. Indifféremment AB ou O

D. Aucune réponse n'est juste

Réponse : A

Explication : Le plasma AB ne contient pas d'anti-A ; le plasma O peut hémolyser les hématies d'un receveur A.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 296 — Devant les signes suivants : un malaise, des frissons violents, une fièvre à 40°C, des vomissements, une diarrhée profuse, observés chez un patient sous transfusion sanguine. De quel accident transfusionnel s'agit-il :

A. Un accident de surcharge

B. Un accident de contamination

C. Un accident d'incompatibilité sanguine

D. Un accident de choc opératoire

E. Un accident d'hémolyse

Réponse : B

Explication : Fièvre élevée, frissons et signes digestifs évoquent une contamination bactérienne ; il faut aussi exclure une hémolyse.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 297 — Pour les calculs effectués avec un transfuseur de 15 gouttes/ml, quelle correspondance utilise-t-on ?

A. Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 10 gouttes

B. 1 ml de produit sanguin correspond à 15 gouttes avec ce dispositif.

C. Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 20 gouttes

D. Les produits sanguins sont des produits à grosses molécules pour lesquels 1 ml correspond à 30 gouttes

Réponse : B

Explication : La correspondance dépend du transfuseur ; 15 gouttes/ml est une hypothèse de calcul, non une propriété de la taille des molécules.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 298 — Une hémorragie abondante peut se compliquer par (choisir les bonnes réponses) :

A. Hypertension artérielle

B. L'anémie

C. Le choc hémorragique

D. Le choc anaphylactique

Réponse : B, C

Explication : Une perte sanguine peut entraîner anémie et choc hémorragique.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 299 — Quels facteurs augmentent la gravité d'un accident d'exposition au sang ?

A. La blessure cutanée secondaire à l'accident est profonde

B. La charge virale du patient source au moment de l'accident est élevée

C. L'aiguille est de gros calibre

D. Le contact avec le sang est de courte durée

Réponse : A, B, C

Explication : Profondeur, charge virale et aiguille de gros calibre sont tous des facteurs de risque ; le nombre de bonnes réponses doit être trois.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 300 — Quel est le moment idéal de prise de la chimio-prophylaxie après un accident d'exposition au sang. Choisissez la bonne réponse :

A. 5 minutes

B. Le plus tôt possible, idéalement dans les premières heures, sans dépasser 72 heures.

C. 48 heures

D. 7 jours

Réponse : B

Explication : Débuter le plus tôt possible, idéalement dans les premières heures, sans dépasser 72 heures ; quatre heures ne sont pas un délai à attendre.

Source : OMS, Guidelines for HIV post-exposure prophylaxis, 22 juillet 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240095137

Question 301 — En cas de blessure ou contact direct avec un liquide biologique sur peau lésée (accident d'exposition au sang), il faut :

A. Terminer l'activité en cours

B. Nettoyer immédiatement la zone cutanée lésée à l'eau et au savon

C. Désinfecter au Dakin stabilisé la zone cutanée concernée

D. Désinfecter avec l'alcool à 70° avec un temps de contact d'au moins 5 min

Réponse : B, C, D

Explication : Laver immédiatement à l'eau et au savon, rincer puis appliquer un antiseptique adapté, dont le Dakin ou l'alcool à 70° selon le protocole local. Ne pas faire saigner ; demander une évaluation urgente.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 302 — En cas d’accident par exposition au sang :

A. Faire saigner

B. Ne pas faire saigner

C. Nettoyer immédiatement à l’eau et au savon

D. Désinfecter avec un antiseptique adapté, par exemple du Dakin ou une solution chlorée à 0,5 %, pendant au moins 5 minutes, selon le protocole

Réponse : B, C, D

Explication : Ne pas faire saigner ; laver puis utiliser un antiseptique adapté selon le protocole, sans produit corrosif concentré.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 303 — L’hémovigilance porte sur :

A. Les procédures de surveillance et d’évaluation des incidents transfusionnels

B. La surveillance des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs du sang

C. La phase de collecte des produits sanguins labiles

D. Le suivi épidémiologique des donneurs

E. Toutes ces réponses ne paraissent pas être justes

Réponse : A, B, C, D

Explication : L’hémovigilance couvre la chaîne transfusionnelle et les événements chez donneurs et receveurs.

Source : Connaissances complémentaires — transfusion, immunohématologie et prévention des expositions ; justification non localisée dans les cours consultés.

VIH et traitements antirétroviraux

Question 304 — Le Traitement Antirétroviral Hautement Actif (HAART) est une association efficace de trois médicaments au moins, appartenant en général à au moins deux classes différentes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La trithérapie classique associe des médicaments actifs ; certains schémas validés actuels utilisent deux molécules.

Source : NIH, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV, rubrique What to Start. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/what-start-initial-combination-regimens

Question 305 — Le Traitement Antirétroviral Hautement Actif (HAART) est une association efficace de trois médicaments ou plus, appartenant en général à au plus deux classes différentes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : « Au plus deux classes » n’est pas une règle générale : deux ou plusieurs classes peuvent être utilisées.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 306 — La réduction du nombre de nouvelles contaminations est un intérêt du TARV

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un traitement efficace avec suppression virale réduit la transmission ; une charge virale durablement indétectable empêche la transmission sexuelle.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 307 — La réduction du nombre de maladies opportunistes, d'hospitalisations, de décès liés au VIH et l'amélioration de l'espérance de vie font partie des principes de base du TARV

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Ce sont des bénéfices et objectifs du traitement, à distinguer des principes pratiques d'association et d'observance.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 308 — Prévenir les échecs thérapeutiques et repousser la résistance dans le temps est un intérêt du TARV

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une prise correcte et un schéma actif limitent l'échec et l'émergence de résistances.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 309 — Concernant les interactions avec les ARV, la Rifampicine est contre-indiquée avec les inhibiteurs de protéase IP (Ritonavir).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La rifampicine interagit fortement avec les inhibiteurs de protéase boostés ; une alternative ou un avis spécialisé est nécessaire.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 310 — La Rifampicine associée aux INNRT augmente la concentration de la NVP

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La rifampicine induit le métabolisme et peut diminuer les concentrations de névirapine.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 311 — Il est recommandé de doubler la dose du Dolutégravir lors de l’association avec la rifampicine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : En l’absence de résistance aux intégrases, le dolutégravir est habituellement donné deux fois par jour avec la rifampicine selon le protocole.

Source : OMS, Dolutegravir 50 mg tablets, résumé des caractéristiques recommandé, interaction avec la rifampicine.
https://extranet.who.int/prequal/key-resources/documents/dtg-50mg-tablet-who-recommended-text-smpc

Question 312 — Les inhibiteurs de protéase (IP) diminuent les concentrations de certains contraceptifs oraux (éthinylestradiol).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Certains inhibiteurs de protéase modifient les concentrations d’éthinylestradiol ; vérifier l’association précise.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 313 — L’Artémisinine en association avec ARV+Rito est recommandée car il y a une augmentation des concentrations de l’antipaludéen

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une augmentation de concentration n’est pas un motif de recommandation ; l’interaction dépend de l’antipaludéen et de l’ARV précis.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 314 — L’Artémisinine en association avec INNRT est déconseillée car diminution des concentrations de l’antipaludéen

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’affirmation est trop générale : certaines associations restent utilisables avec précautions et surveillance.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 315 — La Quinine en association avec les INNRT entraîne une diminution des concentrations, donc augmenter les doses de la quinine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Ne pas augmenter automatiquement la quinine ; la conduite dépend de l’association et d’une évaluation des risques.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 316 — La Quinine en association avec ARV + Rito entraîne une augmentation des concentrations, donc diminuer les posologies de la quinine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Ne pas diminuer automatiquement la quinine sur cette seule affirmation ; avis spécialisé et surveillance sont nécessaires.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 317 — Le ritonavir diminue systématiquement la concentration de codéine, ce qui justifie d'en augmenter soi-même la dose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le ritonavir peut réduire l'activation de la codéine en morphine ; l'effet ne se résume pas à une diminution de concentration de codéine.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 318 — En cas de Pré-Exposition (PrEP) continue, l'arrêt du traitement n'est possible que 21 jours après la dernière prise de risque.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La durée après la dernière exposition dépend du produit et du type d'exposition ; 21 jours n'est pas une règle universelle d'arrêt.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 319 — La compliance est la capacité d'une personne à prendre un traitement selon une prescription donnée (posologie, horaire, repas).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La compliance décrit le suivi de la prescription, incluant doses et horaires.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 320 — L'adhésion est le degré d'accord du patient au traitement

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'adhésion correspond à l'accord éclairé et à l'implication du patient dans le traitement.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 321 — L’observance du TARV est le respect du rythme des prises médicamenteuses et quantité de médicaments

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’observance décrit l’application effective des modalités du traitement.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 322 — Comment préparer le patient au traitement ARV ? Entourer les bonnes les réponses exactes

A. Faire comprendre au patient l’importance d’une bonne observance

B. Gérer les effets indésirables des ARV

C. Faire savoir au patient que le traitement ARV est un traitement de longue durée ou à vie

D. Choisir le bon schéma de traitement

E. Respecter le calendrier de suivi

F. Prendre en compte les préoccupations et les priorités

Réponse : A, C, F

Explication : Expliquer la durée, l’intérêt d’une bonne prise et intégrer les préoccupations prépare l’adhésion.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 323 — Parmi les éléments suivants deux sont les principes de base du TARV lesquels ?

A. Associer les médicaments antirétroviraux

B. L’amélioration de la qualité de vie

C. Aider le patient à l’observance du TARV

D. La suppression ou une réduction forte et prolongée de la réplication virale (charge virale ou CV)

E. La restauration et l’amélioration de la fonction immunitaire

Réponse : A, C

Explication : Association d’ARV actifs et soutien à l’observance sont des principes de mise en œuvre ; les autres propositions sont des objectifs.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 324 — Parmi les éléments suivants indiquez ceux qui sont les principes de base pour aider le patient à l’observance du TARV

A. Éviter de prendre une ou deux molécules sur trois prescrites

B. Savoir que c’est un traitement à vie

C. Choisir le bon schéma de traitement

D. Renouveler les stocks à temps

E. Respecter les doses prescrites, les horaires de prises et les restrictions alimentaires

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Prendre le schéma complet, comprendre le traitement, anticiper les stocks et respecter les modalités favorisent l’efficacité.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 325 — Sous PrEP orale quotidienne au ténofovir, quel délai peut être nécessaire pour atteindre une protection maximale lors d'une exposition vaginale réceptive ?

A. 7 jours de prise

B. 21 jours de prise

C. 28 jours de prise

D. 30 jours de prise

Réponse : B

Explication : Pour une PrEP orale quotidienne au ténofovir, la protection maximale pour l'exposition vaginale peut nécessiter jusqu'à 21 jours.

Source : CDC, Clinical Guidance for PrEP, rubrique délai de protection. https://www.cdc.gov/hivnexus/hcp/prep/index.html

Question 326 — Les limites du Traitement ARV sont :

A. Activité non virucide

B. Médicaments non efficaces

C. Émergence rapide des mutants résistants

D. Médicaments onéreux pour le malade

Réponse : A, C

Explication : Les ARV ne suppriment pas les réservoirs ; une résistance peut émerger en cas de réplication sous pression thérapeutique insuffisante.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 327 — Sous PrEP orale quotidienne au ténofovir, quel délai est généralement retenu pour atteindre une protection maximale lors d'une exposition anale réceptive ?

A. 7 jours de prise

B. 21 jours de prise

C. 28 jours de prise

D. 30 jours de prise

Réponse : A

Explication : Le délai d'environ sept jours concerne l'exposition anale réceptive sous PrEP orale quotidienne, et ne se définit pas par le sexe seul.

Source : CDC, Clinical Guidance for PrEP, rubrique délai de protection. https://www.cdc.gov/hivnexus/hcp/prep/index.html

Question 328 — Un enfant de [6 mois – 3 ans[mis sous TARV (ABC + 3TC + LPV/r) a pour régime :

A. ABC + 3TC + LPV/r (Granules 40mg/10mg)

B. ABC + 3TC + LPV/r (Comprimés dispersibles 100mg/25mg)

C. ABC + 3TC + LPV/r (Sirop 80mg/20mg par mL)

Réponse : A

Explication : Les granules pédiatriques sont une présentation adaptée aux jeunes enfants ; dose et choix doivent suivre le poids et les directives.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Situation clinique

Étude de cas Enfant S V est né à la maternité rurale de S B le 14 Février 2023 d'un accouchement normal. Sa mère KM a été dépistée séropositive au VIH1 la veille de Noël 2022 lors de sa 1ère CPN et mise sous TARV le même jour mais n'a pas pu bénéficier d'un bilan initial ni de charge virale au cours de la grossesse à cause de la distance de la maternité au chef-lieu de Sous-Préfecture. Sur conseils de la Sage-Femme, l'enfant n'a pas été mis au sein.

Question 329 — Quel est le statut de l'enfant S V ?

A. Enfant exposé à faible risque de transmission du VIH

B. Enfant exposé à haut risque de transmission du VIH

C. Enfant exposé à aucun risque de transmission du VIH

D. Risque à évaluer selon charge virale, observance, durée du TARV et critères nationaux.

Réponse : D

Explication : La mère a reçu environ sept semaines de TARV, mais la charge virale et l'observance sont inconnues ; le risque exige le protocole national.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 330 — Faut-il mettre l'enfant S V sous traitement ?

A. Oui

B. Non

C. Je ne sais pas

Réponse : A

Explication : Tout enfant exposé doit bénéficier d'une prophylaxie adaptée au risque et d'un suivi virologique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 331 — Après plusieurs hésitations, la Sage-Femme décide de mettre l'enfant SV sous traitement ARV prophylactique ; aidez-la.

A. AZT 2 fois/jour pendant 6 semaines

B. AZT + NVP pendant 6 semaines

C. Névirapine (NVP) 1,5 ml/jour

D. Zidovudine (AZT) 1,5 ml deux fois/jour

E. Choisir la prophylaxie selon le risque et le protocole national ; calculer les doses selon poids et formulation.

Réponse : E

Explication : Sans classification du risque, poids et formulation, il n'est pas sûr de choisir une association ou une dose en millilitres.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 332 — A la visite de CPoN, la sage-femme s'est rendu compte que la mère KM n'a pas suivi ses conseils et qu'elle donne régulièrement le sein à son enfant SV sur insistance de sa grand-mère. Avec cette nouvelle donne, faut-il requalifier l'enfant SV ? (lui donner un nouveau statut) ?

A. Oui

B. Non

C. Je ne sais pas

Réponse : A

Explication : L’allaitement ajoute une exposition postnatale ; il faut réévaluer la situation sans culpabiliser la mère.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 333 — Faut-il changer de traitement ?

A. Oui

B. Non

C. Je ne sais pas

D. Réévaluer le risque et adapter la prophylaxie selon les directives plutôt que changer automatiquement.

Réponse : D

Explication : La prophylaxie est réévaluée selon la charge virale maternelle, l’observance, l’âge et le protocole ; un changement n’est pas automatique.

Source : OMS, Infant feeding for the prevention of mother-to-child transmission of HIV. https://www.who.int/tools/elena/interventions/hiv-infant-feeding

Question 334 — Le 30 Mars 2023 une PCR sera faite. Si la PCR est négative que faire ?

A. Poursuivre le traitement prophylactique prescrit

B. Arrêter le traitement prophylactique

C. Poursuivre la prophylaxie avec la NVP seule pendant 6 semaines supplémentaires

D. Poursuivre l’évaluation et le suivi virologique ; adapter la prophylaxie à l’exposition par l’allaitement selon les directives.

Réponse : D

Explication : Une PCR négative à six semaines ne clôt pas le suivi si l’allaitement continue ; durée et prophylaxie dépendent du risque et des directives.

Source : OMS, VIH et sida, fiche du 27 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Question 335 — En cas d’accident d’exposition, le traitement ARV prophylactique d’un adulte est :

A. TDF + 3TC + DTG dans les 72h suivant l’exposition et pendant 28 jours

B. AZT + 3TC + LPV/r dans les 72h suivant l’exposition et pendant 21 jours

C. TLD dans les 24h suivant l’exposition et pendant 21 jours

Réponse : A

Explication : La prophylaxie post-exposition débute au plus vite, dans les 72 heures, et dure 28 jours ; le schéma dépend des contre-indications.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 336 — En cas d’accident d’exposition, le traitement ARV prophylactique chez l’enfant de moins de 35 kg est :

A. TDF + 3TC + DTG

B. TDF + 3TC + LPV/r

C. AZT + 3TC + LPV/r

D. Schéma pédiatrique fondé sur âge, poids, formulations disponibles et recommandations actualisées.

Réponse : D

Explication : Le seuil de 35 kg seul ne suffit pas ; le schéma dépend de l’âge, du poids, de la formulation et des recommandations actualisées.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 337 — Indiquez les cas de référence au médecin de prise en charge

A. Co-infections TB/VIH

B. Co-infection hépatite/VIH

C. Anémie avec hémoglobine ≤ 8 g/dl.

D. Patient VIH avec facteurs de co-morbidité

E. Troubles neurologiques, rénaux et parasitaires

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Co-infections, anémie importante, comorbidités et atteintes d'organes justifient un avis médical ; l'Hb s'exprime en g/dl.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 338 — Quel est le seuil de bonne observance au TARV ?

A. Le seuil de bonne observance au TARV est de 90%

B. Le seuil de bonne observance au TARV est supérieur à 90%

C. Le seuil de bonne observance au TARV est inférieur ou égal à 90%

D. Viser toutes les doses prescrites et évaluer les oublis avec le patient.

Réponse : D

Explication : L'objectif est de prendre toutes les doses ; aucun seuil universel de 90 % ne définit à lui seul une bonne observance.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 339 — La mauvaise observance se définit par :

A. Acte délibéré ou non de manquer plus d'une dose au cours d'une période d'un mois pour un traitement se prenant deux fois par jour

B. Acte délibéré ou non de manquer plus d'une dose au cours d'une période de 10 jours pour un traitement se prenant deux fois par jour

C. Acte délibéré ou non de manquer une dose au cours d'une période de 10 jours pour un traitement se prenant deux fois par jour

D. Toute prise différente de la prescription doit être évaluée ; aucun seuil calendaire unique ne suffit.

Réponse : D

Explication : Toute dose manquée doit être évaluée ; aucun de ces découpages calendaires n'est une définition générale validée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 340 — Les causes de la mauvaise observance liées aux médicaments sont :

A. Nombre par prise

B. Au patient

C. Durée

D. Entourage du patient

E. Contraintes horaires

F. À l'âge du patient

Réponse : A, C, E

Explication : Nombre de comprimés, durée et contraintes horaires sont des facteurs liés au traitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 341 — Indiquez parmi les éléments suivants ceux qui sont les inconvénients d'une mauvaise observance du TARV

A. Diminution du nombre d'orphelins et enfants rendus vulnérables

B. Échec du TARV

C. Réduction des infections opportunistes

D. Aggravation de la maladie

E. Amélioration de l'espérance de vie

F. Réapparition des infections opportunistes

Réponse : B, D, F

Explication : La mauvaise observance expose à l'échec, à la progression de la maladie et aux infections opportunistes.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 342 — Le bilan initial comporte les examens suivants sauf un, lequel ?

A. Sérologie VIH

B. Charge virale CV

C. NFS

D. ALAT

E. Numération CD4

Réponse : A

Explication : Après confirmation du diagnostic VIH, répéter la sérologie n'évalue pas l'état initial ; le bilan biologique dépend du schéma et du terrain.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 343 — Le bilan de suivi d'un malade sous traitement ARV comporte les examens suivants sauf un, lequel ?

A. Sérologie VIH

B. Charge virale CV

C. NFS

D. ALAT

E. Numération CD4

Réponse : A

Explication : La sérologie reste positive et ne mesure pas l'efficacité ; le suivi repose surtout sur la charge virale et la clinique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 344 — Les moyens de prévention primaire de la transmission sexuelle du VIH sont :

A. L'abstinence sexuelle

B. La fidélité mutuelle mono-partenaire

C. Le rapport protégé

D. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, B, C

Explication : L’abstinence, la fidélité mutuelle dans un couple non infecté et le préservatif réduisent le risque ; la PrEP et le traitement efficace complètent la prévention.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Appareil urinaire

Question 345 — Les fonctions excrétrices du rein consistent à :

A. Éliminer des déchets

B. Éliminer les liquides en excès

C. Réguler la pression artérielle grâce à la rénine

D. Régler les taux d’électrolytes

Réponse : A, B, D

Explication : Les reins excrètent déchets, eau et électrolytes ; la rénine relève de leur fonction endocrine.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 346 — Avant la pose du sondage vésical, il faut vérifier :

A. L’identité du patient

B. Si le patient possède une couverture médicale

C. La prescription médicale conforme

D. L’étanchéité du matériel

Réponse : A, C, D

Explication : Vérifier identité, indication ou prescription, matériel et asepsie ; l’assurance n’est pas une condition clinique au geste.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 347 — Le lavage vésical est un nettoyage mécanique d’une vessie contenant des :

A. Dépôts lithiasiques

B. Débris épithéliaux

C. Urines

D. Caillots de sang

Réponse : A, B, D

Explication : L’irrigation peut évacuer caillots et débris dans des indications précises ; pas de lavage systématique d’une vessie sondée.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 348 — Les contre-indications du lavage vésical sont :

A. La rupture traumatique de l’urètre

B. L’infection urétrale

C. L’infection vésicale

D. L’âge

E. La sédentarité

Réponse : A, B

Explication : Un traumatisme urétral suspect ou une urétrite impose de différer le sondage aveugle et d’obtenir un avis adapté.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 349 — Les indications du lavage vésical sont :

A. Post-opératoire après une chirurgie sanglante

B. Résection trans-urétrale de la prostate

C. Résection trans-urétrale de la vessie

D. Hématuries

Réponse : A, B, C, D

Explication : L’irrigation peut prévenir ou évacuer les caillots après chirurgie ou en cas d’hématurie caillotante.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 350 — Les éléments de surveillance chez un patient porteur d’une sonde vésicale sont :

A. La perméabilité de la sonde

B. L’aspect des urines

C. La température du corps

D. Le pouls et la tension artérielle

E. L’hygiène corporelle

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Surveiller débit, perméabilité, aspect des urines, signes infectieux, constantes et soins d’hygiène.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 351 — L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

A. Avant la toilette des organes génitaux externes

B. Après la toilette des organes génitaux externes

C. En recueillant les urines du premier jet

D. Après avoir éliminé le premier jet contaminant

Réponse : B, D

Explication : Après toilette, recueillir le milieu de jet dans un pot stérile, avant antibiothérapie si possible.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 352 — La diurèse englobe :

A. La mesure quantitative des urines sécrétées

B. La mesure quantitative des urines sécrétées et leur analyse qualitative

C. L’analyse qualitative des urines sécrétées

Réponse : A

Explication : La diurèse est le volume d’urine émis dans un temps donné ; l’analyse qualitative est un examen distinct.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 353 — Parmi les anomalies de la diurèse, on note :

A. La polydipsie

B. L’hématurie

C. La polyurie

D. La pollakiurie

Réponse : C

Explication : La polyurie est une anomalie de volume ; hématurie et pollakiurie sont d’autres troubles urinaires.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 354 — Les diurétiques ont un effet sur :

A. L’augmentation de la diurèse

B. L’élévation de la TA

C. La résolution des œdèmes

D. La diminution du poids

Réponse : A, C, D

Explication : Les diurétiques augmentent l’excrétion urinaire et peuvent réduire œdèmes et poids liés à l’eau.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 355 — Les éléments de surveillance et d’évaluation de la diurèse sont :

A. La quantité des urines collectées

B. L’aspect des urines

C. La couleur et l’odeur des urines

D. La présence d’albumine

Réponse : A, B, C, D

Explication : La surveillance associe volume et caractéristiques ; l’albuminurie est évaluée lorsqu’elle est indiquée.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 356 — Les risques fréquents en cas d’hémodialyse sont :

A. Hypertension artérielle

B. Hypotension artérielle

C. Troubles de la fréquence cardiaque

D. Fatigue après la séance

Réponse : B, C, D

Explication : Hypotension, troubles du rythme et fatigue sont possibles pendant ou après l’hémodialyse.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 357 — Les indications d’un sondage vésical sont :

A. Rupture traumatique de l’urètre

B. Adénome de prostate

C. Chez un enfant avant l’âge de 18 mois

D. Urétrite aiguë suppurante

Réponse : B

Explication : La rétention sur obstacle prostatique peut justifier un drainage ; traumatisme urétral et infection requièrent une stratégie adaptée.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 358 — Le seuil rénal du glucose est de

A. 0,60 g/l

B. 1,10 g/l

C. 1,25 g/l

D. Environ 1,8 g/l, avec des variations individuelles.

Réponse : D

Explication : Le seuil rénal du glucose est approximativement de 1,8 g/l, avec des variations individuelles.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 359 — Les tailles des calculs dépendent de leur lieu de formation et de la durée de leur séjour au même endroit

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La croissance des calculs dépend notamment de la localisation, de la durée et de la composition urinaire.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 360 — La douleur de la lithiase débute avec une brusquerie extrême dans la région lombaire

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une colique néphrétique lithiasique débute souvent brutalement dans la région lombaire.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 361 — Une fièvre élevée ou une hypothermie lors d’une colique néphrétique doit faire craindre une infection sur obstacle, potentiellement septique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Fièvre ou hypothermie sur obstacle urinaire fait craindre une infection grave et nécessite une prise en charge urgente.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 362 — La lithiase est la cause la plus fréquente de la crise en tension brutale de la voie excrétrice

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La lithiase est une cause fréquente d'obstruction aiguë des voies urinaires.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 363 — La colique néphrétique est synonyme de lithiase

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La colique néphrétique est un syndrome douloureux ; la lithiase n'en est pas l'unique cause.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 364 — La diététhérapie est efficace dans le cas des calculs causés par un trouble métabolique provoquant une excrétion insuffisante de sels

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les mesures dépendent du type de calcul et des anomalies métaboliques ; l'excrétion excessive de certains solutés peut favoriser la lithiase.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 365 — La LEPOC est utilisée pour désagréger en petits fragments les calculs logés dans les calices rénaux

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La lithotritie extracorporelle peut fragmenter certains calculs rénaux ou urétéraux selon leur taille et localisation.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 366 — Un raccourcissement congénital du trajet intra-vésical de l'urètre permet à l'urine de refluer presque dans les bassinets pendant la miction

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le reflux vésico-urétéral concerne le trajet intravésical de l'uretère, non de l'urètre.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 367 — La cystite aiguë est causée généralement par Escherichia coli chez l'homme à la suite d'un rapport sexuel

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La cystite est surtout fréquente chez la femme ; E. coli domine et les rapports sont un facteur favorisant, sans en faire une IST.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 89–91, manifestations de la lithiase urinaire ; connaissances complémentaires pour la physiologie et les indications actuelles.

Question 368 — Pour éviter la stase urinaire et prévenir les récidives des infections urinaires, l'infirmier recommande au patient d'uriner souvent pour évacuer complètement la vessie

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Éviter de retenir les urines et favoriser une vidange vésicale correcte limite la stase.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 369 — Les abus des analgésiques favorisent les infections urinaires chroniques

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'abus d'antalgiques peut léser le rein ; ce n'est pas une cause directe générale d'infection urinaire chronique.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 370 — La pyonéphrose et la paranéphrite sont des complications redoutables des infections urinaires aiguës

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'infection peut se compliquer de pyonéphrose ou d'infection périrénale, surtout sur obstacle.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 98–104, infections urinaires et pyélonéphrite ; connaissances complémentaires en urologie.

Question 371 — Chez le garçon, une puberté précoce se définit par l'apparition de signes pubertaires après dix ans.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La puberté précoce du garçon débute avant neuf ans ; le mécanisme peut être central ou périphérique.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 372 — La dyspareunie est la sensation d’une douleur au moment des rapports sexuels

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La dyspareunie est une douleur génitale ou pelvienne associée aux rapports sexuels.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Escarres et sondage urinaire

Question 373 — Le processus de formation d’escarres est rapidement réversible :

A. Au stade 1

B. Au stade 1 et 2

C. Au stade 3 pour une personne dénutrie

D. Au stade 3 pour une personne obèse

Réponse : A

Explication : La levée précoce de la pression peut limiter les lésions au stade 1 ; une plaie constituée ne disparaît pas immédiatement.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 374 — Les signes cliniques locaux d’une escarre infectée sont :

A. Une odeur nauséabonde

B. Une modification des exsudats

C. Un saignement

D. La réapparition de fibrine alors que la plaie est en phase de bourgeonnement

Réponse : A, B, D

Explication : Odeur, exsudats modifiés et dégradation du lit de plaie peuvent évoquer une infection ; ils s’interprètent avec les autres signes.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 375 — Une escarre peut survenir en :

A. 2 heures

B. 24 heures

C. 2 jours

D. Après une longue durée d’alitement

Réponse : A

Explication : Une lésion de pression peut se constituer en quelques heures ; le délai varie avec les facteurs de risque.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 376 — Pour les stades de l’escarre, lesquelles des propositions suivantes sont l’ordre normal :

A. Stade 1 : rougeur de la peau ne disparaissant pas après levée de la pression

B. Stade 2 : perte de substance impliquant le tissu cutané avec ou sans décollement périphérique

C. Stade 3 : perte de substance impliquant l’épiderme et en partie le derme

D. Stade 4 : perte de substance pouvant impliquer l’os, les articulations, les muscles et les tendons

Réponse : A, D

Explication : Le stade 2 est une perte cutanée partielle ; le stade 3 est une perte de toute l’épaisseur cutanée, sans exposition osseuse.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 377 — Le pansement d’escarre est un pansement :

A. Propre et non stérile

B. Stérile

C. Nécessitant l’utilisation d’antiseptique

D. Qui ne nécessite pas l’utilisation d’antiseptique

Réponse : B, D

Explication : Utiliser une technique aseptique ; les antiseptiques locaux ne sont pas systématiques sur une plaie chronique.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 378 — Un malade en décubitus dorsal est prédisposé à faire :

A. Des infections urinaires

B. Des escarres

C. Des constipations

D. Des vomissements à répétition

Réponse : A, B, C

Explication : Immobilisation et dépendance favorisent escarres, constipation et complications urinaires.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 379 — Les complications de l’alitement prolongé sont :

A. L’infection urinaire

B. L’encombrement bronchique

C. La fonte musculaire

D. L’arythmie cardiaque

Réponse : A, B, C

Explication : Infection urinaire, encombrement respiratoire et fonte musculaire sont des complications possibles du décubitus prolongé.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 380 — Parmi les complications du décubitus on note :

A. Anorexie

B. Constipation

C. Infection urinaire

D. Atrophie musculaire

E. Toutes les réponses sont justes

Réponse : A, B, C, D

Explication : L’alitement peut entraîner diminution de l’appétit, constipation, complications urinaires et atrophie musculaire.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 381 — Quelles propositions décrivent une complication ou une erreur traumatique possible du sondage vésical ?

A. Rétention d’urine

B. Infections

C. Insuffisance rénale

D. Perforation de l’urètre

E. Perforation vésicale

F. Le gonflement du ballonnet dans l’urètre

Réponse : B, D, E, F

Explication : Infection et lésions urétrales ou vésicales sont possibles ; gonfler le ballonnet dans l’urètre est une erreur traumatique.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 382 — Le sondage vésical est contre-indiqué dans deux (02) des situations suivantes, lesquelles ?

A. Intervention sur le petit bassin, en chirurgie gynécologique et urologique

B. Suspicion de rupture traumatique de l'urètre

C. Incontinence de la personne âgée si elle est susceptible d'aggraver son état cutané

D. Présence d'une prothèse endo-urétrale ou sphincter artificiel

E. Rétention urinaire et prévention des rétentions urinaires

F. Surveillance des entrées et des sorties dans les services de soins

Réponse : B, D

Explication : Un traumatisme urétral suspect ou un sphincter artificiel impose un avis spécialisé avant tout sondage.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 383 — La pollakiurie est l’augmentation de la fréquence des mictions avec :

A. Diurèse perturbée

B. Diurèse augmentée

C. Diurèse diminuée

D. Diurèse conservée

Réponse : D

Explication : La pollakiurie augmente la fréquence des mictions, souvent de petit volume, sans augmentation obligatoire de la diurèse totale.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 384 — Dans l’oligurie, la diurèse est comprise entre

A. 100 ml et 900 ml par 24 heures

B. 100 ml et 700 ml par 24 heures

C. 100 ml et 500 ml par 24 heures

D. 100 ml et 300 ml par 24 heures

Réponse : C

Explication : L’oligurie adulte correspond usuellement à moins de 400–500 ml/24 h ou à un débit pondéral insuffisant.

Source : Connaissances complémentaires — urologie, physiologie rénale et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Sémiologie générale

Question 385 — La sémiologie respiratoire est une science qui étudie les cellules respiratoires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La sémiologie respiratoire étudie les signes et symptômes respiratoires, non les cellules.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 386 — La sémiologie analyse uniquement les manifestations physiques.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Elle analyse les manifestations fonctionnelles, physiques et générales, pas seulement physiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 387 — La sémiologie fonde le comportement médical.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’analyse des signes oriente le raisonnement et la conduite clinique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 388 — La nosologie est la classification des maladies.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La nosologie classe les maladies.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 389 — Une altération anatomopathologique peut contribuer à caractériser une maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une lésion anatomopathologique peut caractériser certaines maladies ; toutes n’exigent pas une lésion visible.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 390 — Un syndrome est défini par des critères cliniques, paracliniques et physiologiques.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un syndrome est un ensemble cohérent de manifestations ; les critères exacts dépendent du syndrome.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 391 — Lorsqu’une maladie est causée par un parasite, la cause est directe.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’agent parasitaire constitue une cause biologique directe de la maladie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 392 — La physiologie est l’étude de la modification des grandes fonctions au cours des maladies.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La physiologie étudie les fonctions normales ; la physiopathologie étudie leurs perturbations pathologiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 393 — L’étiopathologie décrit le mécanisme par lequel la cause aboutit à la maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’étiopathogénie décrit les mécanismes reliant une cause à la maladie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 394 — L’épidémiologie étudie les facteurs de risque d’une maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’épidémiologie étudie fréquence, répartition et déterminants des problèmes de santé.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 395 — Le symptôme décrit les plaintes exprimées par le malade.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un symptôme fonctionnel est une manifestation ressentie et rapportée par le patient.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 396 — Les symptômes objectifs sont révélés par l'interrogatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les signes objectifs sont constatés à l'examen ; l'interrogatoire recueille notamment les symptômes.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 397 — L'anorexie fait partie des signes généraux d'une maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La perte d'appétit fait partie des manifestations générales possibles.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 398 — L'examen clinique comporte 5 temps obligatoires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'examen s'adapte au contexte ; inspection, palpation, percussion et auscultation sont quatre techniques classiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 399 — La palpation est une technique qui consiste à frapper sur un autre doigt ou la main appuyée fermement sur le malade.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La description correspond à la percussion ; la palpation utilise le toucher.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 400 — La radioscopie est un examen complémentaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La radioscopie est un examen d’imagerie complémentaire utilisant les rayons X.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 401 — L’asthme est une cause extra-pulmonaire de la sémiologie des pathologies respiratoires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’asthme est une affection des voies aériennes, donc une cause bronchopulmonaire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 402 — L’expectoration est une sécrétion normale provenant de l’appareil respiratoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’expectoration est le rejet par la bouche de sécrétions sous-glottiques ; son extériorisation traduit habituellement une situation pathologique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 403 — La dilatation des bronches est une cause d’expectoration.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les bronchectasies peuvent provoquer une expectoration chronique abondante.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 404 — L’odeur permet d’identifier une expectoration.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’odeur est un caractère descriptif ; une odeur fétide peut orienter mais ne suffit pas au diagnostic.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 405 — La vomique est une forme d’expectoration caractérisée par le rejet brutal et massif d’une grande quantité de pus au cours d’un effort de toux.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La vomique est une évacuation brusque d’un contenu liquidien ou purulent dans les bronches puis par la bouche.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 406 — L’abcès hépatique est une cause de vomique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un abcès hépatique peut exceptionnellement se fistuliser à travers le diaphragme vers les bronches.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 407 — L’hémoptysie est une expectoration de sang au cours d’un effort de toux.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le sang provient de l’arbre respiratoire sous-glottique et est rejeté lors de la toux.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 408 — L’épistaxis est une cause d’hémoptysie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’épistaxis peut simuler une hémoptysie ; elle n’est pas une hémoptysie vraie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 409 — L’hémosialorrhée est une cause de vomique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’hémosialorrhée correspond à du sang mêlé à la salive ; elle ne définit pas une vomique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 410 — Rechercher les antécédents pulmonaires du client est un geste infirmier dans la prise en charge d’un malade présentant une hémoptysie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Antécédents, traitements, abondance et retentissement orientent l’évaluation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 411 — La dyspnée est une sensation subjective de gêne respiratoire, parfois accompagnée de modifications visibles de la ventilation.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La dyspnée est une sensation de gêne respiratoire ; elle peut exister même sans modification visible.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 412 — La fréquence respiratoire normale chez l'adulte est de 10-16 cycles par minute avec pause.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Chez l'adulte au repos, la fréquence usuelle est de 12 à 20/min, sans pause pathologique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 413 — Les bruits respiratoires associés peuvent contribuer à caractériser une dyspnée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le temps respiratoire, le rythme et les bruits ou le timbre associés contribuent à décrire une dyspnée.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 414 — Les troubles de la voix sont des signes d'accompagnement de la dyspnée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une dysphonie peut accompagner une obstruction laryngée et une dyspnée inspiratoire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 415 — La tachypnée est une respiration rapide et éventuellement superficielle.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La tachypnée est une augmentation de la fréquence respiratoire, parfois superficielle.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 416 — L'œdème de Quincke est une cause de dyspnée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un angiœdème laryngé peut obstruer les voies aériennes et constitue une urgence.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 417 — En cas de bradypnée, il faut mettre le malade en décubitus dorsal.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La position dépend de la conscience et de la respiration ; une bradypnée exige surtout évaluation urgente et soutien ventilatoire si nécessaire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 418 — Le médecin retrouve le tympanisme au cours de la palpation.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le tympanisme est recherché par percussion, non par palpation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 419 — Une fréquence respiratoire de 16/min suffit à affirmer la présence d'un tirage.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Un tirage traduit un effort ventilatoire ; il ne se déduit pas d'une fréquence de 16/min.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 420 — La dysphagie est une sensation douloureuse et de gêne à la déglutition.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La dysphagie est une difficulté de déglutition ; la douleur à la déglutition est une odynophagie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 421 — Lorsque la dysphagie est sélective, elle est plus ressentie sur les solides que sur les liquides.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une obstruction organique gêne souvent d'abord les solides puis les liquides.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 422 — L'anévrisme aortique volumineux est une cause de dysphagie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un anévrisme volumineux peut comprimer l'œsophage.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 423 — La mauvaise fermeture du cardia est une étiologie de reflux gastro-œsophagien.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'insuffisance de la barrière antireflux favorise le passage du contenu gastrique dans l'œsophage.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 424 — Dans la hernie hiatale par glissement, le cardia traverse le diaphragme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La jonction œsogastrique remonte au-dessus du diaphragme dans une hernie hiatale par glissement.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 425 — La colique néphrétique est une étiologie médicale à rechercher dans les atteintes de l'appareil digestif.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une colique néphrétique peut donner douleurs abdominales et vomissements et entre dans les diagnostics différentiels extradigestifs.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 426 — La sténose pylorique est une cause médicale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une sténose pylorique constitue un obstacle mécanique ; elle peut nécessiter une prise en charge endoscopique ou chirurgicale.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 427 — La polydipsie est une exagération de la sueur.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La polydipsie est une soif excessive ; l'excès de sueur est une hypersudation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 428 — La boulimie est une manifestation de la restriction alimentaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La boulimie comporte des épisodes de prises alimentaires excessives avec perte de contrôle.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 429 — La potomanie est le besoin de boire en grande abondance de l'eau.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La potomanie est une consommation excessive d'eau, souvent d'origine comportementale.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 430 — Le pyrosis est le reflux d'aliments avant leur digestion.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le pyrosis est une brûlure rétrosternale ascendante ; la remontée de contenu est une régurgitation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 431 — L'éructation est l'émission bruyante par la bouche d'aliments provenant de l'estomac.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'éructation est une émission de gaz par la bouche, non d'aliments.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 432 — La flatulence est la présence de gaz dans l'estomac avec sensation de ballonnement provoquant des renvois.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les gaz gastriques avec renvois relèvent de l'aérogastrie ; les flatulences sont des émissions de gaz intestinaux.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 433 — La pancréatite est une cause extradigestive des troubles de la digestion.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La pancréatite atteint un organe digestif ; elle n’est donc pas une cause extradigestive.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 434 — Le fécalome est un retard à l’évacuation des selles au-delà de 3 jours.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le fécalome est une accumulation de selles dures formant une masse, souvent rectale.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 435 — Un rejet de sang noir par la bouche au cours d’un effort de vomissement est une hématémèse.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le sang vomi peut être rouge ou noirâtre, digéré en « marc de café ».

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 436 — Le méléna est une émission de sang noir non digéré par l’anus de consistance goudron et d’odeur nauséabonde.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le méléna correspond à du sang digéré, noir, goudronneux et malodorant.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 437 — L’anxiété est un facteur favorisant des colopathies fonctionnelles.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Stress et anxiété peuvent moduler les symptômes des troubles digestifs fonctionnels.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 438 — La sémiologie analyse uniquement les manifestations physiques.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Elle analyse les manifestations fonctionnelles, physiques et générales, pas seulement physiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 439 — La sémiologie fonde le comportement médical.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’analyse des signes oriente le raisonnement et la conduite clinique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 440 — La nosologie est la classification des maladies.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La nosologie classe les maladies.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 441 — Une altération anatomopathologique peut contribuer à caractériser une maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une lésion anatomopathologique peut caractériser certaines maladies ; toutes n’exigent pas une lésion visible.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 442 — Un syndrome est défini par des critères cliniques, paracliniques et physiologiques.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un syndrome est un ensemble cohérent de manifestations ; les critères exacts dépendent du syndrome.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 443 — Lorsqu’une maladie est causée par un parasite, la cause est directe.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’agent parasitaire constitue une cause biologique directe de la maladie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 444 — La physiologie est l’étude de la modification des grandes fonctions au cours des maladies.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La physiologie étudie les fonctions normales ; la physiopathologie étudie leurs perturbations pathologiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 445 — L’étiopathologie décrit le mécanisme par lequel la cause aboutit à la maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’étiopathogénie décrit les mécanismes reliant une cause à la maladie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 446 — L’épidémiologie étudie les facteurs de risque d’une maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’épidémiologie étudie fréquence, répartition et déterminants des problèmes de santé.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 447 — Le symptôme décrit les plaintes exprimées par le malade.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un symptôme fonctionnel est une manifestation ressentie et rapportée par le patient.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 448 — Les symptômes objectifs sont révélés par l’interrogatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les signes objectifs sont constatés à l’examen ; l’interrogatoire recueille notamment les symptômes.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 449 — L’anorexie fait partie des signes généraux d’une maladie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La perte d’appétit fait partie des manifestations générales possibles.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 450 — L’examen clinique comporte 5 temps obligatoires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’examen s’adapte au contexte ; inspection, palpation, percussion et auscultation sont quatre techniques classiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 451 — La palpation est une technique qui consiste à frapper sur un autre doigt ou la main appuyée fermement sur le malade.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La description correspond à la percussion ; la palpation utilise le toucher.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 452 — La radioscopie est un examen complémentaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La radioscopie est un examen d’imagerie complémentaire utilisant les rayons X.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 453 — L’asthme est une cause extra-pulmonaire de la sémiologie des pathologies respiratoires.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’asthme est une affection des voies aériennes, donc une cause bronchopulmonaire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 454 — L’expectoration est une sécrétion normale provenant de l’appareil respiratoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’expectoration est le rejet par la bouche de sécrétions sous-glottiques ; son extériorisation traduit habituellement une situation pathologique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 455 — La dilatation des bronches est une cause d’expectoration.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les bronchectasies peuvent provoquer une expectoration chronique abondante.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 456 — L’odeur permet d’identifier une expectoration.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’odeur est un caractère descriptif ; une odeur fétide peut orienter mais ne suffit pas au diagnostic.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 457 — La vomique est une forme d’expectoration caractérisée par le rejet brutal et massif d’une grande quantité de pus au cours d’un effort de toux.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La vomique est une évacuation brusque d’un contenu liquidien ou purulent dans les bronches puis par la bouche.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 458 — L’abcès hépatique est une cause de vomique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un abcès hépatique peut exceptionnellement se fistuliser à travers le diaphragme vers les bronches.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 459 — L’hémoptysie est une expectoration de sang au cours d’un effort de toux.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le sang provient de l’arbre respiratoire sous-glottique et est rejeté lors de la toux.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 460 — L’épistaxis est une cause d’hémoptysie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’épistaxis peut simuler une hémoptysie ; elle n’est pas une hémoptysie vraie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 461 — L’hémosialorrhée est une cause de vomique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’hémosialorrhée correspond à du sang mêlé à la salive ; elle ne définit pas une vomique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 462 — Rechercher les antécédents pulmonaires du client est un geste infirmier dans la prise en charge d’un malade présentant une hémoptysie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Antécédents, traitements, abondance et retentissement orientent l’évaluation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 463 — La dyspnée est une sensation subjective de gêne respiratoire, parfois accompagnée de modifications visibles de la ventilation.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La dyspnée est une sensation de gêne respiratoire ; elle peut exister même sans modification visible.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 464 — La fréquence respiratoire normale chez l’adulte est de 10-16 cycles par minute avec pause.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Chez l’adulte au repos, la fréquence usuelle est de 12 à 20/min, sans pause pathologique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 465 — Les bruits respiratoires associés peuvent contribuer à caractériser une dyspnée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le temps respiratoire, le rythme et les bruits ou le timbre associés contribuent à décrire une dyspnée.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 466 — Les troubles de la voix sont des signes d’accompagnement de la dyspnée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une dysphonie peut accompagner une obstruction laryngée et une dyspnée inspiratoire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 467 — La tachypnée est une respiration rapide et éventuellement superficielle.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La tachypnée est une augmentation de la fréquence respiratoire, parfois superficielle.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 468 — L’œdème de Quincke est une cause de dyspnée.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un angiœdème laryngé peut obstruer les voies aériennes et constitue une urgence.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 469 — En cas de bradypnée, il faut mettre le malade en décubitus dorsal.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La position dépend de la conscience et de la respiration ; une bradypnée exige surtout évaluation urgente et soutien ventilatoire si nécessaire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 470 — Le médecin retrouve le tympanisme au cours de la palpation.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le tympanisme est recherché par percussion, non par palpation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 471 — Une fréquence respiratoire de 16/min suffit à affirmer la présence d’un tirage.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Un tirage traduit un effort ventilatoire ; il ne se déduit pas d’une fréquence de 16/min.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 472 — La dysphagie est une sensation douloureuse et de gêne à la déglutition.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La dysphagie est une difficulté de déglutition ; la douleur à la déglutition est une odynophagie.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 473 — Lorsque la dysphagie est sélective, elle est plus ressentie sur les solides que sur les liquides.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une obstruction organique gêne souvent d'abord les solides puis les liquides.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 474 — L'anévrisme aortique volumineux est une cause de dysphagie.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un anévrisme volumineux peut comprimer l'œsophage.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 475 — La mauvaise fermeture du cardia est une étiologie de reflux gastro-œsophagien.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'insuffisance de la barrière antireflux favorise le passage du contenu gastrique dans l'œsophage.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 476 — Dans la hernie hiatale par glissement, le cardia traverse le diaphragme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La jonction œsogastrique remonte au-dessus du diaphragme dans une hernie hiatale par glissement.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 477 — La colique néphrétique est une étiologie médicale à rechercher dans les atteintes de l'appareil digestif.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une colique néphrétique peut donner douleurs abdominales et vomissements et entre dans les diagnostics différentiels extradigestifs.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 478 — La sténose pylorique est une cause médicale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une sténose pylorique constitue un obstacle mécanique ; elle peut nécessiter une prise en charge endoscopique ou chirurgicale.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 479 — La polydipsie est une exagération de la sueur.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La polydipsie est une soif excessive ; l'excès de sueur est une hypersudation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 480 — La boulimie est une manifestation de la restriction alimentaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La boulimie comporte des épisodes de prises alimentaires excessives avec perte de contrôle.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 481 — La potomanie est le besoin de boire en grande abondance de l'eau.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La potomanie est une consommation excessive d'eau, souvent d'origine comportementale.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 482 — Le pyrosis est le reflux d'aliments avant leur digestion.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le pyrosis est une brûlure rétrosternale ascendante ; la remontée de contenu est une régurgitation.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 483 — L'éructation est l'émission bruyante par la bouche d'aliments provenant de l'estomac.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’éructation est une émission de gaz par la bouche, non d’aliments.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 484 — La flatulence est la présence de gaz dans l’estomac avec sensation de ballonnement provoquant des renvois.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les gaz gastriques avec renvois relèvent de l’aérogastrie ; les flatulences sont des émissions de gaz intestinaux.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 485 — La pancréatite est une cause extradigestive des troubles de la digestion.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La pancréatite atteint un organe digestif ; elle n’est donc pas une cause extradigestive.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 486 — Le fécalome est un retard à l’évacuation des selles au-delà de 3 jours.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le fécalome est une accumulation de selles dures formant une masse, souvent rectale.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 487 — Un rejet de sang noir par la bouche au cours d’un effort de vomissement est une hématémèse.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le sang vomi peut être rouge ou noirâtre, digéré en « marc de café ».

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 488 — Le méléna est une émission de sang noir non digéré par l’anus de consistance goudron et d’odeur nauséabonde.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le méléna correspond à du sang digéré, noir, goudronneux et malodorant.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 489 — L’anxiété est un facteur favorisant des colopathies fonctionnelles.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Stress et anxiété peuvent moduler les symptômes des troubles digestifs fonctionnels.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 490 — La bronchite aiguë comporte obligatoirement trois phases successives distinctes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La bronchite aiguë est classiquement décrite en phase sèche puis productive ; cette séquence n’est pas obligatoire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 491 — Pendant la phase catarrhale de la bronchite aiguë, la toux est sèche.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La phase productive ou humide comporte des expectorations ; la phase initiale est plutôt sèche.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 492 — L’état général est conservé dans la bronchite aiguë.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’état général est souvent relativement conservé dans une bronchite aiguë simple ; une altération importante fait rechercher autre chose.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 493 — Pendant la phase sèche de la bronchite aiguë, les douleurs sont rétrosternales.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La toux sèche peut s’accompagner de brûlures ou douleurs rétrosternales.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 494 — La surinfection bronchique est une séquelle de la bronchite aiguë.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une surinfection éventuelle est une complication, non une séquelle obligatoire.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 495 — La cyanose est un signe de gravité en cas de détresse respiratoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une cyanose centrale peut traduire une hypoxémie et nécessite une évaluation urgente.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 496 — Le diabète est une cause d'embolie pulmonaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'embolie pulmonaire résulte d'une obstruction artérielle, souvent par un thrombus veineux ; le diabète seul n'en est pas une cause directe.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 497 — L'insuffisance respiratoire chronique est une cause d'embolie pulmonaire

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'insuffisance respiratoire n'est pas une cause directe ; immobilisation et maladies associées peuvent accroître le risque thrombotique.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 498 — Le glomérule est une sorte de chambre de filtration du plasma

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le glomérule assure l'ultrafiltration initiale du plasma.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 499 — Une insuffisance rénale aiguë peut être consécutive à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les AINS peuvent réduire la perfusion rénale et provoquer une insuffisance rénale, surtout sur terrain à risque.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 500 — Les douleurs abdominales, les nausées et vomissements peuvent être des signes d'appel d'une insuffisance rénale chronique (IRC) :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Des symptômes digestifs peuvent accompagner une urémie avancée, mais sont peu spécifiques.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 501 — Un œdème est une infiltration séreuse dans divers tissus, en particulier le tissu sous-cutané et sous-muqueux, due à l'augmentation du liquide interstitiel, généralisé (ANASARQUE)

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'œdème est un excès de liquide interstitiel ; l'anasarque est un œdème généralisé important.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 502 — La cause d'une maladie est indirecte lorsqu'elle est :

A. Génétique

B. Chimique

C. Religieuse

D. Mécanique

Réponse : A

Explication : Une prédisposition génétique peut constituer un terrain favorisant ; la distinction directe/indirecte dépend du modèle étiologique enseigné.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 503 — Une expectoration est caractérisée par :

A. Sa consistance

B. Sa forme

C. Son origine

D. Sa topographie

Réponse : A

Explication : Quantité, couleur, consistance et odeur sont des caractères descriptifs des expectorations.

Source : Connaissances complémentaires — sémiologie médicale générale ; justification non localisée dans les cours consultés.

Questions cliniques et traitement du VIH

Question 504 — Les soins palliatifs consistent à procurer un mieux-être aux malades en phase terminale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie ; ils peuvent commencer bien avant la phase terminale.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 505 — L'onchocercose est transmise par la piqûre de la glossine.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'onchocercose est transmise par une simulie ; la glossine transmet les trypanosomes africains.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 506 — Le trismus est une contracture des muscles masticateurs bloquant l'ouverture de la mâchoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le trismus est une contracture des muscles masticateurs limitant l'ouverture de la bouche.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 507 — Il n'y a pas d'ulcère gastro-duodénal sans la bactérie Helicobacter.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Un ulcère peut être lié aux AINS ou à d'autres causes sans H. pylori.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 508 — L'arthrose est une maladie inflammatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'arthrose est principalement dégénérative, avec parfois une composante inflammatoire secondaire.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 509 — Le signe de KOPLIK se rencontre dans la rougeole. Il se définit comme une éruption sur la joue de petits points blancs.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le signe de Koplik correspond à de petits points blanchâtres sur la muqueuse jugale, non sur la peau de la joue.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 510 — Le Lasilix est un médicament susceptible d'entraîner une hyperkaliémie chez un patient.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le furosémide peut entraîner une hypokaliémie et impose une surveillance adaptée.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 79–80, diurétiques ; connaissances complémentaires pour la surveillance rénale et ionique.

Question 511 — Toute atteinte hépatique se termine toujours par une cirrhose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : De nombreuses hépatites guérissent ; la cirrhose n'est pas une évolution obligatoire.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 37–45, hépatites virales.

Question 512 — Une réduction modérée de l'apport en sel est à proscrire dans la prise en charge de l'HTA.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une réduction modérée du sel est recommandée ; « sans sel » ne signifie pas suppression absolue de tout sodium.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 80, mesures hygiénodiététiques de l'hypertension artérielle.

Question 513 — Le sondage urinaire se pratique en cas de traumatisme de l'urètre.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une suspicion de rupture urétrale contre-indique le sondage transurétral aveugle.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 514 — Les pathologies tropicales font reculer le développement socio-économique des régions.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Morbidité, mortalité et coûts des infections entravent les activités et le développement.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 515 — L'œdème des membres inférieurs est un signe majeur de l'insuffisance ventriculaire gauche.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les œdèmes périphériques orientent surtout vers une congestion droite ou une insuffisance globale.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 516 — La glossine et l'anophèle femelle sont les facteurs respectifs probables dans la transmission de la trypanosomiase et du paludisme humain.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La glossine transmet la trypanosomiase ; l'anophèle femelle transmet le paludisme.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 517 — Parmi les intérêts du TARV un seul ne fait pas partie

A. La réduction forte et prolongée de la réplication virale

B. La restauration et/ou la préservation de la fonction immunitaire

C. L'augmentation des partenaires sexuels

D. La réduction du nombre de maladies et de décès liés au VIH

E. La réduction du nombre de nouvelles contaminations

Réponse : C

Explication : Le traitement ne justifie pas la multiplication des expositions ; les autres propositions décrivent ses bénéfices.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 518 — Dans la PEC du VIH il existe en général :

A. Deux classes thérapeutiques

B. Trois classes thérapeutiques

C. Quatre classes thérapeutiques

D. Plus de quatre classes d'ARV peuvent être distinguées dans la classification actuelle.

Réponse : D

Explication : Il existe plus de quatre classes d'ARV ; la question doit préciser la classification et l'époque du cours.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 519 — En Côte d'Ivoire l'on utilise dans la PEC des PVVIH :

A. Deux classes thérapeutiques

B. Trois classes thérapeutiques

C. Quatre classes thérapeutiques

D. La disponibilité nationale doit être vérifiée dans les directives et le formulaire datés.

Réponse : D

Explication : Le nombre de classes effectivement disponibles dépend des directives et de l'année ; aucune réponse nationale actuelle ne peut être déduite du seul énoncé.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 520 — Zidovudine donne comme abréviation :

A. AZT

B. 3TC

C. ABC

Réponse : A

Explication : La zidovudine s'abrège AZT ou ZDV.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 521 — Lamivudine donne comme abréviation :

A. AZT

B. ABC

C. 3TC

Réponse : C

Explication : La lamivudine s'abrège 3TC.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 522 — Les inhibiteurs nucléosidiques de la Réverse Transcriptase sont :

A. Lamivudine

B. Ténofovir

C. Abacavir

D. Efavirenz

Réponse : A, B, C

Explication : Lamivudine, ténofovir et abacavir appartiennent aux inhibiteurs nucléos(t)idiques ; l'éfavirenz est non nucléosidique.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 523 — Médicaments antirétroviraux non disponibles en Côte d'Ivoire sont :

A. Inhibiteurs de la reverse transcriptase

B. Inhibiteurs d'entrée et de fusion

C. Inhibiteurs de la protéase

D. Inhibiteurs de l'intégrase

E. La disponibilité se vérifie dans un formulaire national daté, sans exclusion universelle d'une classe.

Réponse : E

Explication : La disponibilité nationale doit être vérifiée dans le formulaire et les directives datés ; elle ne se déduit pas de la classe seule.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 524 — Chez les patients VIH1 naïfs sans facteur de comorbidité le schéma préférentiel est :

A. TDF + 3TC + AZT

B. ABC + 3TC + LPV/r

C. TDF + 3TC + EFV

D. Un schéma actif fondé sur les directives actualisées, souvent à base de dolutégravir chez l’adulte éligible.

Réponse : D

Explication : Un schéma à base de dolutégravir, souvent TDF + 3TC + DTG chez l’adulte éligible, a remplacé les anciens choix préférentiels.

Source : NIH, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV, rubrique What to Start. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/what-start-initial-combination-regimens

Question 525 — Chez la femme enceinte VIH1 naïve sans facteur de comorbidité le schéma préférentiel est :

A. TDF + 3TC + EFV

B. TDF + 3TC + AZT

C. ABC + 3TC + LPV/r

D. Un schéma actif fondé sur les directives actualisées, souvent à base de dolutégravir chez l’adulte éligible.

Réponse : D

Explication : La grossesse ne contre-indique pas par principe le dolutégravir ; le schéma doit suivre les directives nationales et le terrain.

Source : NIH, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV, rubrique What to Start. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/what-start-initial-combination-regimens

Question 526 — L’observance du TARV se définit comme étant :

A. Capacité d’une personne à prendre un traitement selon la posologie

B. Capacité d’une personne à prendre un traitement selon une prescription donnée (posologie, horaire, repas)

C. Capacité d’une personne à prendre un traitement selon une prescription donnée l’horaire

Réponse : B

Explication : L’observance englobe doses, horaires et conditions de prise prescrites.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 527 — Chez les patients VIH1 et 2 naïfs sans facteur de comorbidité le schéma préférentiel est :

A. TDF + 3TC + EFV

B. TDF + 3TC + AZT

C. ABC + 3TC + LPV/r

D. Un schéma actif fondé sur les directives actualisées, souvent à base de dolutégravir chez l’adulte éligible.

Réponse : D

Explication : Le VIH-2 est naturellement résistant aux INNTI comme l’éfavirenz ; choisir un schéma actif adapté aux directives.

Source : NIH, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV, rubrique What to Start. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/what-start-initial-combination-regimens

Question 528 — Entourez les cas de référence dans la PEC des PVVIH :

A. Patient cliniquement stable sans complication ni comorbidité

B. Bonne tolérance du traitement, sans signe d’alerte

C. Anémie avec taux d’hémoglobine < 8 g/dl

D. Troubles neurologiques, rénaux et métaboliques (diabète)

Réponse : C, D

Explication : Une anémie sévère et des troubles neurologiques, rénaux ou métaboliques demandent une évaluation médicale et, selon la gravité, une référence.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 529 — L’observance du TARV fait appel à :

A. La compliance du patient

B. La conformité du patient

C. La compliance ou conformité du patient

D. A B C

Réponse : C

Explication : Dans le vocabulaire de ce questionnaire, compliance et conformité renvoient au respect du traitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 530 — Causes médicamenteuses liées à la mauvaise observance TARV :

A. Nombre par prise

B. Insuffisance d’information sur la maladie et le traitement

C. Non adhésion aux soins et traitements ARV

D. Contraintes horaires

Réponse : A, D

Explication : Charge en comprimés et contraintes horaires sont des facteurs médicamenteux.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Infections sexuellement transmissibles questions vrai ou faux

Question 531 — L’on définit trois approches de prise en charge des IST.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les trois approches classiquement enseignées sont clinique, étiologique et syndromique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 532 — L’approche étiologique peut n’être pas basée sur les données de l’interrogatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L’approche étiologique intègre l’histoire clinique et les examens de laboratoire pour identifier l’agent.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 533 — Il est important de regarder le patient lors de l’interrogatoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le contact visuel respectueux favorise l’écoute, selon la culture et la situation.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 534 — L’annonce aux partenaires est obligatoire devant toute IST.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La notification aux partenaires est encouragée avec consentement, confidentialité et sécurité, sans divulgation imposée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 535 — L’approche étiologique est basée sur les données de l’interrogatoire, l’examen physique et des tests de laboratoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Elle combine données cliniques et identification de l’agent responsable.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 536 — L’herpès génital est une IST d’origine virale.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’herpès génital est causé par les virus HSV.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 537 — Chacune des approches a des avantages et des inconvénients.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Chaque stratégie présente des avantages et des limites selon les ressources et les infections.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 538 — Le nombre exact de syndromes IST retenus dans un programme national doit être vérifié dans les directives datées du programme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les listes peuvent varier selon les éditions et les catégories retenues ; ne pas extrapoler un nombre sans référentiel.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 539 — La conjonctivite n’est pas un syndrome IST identifié en Côte d’Ivoire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La conjonctivite néonatale est classiquement incluse dans les syndromes à rechercher en lien avec les IST maternelles.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 540 — Tout écoulement vaginal est toujours pathologique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Des sécrétions vaginales physiologiques existent ; un écoulement n’est pas toujours pathologique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 541 — La double protection consiste à utiliser des moyens pour se protéger seulement contre les IST.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La double protection vise à la fois grossesse non désirée et IST, dont le VIH.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 542 — La double protection a l’avantage d’améliorer la santé des individus et des familles.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La prévention des grossesses non désirées et des infections améliore la santé familiale.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 543 — La voie sexuelle n’est pas le premier mode de transmission de l’infection à VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La voie sexuelle est une voie majeure de transmission ; son poids relatif dépend de la population.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 544 — La transfusion par le sang non testé est une voie de transmission du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un produit sanguin contaminé peut transmettre le VIH ; le dépistage des dons est indispensable.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 545 — La transmission verticale du VIH est le passage du virus du VIH de la mère infectée par le VIH à son enfant.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La transmission peut avoir lieu pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 546 — Le lait maternel est un liquide biologique à risque élevé de transmission du virus du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le lait peut transmettre le VIH ; le risque diminue fortement avec un TARV maternel efficace et un suivi adapté.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 547 — La sueur est un déterminant de transmission du virus du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La sueur n’est pas une voie de transmission du VIH dans les contacts habituels.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 548 — L’anatomie de la femme n’est pas un déterminant de la propagation du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La surface muqueuse exposée et les microlésions peuvent influencer la vulnérabilité ; aucun facteur anatomique ne suffit seul.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 549 — L’infection à VIH est une maladie qui évolue en trois stades.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : On décrit souvent primo-infection, phase chronique et stade avancé ; les classifications cliniques utilisent d’autres découpages.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 550 — La classification CDC ne combine pas les signes cliniques et le taux de lymphocytes CD4.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La classification CDC historique croise catégories cliniques et immunologiques.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 551 — Il est important devant toute IST de penser à une co-infection avec le VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Proposer un dépistage VIH avec information et consentement fait partie de la prise en charge des IST.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 552 — La solution chlorée (eau de Javel) diluée à 0,5% est une méthode pour détruire le virus du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une solution chlorée adaptée inactive le VIH sur les surfaces ; ce n’est jamais un produit à appliquer sur les muqueuses.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 553 — Le sororat est un déterminant de la propagation du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Des unions successives sans prévention peuvent favoriser la transmission ; le risque dépend des expositions, non du seul nom de la pratique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 554 — La piqûre d’insectes est un déterminant de la propagation du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les moustiques et autres insectes ne transmettent pas le VIH.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 555 — L’inconscience est un déterminant de la propagation du VIH chez les jeunes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une faible perception du risque peut favoriser des rapports non protégés ; éviter les jugements stigmatisants.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 556 — L’infection à VIH a un impact sur la baisse de la productivité.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La maladie non contrôlée peut réduire la capacité de travail ; le traitement efficace améliore ce pronostic.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 557 — Le sperme n’est pas un liquide biologique à haut risque dans la transmission du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le sperme peut transmettre le VIH lorsque la charge virale n’est pas supprimée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 558 — Le SIDA est une déficience innée et héréditaire.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le sida est un syndrome d’immunodéficience acquise ; il n’est pas une maladie héréditaire.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 559 — Une durée fixe de trois à sept jours permet d’affirmer la contagiosité du VIH dans tout sang séché.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La survie expérimentale ne définit pas une durée universelle de contagiosité du sang séché ; appliquer les précautions standard.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 560 — Le VIH 2 sévit le plus en Afrique de l’Ouest.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le VIH-2 est historiquement concentré en Afrique de l’Ouest.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 561 — La gonococcie est une cause fréquente de l’écoulement urétral.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le gonocoque peut provoquer un écoulement urétral purulent ; d’autres agents sont possibles.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 562 — L’annonce vise à interrompre la chaîne de transmission des IST.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Informer et proposer prise en charge aux partenaires aide à prévenir les nouvelles transmissions et les réinfections.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 563 — Un préservatif bien utilisé est efficace contre les grossesses à risque et les IST/VIH/SIDA.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un préservatif utilisé correctement réduit les risques ; il n’assure pas une protection absolue contre toutes les IST.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 564 — La double protection a l’avantage de renforcer les relations au sein de la famille.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La double protection peut favoriser sécurité et communication du couple ; ce n’est pas une garantie relationnelle.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 565 — L’apprentissage de l’utilisation des méthodes est une limite à la double protection.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une technique correcte nécessite apprentissage et accès aux moyens ; cette contrainte peut être surmontée par le conseil.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 566 — La double protection n’est pas l’affaire d’une seule personne, c’est une question du couple.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La coopération du partenaire est utile ; chacun conserve le droit à une prévention autonome.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 567 — L’utilisation des mêmes ustensiles de cuisine est un déterminant de transmission du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le partage d’ustensiles ne transmet pas le VIH.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 568 — La primo-infection dure en moyenne dix mois.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La primo-infection apparaît généralement dans les semaines suivant l’exposition et ne dure pas en moyenne dix mois.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 569 — Les femmes dans une phase avancée de la maladie devraient éviter toute grossesse.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La décision reproductive doit rester libre ; une maladie avancée nécessite traitement et conseil individualisé avant une grossesse.

Source : OMS, VIH et sida, fiche du 27 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Question 570 — L’analphabétisme n’est pas un déterminant de propagation du VIH chez la femme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les difficultés d’accès à l’information peuvent accroître la vulnérabilité ; elles ne constituent pas une voie biologique de transmission.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 571 — Le mimétisme est un déterminant de propagation du VIH chez les jeunes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La pression du groupe peut favoriser des comportements à risque, selon le contexte.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 572 — Le formol à 0,5 % est le désinfectant courant de première intention à recommander pour prévenir la transmission du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le formol ne doit pas être retenu comme désinfectant courant ; utiliser un produit et un temps de contact validés.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 573 — Une femme enceinte infectée au VIH est exposée au risque d’avortement au premier trimestre.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une infection mal contrôlée peut accroître certains risques obstétricaux ; un TARV efficace et le suivi améliorent le pronostic.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 574 — L’incapacité à négocier le préservatif est un déterminant de propagation du VIH chez la femme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les difficultés à négocier une protection augmentent l’exposition potentielle.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Infections sexuellement transmissibles questions à choix multiples

Question 575 — Dans les IST la prévention vise uniquement à la réduction des contacts sexuels à risque.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La prévention inclut aussi dépistage, traitement, vaccination lorsqu’elle existe et prise en charge des partenaires.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 576 — Dans les IST la prévention primaire comporte le changement de comportement.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Information et comportements protecteurs participent à la prévention primaire.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 577 — La prévention secondaire est la prise en charge précoce des cas d’IST.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le diagnostic et le traitement précoces relèvent de la prévention secondaire.

Source : OMS, VIH et sida, fiche du 27 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Question 578 — Le traitement précoce et efficace des cas d’IST vise à limiter le nombre de nouveaux cas.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Traiter rapidement réduit durée de contagiosité et risque de propagation.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 579 — Toute transfusion sanguine doit se faire avec du sang testé.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les dons doivent être qualifiés et contrôlés selon les normes ; aucun test ne supprime tout risque résiduel.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 580 — Dans la période de latence la sérologie VIH est positive.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Après la séroconversion, la sérologie demeure généralement positive pendant la phase chronique asymptomatique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 581 — SIDA est le sigle du syndrome d'immunodéficience acquise.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : SIDA signifie syndrome d'immunodéficience acquise.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 582 — Dans le VIH le mode de transmission le plus courant est la voie sexuelle.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La transmission sexuelle est majeure, notamment dans le contexte épidémiologique ivoirien.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 583 — En milieu de soins, des mesures d'hygiène doivent être prises pour prévenir les AES.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Matériel sécurisé, précautions standard et formation réduisent les AES.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 584 — Tout écoulement vaginal est toujours pathologique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Il existe des sécrétions physiologiques ; rechercher les caractères anormaux et le contexte.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 585 — L'infection au VIH 2 entraîne une progression rapide vers le stade SIDA.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le VIH-2 progresse en moyenne plus lentement que le VIH-1 sans traitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 586 — L'infection au VIH 1 se transmet moins facilement.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le VIH-1 est généralement plus transmissible que le VIH-2 en l’absence de traitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 587 — Le VIH résiste à l’alcool à 70° pendant 15 minutes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le VIH enveloppé est sensible aux désinfectants adaptés, dont l’alcool ; respecter les indications et temps de contact du produit.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 588 — Le liquide amniotique est un liquide biologique à risque élevé de transmission de germe.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le liquide amniotique fait partie des liquides à considérer dans l’évaluation d’une exposition professionnelle.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 589 — La salutation est un déterminant de transmission du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les salutations ordinaires et poignées de main ne transmettent pas le VIH.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 590 — L’utilisation des mêmes toilettes, douches, est un déterminant de transmission du VIH.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le partage des toilettes ou douches n’est pas une voie de transmission.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 591 — L’approche étiologique est basée sur les données de :

A. L’interrogatoire

B. L’examen physique

C. Tests de laboratoire

D. A + B + C

Réponse : A, B, C

Explication : L’identification étiologique s’appuie sur entretien, examen et laboratoire.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 592 — L’approche syndromique est basée sur

A. L’identification de groupes de signes et de symptômes

B. Tests de laboratoire

C. L’interrogatoire

D. A + B + C

Réponse : A, C

Explication : La stratégie syndromique traite un ensemble de symptômes et signes sans attendre l’identification biologique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 593 — Entourez deux limites de l’approche clinique

A. Erreur de diagnostic et de traitement

B. Tests peu accessibles

C. Ignore les infections mixtes

D. Traitement différé

Réponse : A, C

Explication : L’approche clinique seule peut manquer des infections mixtes et se tromper d’agent.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 594 — Entourez deux avantages de l’approche étiologique

A. Précision diagnostique

B. Traitement spécifique

C. Soulagement rapide

D. Applicable partout

Réponse : A, B

Explication : L’approche étiologique améliore la précision et permet un traitement ciblé.

Source : OMS, VIH et sida, fiche du 27 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Question 595 — Quels avantages la stratégie syndromique peut-elle apporter dans un contexte de ressources limitées ?

A. Précision diagnostique

B. Traitement spécifique

C. Applicable partout

D. Traitement immédiat sans attendre le laboratoire.

Réponse : C, D

Explication : La stratégie syndromique est utilisable sans laboratoire et permet un traitement immédiat ; les coûts varient selon le contexte.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 596 — Entourez deux avantages de la double protection

A. Améliore la santé de l’individu, du couple et de la famille

B. Abstinence totale

C. Diminue les dépenses liées aux maladies et aux grossesses non désirées

D. Préservatif seul

Réponse : A, C

Explication : Elle réduit le risque d'infection et de grossesse non désirée ainsi que leurs conséquences sanitaires et financières.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 597 — Entourez les liquides biologiques à risque élevé de transmission du virus

A. Sang

B. Sperme

C. Sécrétions vaginales

D. A + B + C

Réponse : A, B, C

Explication : Sang, sperme et sécrétions vaginales sont des liquides impliqués dans la transmission.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 598 — Quels éléments peuvent augmenter le risque de transmission sexuelle du VIH ?

A. Microlésions génitales lors d'un rapport.

B. Transfusion avec du sang non testé

C. Charge virale élevée chez le partenaire infecté.

D. Excision, circoncision

Réponse : A, C

Explication : Les microlésions et une charge virale élevée augmentent le risque ; le premier rapport n'est pas à lui seul un critère biologique universel.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 599 — Entourez les déterminants de non-transmission du VIH

A. Piqûres d'insectes : mouches, moustiques

B. Natation dans la même piscine

C. Utilisation des mêmes moyens de transport

D. A + B + C

Réponse : A, B, C

Explication : Insectes, piscine et transports partagés ne sont pas des voies de transmission du VIH.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 600 — Selon la classification de l'OMS 1990 le VIH évolue en :

A. Deux stades

B. Trois stades

C. Quatre stades

Réponse : C

Explication : La classification clinique OMS adulte comporte quatre stades.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 601 — Quelles situations relèvent directement d'un risque de transmission sanguine du VIH ?

A. Transfusion avec du sang non testé

B. Rapports non protégés pendant les menstrues

C. Toxicomanie avec échange de seringues

D. Microtraumatismes lors des rapports

Réponse : A, C

Explication : Sang contaminé et partage de matériel d'injection relèvent de la voie sanguine ; les autres expositions sont sexuelles.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 602 — Modes de transmission du VIH par contact sexuel non protégé s'élève à un taux de :

A. 60 %

B. 70 %

C. 90 %

D. Impossible de choisir une proportion sans préciser le pays, l'année et la population.

Réponse : D

Explication : Une proportion de 60, 70 ou 90 % nécessite pays, période et source ; aucune n'est universelle.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie, prévention du VIH et santé sexuelle ; justification non localisée dans les cours consultés.

Maladies infectieuses

Question 603 — Les maladies infectieuses sont dues à des agents microscopiques non vivants

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les agents infectieux comprennent bactéries, virus, champignons et parasites ; l'énoncé « tous non vivants » est faux.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 604 — L'agent responsable de la fièvre typhoïde est un virus

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La typhoïde est due à Salmonella Typhi, une bactérie.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 605 — Le réservoir des germes peut être l'homme sain

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un porteur asymptomatique peut héberger et transmettre certains agents.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 606 — Les animaux peuvent héberger les germes et les transmettre à l'homme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Les animaux peuvent constituer des réservoirs de zoonoses.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 607 — Le milieu naturel constitue l'habitat de certains germes

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Eau, sol ou autres milieux peuvent être des réservoirs selon le germe.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 608 — La salive est un produit contaminant dans les maladies infectieuses

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La salive peut transmettre certaines infections ; ce n'est pas vrai pour toutes les maladies.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 609 — La transmission indirecte peut se faire par l'intermédiaire de l'eau

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L'eau contaminée peut servir de véhicule de transmission.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 610 — L'incubation constitue le début de la maladie, marquée par les premiers symptômes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'incubation précède les symptômes ; l'invasion correspond aux premiers signes.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 611 — La fièvre typhoïde est une maladie contagieuse liée au péril fécal

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La transmission est féco-orale, par eau, aliments ou mains contaminés.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 612 — Le réservoir de germe de la fièvre typhoïde est strictement humain

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Le réservoir de Salmonella Typhi est humain, malade ou porteur.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 613 — Le méléna est une complication cardiaque dans la fièvre typhoïde

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le méléna traduit une hémorragie digestive, non une complication cardiaque.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 614 — L’homme malade est le seul réservoir de virus du choléra

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le choléra est bactérien et comporte des réservoirs humains et environnementaux aquatiques.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 615 — Le manque d’hygiène alimentaire et fécale est un facteur favorisant le choléra.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Eau insalubre et défaut d’assainissement favorisent la transmission féco-orale.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 616 — La déshydratation légère dans le choléra entraîne le pli cutané

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Un pli cutané franc évoque une déshydratation plus marquée ; l’appréciation combine plusieurs signes.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 617 — La prophylaxie collective dans le choléra fait appel à l’assainissement du milieu

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Eau potable, assainissement et hygiène sont essentiels à la prévention collective.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 618 — Le tétanos céphalique de Rose succède à une plaie de l’orbite

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le tétanos céphalique de Rose suit une plaie de la tête ; la forme ophtalmoplégique de Worms est classiquement liée à une plaie orbitaire.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 619 — Le tétanos néonatal est favorisé par la section du cordon ombilical avec un instrument souillé.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une section ou des soins du cordon contaminés peuvent inoculer les spores du tétanos.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 620 — La rougeole est une maladie cosmopolite

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La rougeole existe dans de nombreuses régions du monde.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 621 — La rougeole sévit sous un mode endémo-épidémique en zone rurale

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Des foyers et épidémies sont possibles en milieu rural, selon l’immunité et la couverture vaccinale.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 622 — La rougeole sévit sous un mode endémo-épidémique en zone urbaine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Des foyers et épidémies sont aussi possibles en milieu urbain ; aucun milieu n’exclut la transmission.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 623 — Le diagnostic de la rougeole est essentiellement clinique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La clinique évoque le diagnostic ; la confirmation biologique est importante pour la surveillance et les cas suspects.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 624 — Le signe de Koplik est le signe pathognomonique de la varicelle.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le signe de Koplik est caractéristique de la rougeole, non de la varicelle.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 625 — La déshydratation est une complication générale de la rougeole

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Fièvre, diarrhée et difficultés alimentaires peuvent provoquer une déshydratation.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 626 — Les convulsions sont les signes nerveux de la rougeole.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Des convulsions peuvent accompagner fièvre ou complications neurologiques ; elles ne sont pas systématiques.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 627 — La maladie infectieuse manifeste se définit, parmi ces formulations, comme :

A. L’ensemble des manifestations cliniques résultant de la pénétration des micro-organismes pathogènes vivants dans l’organisme humain

B. L’ensemble des manifestations cliniques et biologiques résultant de la pénétration des micro-organismes pathogènes vivants dans l’organisme humain

C. L’ensemble des manifestations biologiques résultant de la pénétration des micro-organismes pathogènes vivants dans l’organisme humain

Réponse : B

Explication : Une infection implique pénétration et multiplication d’un agent ; elle peut rester asymptomatique, contrairement à une maladie infectieuse manifeste.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 628 — Les responsables des maladies infectieuses sont :

A. Les virus

B. Les mouches

C. Les champignons microscopiques responsables de mycoses.

D. Les moustiques

Réponse : A, C

Explication : Virus et champignons peuvent provoquer des infections ; mouches et moustiques sont principalement des vecteurs.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 629 — La virulence, c’est la propriété qu’ont les germes à :

A. Résister à la phagocytose

B. Se multiplier dans l’organisme

C. Se multiplier et à résister à la phagocytose

Réponse : C

Explication : La virulence est le degré de pouvoir pathogène ; multiplication et échappement aux défenses y contribuent.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 630 — Dans les produits contaminants les selles peuvent entraîner :

A. Poliomyélite

B. La fièvre typhoïde

C. L’oreillon

D. La coqueluche

Réponse : A, B

Explication : Poliomyélite et typhoïde se transmettent par voie féco-orale.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 631 — On distingue dans l’ordre plusieurs périodes dans l’évolution d’une maladie infectieuse :

A. Invasion, incubation et phase d’état

B. Phase d’état, invasion et incubation

C. Incubation, invasion et phase d’état

Réponse : C

Explication : La séquence classique est incubation, invasion puis phase d’état, avant déclin et convalescence.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 632 — La période d’état d’une maladie infectieuse représente :

A. La période de la maladie entièrement constituée où les signes de la maladie sont présents

B. Le début de la maladie, marquée par les premiers symptômes de la maladie

C. La période qui s’étend du jour de la pénétration du germe dans l’organisme jusqu’au jour où se manifestent les premiers signes de la maladie

Réponse : A

Explication : La phase d’état correspond au tableau clinique constitué.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 633 — Dans les complications cardio-vasculaires de la fièvre typhoïde l’on rencontre :

A. Une myocardite

B. Une cholécystite

C. Une phlébite

D. Rectorragie

Réponse : A, C

Explication : Myocardite et complications veineuses sont possibles ; cholécystite et rectorragie sont digestives.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 634 — La prophylaxie individuelle de la fièvre typhoïde repose sur les mesures hygiéno-diététiques qui sont :

A. Laver les mains avant chaque repas

B. La construction, l’utilisation et l’entretien de latrines

C. L’assainissement du milieu

D. Laver les légumes et les fruits consommés crus

Réponse : A, D

Explication : L’hygiène des mains et des aliments relève des comportements individuels.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 635 — La prophylaxie collective de la fièvre typhoïde repose sur la lutte contre le péril fécal par

A. Laver les mains avant chaque repas

B. La construction, l’utilisation et l’entretien de latrines

C. L’assainissement du milieu

D. Laver les légumes et les fruits consommés crus

Réponse : B, C

Explication : Assainissement et gestion des excreta relèvent de la prévention collective.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 636 — Les déshydratations moyennes entraînent :

A. Une perte hydrique < 5% du poids corporel

B. Une perte hydrique comprise entre 5% et 10% du poids corporel

C. Une perte hydrique > à 10% du poids corporel

Réponse : B

Explication : Dans cette classification pondérale pédagogique, la perte est de 5 à 10 % ; les critères cliniques restent essentiels.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 637 — Dans la présentation pédagogique classique, combien d'éléments sont associés : porte d'entrée, contamination par les spores, immunisation insuffisante ?

A. Deux conditions

B. Trois conditions

C. Quatre conditions

Réponse : B

Explication : Le cours classique retient porte d'entrée, contamination par les spores et immunisation insuffisante ; ce n'est pas un critère diagnostique numérique autonome.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 638 — Parmi les conditions pour qu'il y ait tétanos une est de trop

A. L'existence d'une porte d'entrée

B. La naissance dans une maternité

C. L'absence de vaccination efficace

D. La contamination de la porte d'entrée par les spores de Clostridium tetani

Réponse : B

Explication : Naître en maternité ne constitue pas une condition de survenue du tétanos.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 639 — Le réservoir de germes de la rougeole est :

A. L'homme malade

B. Le porteur sain

C. Le personnel soignant

Réponse : A

Explication : L'être humain infecté constitue le réservoir du virus rougeoleux, y compris avant l'éruption.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 640 — Le virus de la rougeole se transmet par les éléments suivants sauf un

A. Les gouttelettes de salive émises par la toux dans l'air

B. Les urines émises dans les toilettes

C. Par contact direct avec les sécrétions du nez des personnes infectées

D. Par contact direct avec les sécrétions de la gorge des personnes infectées

Réponse : B

Explication : La rougeole se transmet surtout par voie aérienne, non par les urines dans les toilettes.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 641 — La chronologie de l’éruption de la rougeole est descendante :

A. De la tête aux pieds

B. Du thorax aux pieds

C. De l’abdomen aux pieds

Réponse : A

Explication : L’éruption commence habituellement au visage puis descend vers le tronc et les membres.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 642 — On distingue trois niveaux de complications dans la rougeole sauf un :

A. Les complications générales

B. Les complications liées à l’environnement

C. Les complications liées au virus

D. Les complications de surinfection

Réponse : B

Explication : Le cours distingue complications générales, virales et surinfections ; l’environnement est un facteur de contexte.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situations cliniques diverses

Question 643 — Quel signe général, parmi ces choix peu spécifiques, peut accompagner une insuffisance hépatique ?

A. Prostration

B. Sudation

C. Céphalée

D. Hyperthermie

Réponse : A

Explication : La prostration est peu spécifique ; une insuffisance hépatique se suspecte surtout devant ictère, troubles de coagulation ou encéphalopathie.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 46–56, cirrhose et ascite ; connaissances complémentaires pour les gestes infirmiers.

Question 644 — La numération formule sanguine (NFS) renseigne sur :

A. Les maladies cardiaques

B. Les maladies du sang

C. Les maladies hépatiques

D. Les maladies infectieuses

Réponse : B, D

Explication : La NFS décrit les lignées sanguines et peut orienter vers une infection ; elle ne pose pas seule un diagnostic étiologique.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 645 — Dans toutes les maladies infectieuses, l’homme malade est l’unique réservoir de germes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Sans maladie précisée, l’homme malade ne peut être déclaré réservoir unique.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 646 — La phase d'état de la bilharziose à Schistosoma mansoni est dominée par les manifestations intestinales et hépatospléniques :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : S. mansoni peut entraîner des manifestations intestinales et une atteinte hépatosplénique.

Source : Medecine L1.pdf, p. 74–87, introduction à la parasitologie ; connaissances complémentaires pour la clinique et les vecteurs.

Question 647 — Les tréponématoses sont un groupe d'affections parasitaires causées par des tréponèmes :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Les tréponématoses sont bactériennes.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 648 — Dans une dysenterie bacillaire la transmission se fait de façon directe ou indirecte :

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La transmission féco-orale peut être directe ou indirecte.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 649 — La prescription la plus adaptée à une crise d’asthme comporte

A. L’adrénaline en injection sous-cutanée

B. Les bêta 2 sympathomimétiques en aérosol doseur

C. Une injection IV de théophylline

D. Une céphalosporine

Réponse : B

Explication : Un bronchodilatateur bêta-2 inhalé est adapté à la crise, avec corticoïdes et autres mesures selon la gravité.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 44–47, médicaments de l’appareil respiratoire ; connaissances complémentaires en pneumologie pour les signes cliniques.

Question 650 — Parmi les examens suivants lequel est indiqué dans l'ulcère gastro-duodénal ?

A. Expectoration spontanée

B. Tubage gastrique

C. Fibroscopie

Réponse : C

Explication : La fibroscopie visualise les ulcères et permet des prélèvements.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 651 — La sténose pyloro-bulbaire se traduit par

A. Des vomissements bilieux, puis fécaloïdes

B. Des vomissements bilieux fréquents et répétés

C. Des vomissements d'emblée fécaloïdes

D. Vomissements alimentaires tardifs de stase, habituellement non bilieux.

Réponse : D

Explication : La sténose pylorique donne surtout des vomissements alimentaires tardifs, non bilieux.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 70–77, ulcère gastroduodénal ; connaissances complémentaires pour les définitions anatomiques et les urgences.

Question 652 — Parmi les localisations de la tuberculose suivantes, cochez les les réponses exactes justes

A. Tuberculose osseuse contagieuse

B. Tuberculose rénale ou mal de Pott

C. Tuberculose pulmonaire

D. Les méningites tuberculeuses génitales

E. La tuberculose génitale

Réponse : C, E

Explication : Tuberculoses pulmonaire et génitale sont des localisations correctes ; le mal de Pott est vertébral, non rénal.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 653 — La pollakiurie est l'augmentation du volume des urines pendant la nuit.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La pollakiurie augmente la fréquence des mictions ; la nycturie désigne les mictions nocturnes.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 654 — L'insuffisance cardiaque se définit par l'état de défaillance circulatoire qui résulte de l'impossibilité pour le cœur d'assurer un débit sanguin suffisant au besoin de l'organisme.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’insuffisance cardiaque entraîne un débit inadapté aux besoins ou le maintient au prix de pressions de remplissage élevées.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 24–28, insuffisance cardiaque.

Question 655 — Le cœur est un muscle doué d’une fonction non contractile mais automatique.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le myocarde est contractile ; le tissu spécialisé possède un automatisme.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 24–28, insuffisance cardiaque.

Question 656 — Les œdèmes des membres inférieurs d’origine cardiaque sont :

A. Unilatéraux

B. Douloureux

C. Symétriques

D. Prennent le godet

Réponse : C, D

Explication : Les œdèmes cardiaques sont habituellement bilatéraux, déclives, indolores et prenant le godet.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 24–28, insuffisance cardiaque.

Question 657 — Dans l’angine de poitrine

A. Le patient a du mal à avaler son crachat

B. La douleur est constrictive

C. La douleur survient à l’effort

D. La sédation survient avec la prise de trinitrine en 1 à 2 mn

Réponse : B, C, D

Explication : L’angor stable est classiquement constrictif, déclenché par l’effort et calmé par repos ou trinitrine.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 17–19, angine de poitrine.

Question 658 — Parmi ces facteurs, lesquels peuvent provoquer une atteinte du muscle cardiaque, notamment une cardiomyopathie toxique ou carentielle ?

A. L’anémie

B. L’alcool

C. Le sport

D. La malnutrition

Réponse : B, D

Explication : Alcool et certaines carences peuvent léser le myocarde ; il faut distinguer cardiomyopathie et myocardite.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 659 — Un patient naïf aux ARV est :

A. Un patient sous traitement ARV

B. Un patient n’ayant jamais pris d’ARV

C. Un patient ayant arrêté son traitement ARV

Réponse : B

Explication : Un patient naïf n’a pas encore reçu de traitement antirétroviral.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 660 — Une précordialgie d’origine cardiaque de courte durée et qui s’arrête avec la cessation des circonstances qui l’ont provoquée est :

A. Une péricardite aiguë

B. Une dissection aortique

C. Une angine de poitrine

D. Un œdème aigu des poumons

Réponse : C

Explication : Une douleur brève provoquée par l’effort et calmée par son arrêt évoque un angor stable.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 17–19, angine de poitrine.

Question 661 — Le rythme cardiaque normal chez l’adulte est compris entre :

A. 50 et 120 pulsations par minute

B. 50 et 100 pulsations par minute

C. 60 et 120 pulsations par minute

D. 60 et 100 pulsations par minute

Réponse : D

Explication : La fréquence cardiaque habituelle d’un adulte au repos est de 60 à 100/min.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Situation clinique

Cas clinique n°1 M. SAKI, 52 ans, commerçant, alcoolique connu, souffre de cirrhose hépatique chez qui une ponction d’ascite est effectuée. Il est sous Lasilix 20 mg comprimé. Depuis ce matin, vous découvrez que M. SAKI présente un signe d’insuffisance hépatique.

Question 662 — Quelles mesures concernent directement l’alimentation d’un patient cirrhotique avec ascite ?

A. Conseiller un régime alimentaire équilibré

B. Surveiller la coloration et la consistance des selles

C. Réaliser les examens paracliniques

D. Assurer le repos au lit jusqu’à l’assèchement de l’ascite

E. Prescrire des médicaments antibiotiques

F. Surveiller le régime désodé

Réponse : A, F

Explication : Nutrition adaptée et restriction sodée modérée dans l’ascite sont utiles ; surveiller aussi selles et tolérance du traitement.

Source : Médecine L2 .pdf, p. 46–56, cirrhose et ascite ; connaissances complémentaires pour les gestes infirmiers.

Question 663 — La classe thérapeutique du Lasilix est :

A. Antibiotique

B. Antiœdémateux

C. Diurétique

D. Anti-inflammatoire

Réponse : C

Explication : Le furosémide est un diurétique de l’anse.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 79–80, diurétiques ; connaissances complémentaires pour la surveillance rénale et ionique.

Question 664 — Quels sont les deux bilans prioritaires avant et pendant un traitement par furosémide, selon la situation ?

A. Ionogramme sanguin avec kaliémie.

B. Numération Formule Sanguine – VS

C. Examen cytobactériologique des urines

D. Échographie rénale

E. Clairance à la créatinine

F. Sérologie virale

Réponse : A, E

Explication : La kaliémie et la fonction rénale permettent de prévenir troubles électrolytiques et complications rénales.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 79–80, diurétiques ; connaissances complémentaires pour la surveillance rénale et ionique.

Question 665 — Le diagnostic du syndrome du côlon irritable est

A. Radiographique

B. Biologique

C. Radioscopique

D. Clinique

Réponse : D

Explication : Le côlon irritable est un diagnostic clinique positif avec recherche de signes d’alarme.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 666 — Indiquez parmi les éléments suivants la circonstance de découverte de la colopathie fonctionnelle :

A. Diarrhée hypo-électrolytique indolore à prédominance matinale ou post-prandiale

B. Affection colique associée à une diarrhée chronique

C. Céphalées accompagnées de nausées et vomissements parfois

D. Notion de dysenterie post-prandiale précédée de constipation

Réponse : A

Explication : Une diarrhée fonctionnelle peut être matinale ou postprandiale ; rechercher les critères de douleur pour parler de côlon irritable.

Source : Connaissances complémentaires — médecine générale, infectiologie et soins infirmiers ; justification non localisée dans les cours consultés.

VIH et traitements antirétroviraux deuxième série

Question 667 — Le Traitement Antirétroviral Hautement Actif (HAART) est une association efficace de trois médicaments au moins, appartenant en général à au moins deux classes différentes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La trithérapie classique associe des médicaments actifs ; certains schémas validés actuels utilisent deux molécules.

Source : NIH, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV, rubrique What to Start. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/what-start-initial-combination-regimens

Question 668 — Le Traitement Antirétroviral Hautement Actif (HAART) est une association efficace de trois médicaments ou plus, appartenant en général à au plus deux classes différentes.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : « Au plus deux classes » n’est pas une règle générale : deux ou plusieurs classes peuvent être utilisées.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 669 — La réduction du nombre de nouvelles contaminations est un intérêt du TARV

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Un traitement efficace avec suppression virale réduit la transmission ; une charge virale durablement indétectable empêche la transmission sexuelle.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 670 — La réduction du nombre de maladies opportunistes, d’hospitalisations, de décès liés au VIH et l’amélioration de l’espérance de vie font partie des principes de base du TARV

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Ce sont des bénéfices et objectifs du traitement, à distinguer des principes pratiques d’association et d’observance.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 671 — Prévenir les échecs thérapeutiques et repousser la résistance dans le temps est un intérêt du TARV

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Une prise correcte et un schéma actif limitent l’échec et l’émergence de résistances.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 672 — Concernant les interactions avec les ARV, la Rifampicine est contre-indiquée avec les inhibiteurs de protéase IP (Ritonavir).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La rifampicine interagit fortement avec les inhibiteurs de protéase boostés ; une alternative ou un avis spécialisé est nécessaire.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 673 — La Rifampicine associée aux INNRT augmente la concentration de la NVP

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La rifampicine induit le métabolisme et peut diminuer les concentrations de névirapine.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 674 — Il est recommandé de doubler la dose du Dolutégravir lors de l'association avec la rifampicine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : En l'absence de résistance aux intégrases, le dolutégravir est habituellement donné deux fois par jour avec la rifampicine selon le protocole.

Source : OMS, Dolutegravir 50 mg tablets, résumé des caractéristiques recommandé, interaction avec la rifampicine.
https://extranet.who.int/prequal/key-resources/documents/dtg-50mg-tablet-who-recommended-text-smpc

Question 675 — Les inhibiteurs de protéase (IP) diminuent les concentrations de certains contraceptifs oraux (éthinylestradiol).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : Certains inhibiteurs de protéase modifient les concentrations d'éthinylestradiol ; vérifier l'association précise.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 676 — L'Artémisinine en association avec ARV+Rito est recommandée car il y a une augmentation des concentrations de l'antipaludéen

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Une augmentation de concentration n'est pas un motif de recommandation ; l'interaction dépend de l'antipaludéen et de l'ARV précis.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 677 — L'Artémisinine en association avec INNRT est déconseillée car diminution des concentrations de l'antipaludéen

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : L'affirmation est trop générale : certaines associations restent utilisables avec précautions et surveillance.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 678 — La Quinine en association avec les INNRT entraîne une diminution des concentrations, donc augmenter les doses de la quinine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Ne pas augmenter automatiquement la quinine ; la conduite dépend de l'association et d'une évaluation des risques.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 679 — La Quinine en association avec ARV + Rito entraîne une augmentation des concentrations, donc diminuer les posologies de la quinine

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Ne pas diminuer automatiquement la quinine sur cette seule affirmation ; avis spécialisé et surveillance sont nécessaires.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 680 — Le ritonavir diminue systématiquement la concentration de codéine, ce qui justifie d'en augmenter soi-même la dose.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : Le ritonavir peut réduire l'activation de la codéine en morphine ; l'effet ne se résume pas à une diminution de concentration de codéine.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 681 — En cas de Pré-Exposition (PrEP) continue, l'arrêt du traitement n'est possible que 21 jours après la dernière prise de risque.

A. Vrai

B. Faux

Réponse : B — Faux

Explication : La durée après la dernière exposition dépend du produit et du type d’exposition ; 21 jours n’est pas une règle universelle d’arrêt.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 682 — La compliance est la capacité d’une personne à prendre un traitement selon une prescription donnée (posologie, horaire, repas).

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : La compliance décrit le suivi de la prescription, incluant doses et horaires.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 683 — L’adhésion est le degré d’accord du patient au traitement

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’adhésion correspond à l’accord éclairé et à l’implication du patient dans le traitement.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 684 — L’observance du TARV est le respect du rythme des prises médicamenteuses et quantité de médicaments

A. Vrai

B. Faux

Réponse : A — Vrai

Explication : L’observance décrit l’application effective des modalités du traitement.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 685 — Comment préparer le patient au traitement ARV ? Entourer les bonnes les réponses exactes

A. Faire comprendre au patient l’importance d’une bonne observance

B. Gérer les effets indésirables des ARV

C. Faire savoir au patient que le traitement ARV est un traitement de longue durée ou à vie

D. Choisir le bon schéma de traitement

E. Respecter le calendrier de suivi

F. Prendre en compte les préoccupations et les priorités

Réponse : A, C, F

Explication : Expliquer la durée, l’intérêt d’une bonne prise et intégrer les préoccupations prépare l’adhésion.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 686 — Parmi les éléments suivants deux sont les principes de base du TARV lesquels ?

A. Associer les médicaments antirétroviraux

B. L’amélioration de la qualité de vie

C. Aider le patient à l’observance du TARV

D. La suppression ou une réduction forte et prolongée de la réplication virale (charge virale ou CV)

E. La restauration et l’amélioration de la fonction immunitaire

Réponse : A, C

Explication : Association d’ARV actifs et soutien à l’observance sont des principes de mise en œuvre ; les autres propositions sont des objectifs.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 687 — Parmi les éléments suivants indiquez ceux qui sont les principes de base pour aider le patient à l’observance du TARV

A. Éviter de prendre une ou deux molécules sur trois prescrites

B. Savoir que c’est un traitement à vie

C. Choisir le bon schéma de traitement

D. Renouveler les stocks à temps

E. Respecter les doses prescrites, les horaires de prises et les restrictions alimentaires

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Prendre le schéma complet, comprendre le traitement, anticiper les stocks et respecter les modalités favorisent l’efficacité.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 688 — Sous PrEP orale quotidienne au ténofovir, quel délai peut être nécessaire pour atteindre une protection maximale lors d’une exposition vaginale réceptive ?

A. 7 jours de prise

B. 21 jours de prise

C. 28 jours de prise

D. 30 jours de prise

Réponse : B

Explication : Pour une PrEP orale quotidienne au ténofovir, la protection maximale pour l’exposition vaginale peut nécessiter jusqu’à 21 jours.

Source : CDC, Clinical Guidance for PrEP, rubrique délai de protection.
https://www.cdc.gov/hivnexus/hcp/prep/index.html

Question 689 — Les limites du Traitement ARV sont :

A. Activité non virucide

B. Médicaments non efficaces

C. Émergence rapide des mutants résistants

D. Médicaments onéreux pour le malade

Réponse : A, C

Explication : Les ARV ne suppriment pas les réservoirs ; une résistance peut émerger en cas de réplication sous pression thérapeutique insuffisante.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 690 — Sous PrEP orale quotidienne au ténofovir, quel délai est généralement retenu pour atteindre une protection maximale lors d'une exposition anale réceptive ?

A. 7 jours de prise

B. 21 jours de prise

C. 28 jours de prise

D. 30 jours de prise

Réponse : A

Explication : Le délai d'environ sept jours concerne l'exposition anale réceptive sous PrEP orale quotidienne, et ne se définit pas par le sexe seul.

Source : CDC, Clinical Guidance for PrEP, rubrique délai de protection.
https://www.cdc.gov/hivnexus/hcp/prep/index.html

Question 691 — Un enfant de [6 mois – 3 ans[mis sous TARV (ABC + 3TC + LPV/r) a pour régime :

A. ABC + 3TC + LPV/r (Granules 40mg/10mg)

B. ABC + 3TC + LPV/r (Comprimés dispersibles 100mg/25mg)

C. ABC + 3TC + LPV/r (Sirop 80mg/20mg par mL)

Réponse : A

Explication : Les granules pédiatriques sont une présentation adaptée aux jeunes enfants ; dose et choix doivent suivre le poids et les directives.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d'antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Situation clinique

Étude de cas Enfant S V est né à la maternité rurale de S B le 14 Février 2023 d'un accouchement normal. Sa mère KM a été dépistée séropositive au VIH1 la veille de Noël 2022 lors de sa 1ère CPN et mise sous TARV le même jour mais n'a pas pu bénéficier d'un bilan initial ni de charge virale au cours de la grossesse à cause de la distance de la maternité au chef-lieu de Sous-Préfecture. Sur conseils de la Sage-Femme, l'enfant n'a pas été mis au sein.

Question 692 — Quel est le statut de l'enfant S V ?

A. Enfant exposé à faible risque de transmission du VIH

B. Enfant exposé à haut risque de transmission du VIH

C. Enfant exposé à aucun risque de transmission du VIH

D. Risque à évaluer selon charge virale, observance, durée du TARV et critères nationaux.

Réponse : D

Explication : La mère a reçu environ sept semaines de TARV, mais la charge virale et l'observance sont inconnues ; le risque exige le protocole national.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 693 — Faut-il mettre l'enfant S V sous traitement ?

A. Oui

B. Non

C. Je ne sais pas

Réponse : A

Explication : Tout enfant exposé doit bénéficier d'une prophylaxie adaptée au risque et d'un suivi virologique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 694 — Après plusieurs hésitations, la Sage-Femme décide de mettre l'enfant SV sous traitement ARV prophylactique ; aidez-la.

A. AZT 2 fois/jour pendant 6 semaines

B. AZT + NVP pendant 6 semaines

C. Névirapine (NVP) 1,5 ml/jour

D. Zidovudine (AZT) 1,5 ml deux fois/jour

E. Choisir la prophylaxie selon le risque et le protocole national ; calculer les doses selon poids et formulation.

Réponse : E

Explication : Sans classification du risque, poids et formulation, il n'est pas sûr de choisir une association ou une dose en millilitres.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 695 — A la visite de CPoN, la sage-femme s'est rendu compte que la mère KM n'a pas suivi ses conseils et qu'elle donne régulièrement le sein à son enfant SV sur insistance de sa grand-mère. Avec cette nouvelle donne, faut-il requalifier l'enfant SV ? (lui donner un nouveau statut) ?

A. Oui

B. Non

C. Je ne sais pas

Réponse : A

Explication : L'allaitement ajoute une exposition postnatale ; il faut réévaluer la situation sans culpabiliser la mère.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 696 — Faut-il changer de traitement ?

A. Oui

B. Non

C. Je ne sais pas

D. Réévaluer le risque et adapter la prophylaxie selon les directives plutôt que changer automatiquement.

Réponse : D

Explication : La prophylaxie est réévaluée selon la charge virale maternelle, l'observance, l'âge et le protocole ; un changement n'est pas automatique.

Source : OMS, Infant feeding for the prevention of mother-to-child transmission of HIV. https://www.who.int/tools/elena/interventions/hiv-infant-feeding

Question 697 — Le 30 Mars 2023 une PCR sera faite. Si la PCR est négative que faire ?

A. Poursuivre le traitement prophylactique prescrit

B. Arrêter le traitement prophylactique

C. Poursuivre la prophylaxie avec la NVP seule pendant 6 semaines supplémentaires

D. Poursuivre l'évaluation et le suivi virologique ; adapter la prophylaxie à l'exposition par l'allaitement selon les directives.

Réponse : D

Explication : Une PCR négative à six semaines ne clôt pas le suivi si l'allaitement continue ; durée et prophylaxie dépendent du risque et des directives.

Source : OMS, VIH et sida, fiche du 27 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

Question 698 — En cas d’accident d’exposition, le traitement ARV prophylactique d’un adulte est :

A. TDF + 3TC + DTG dans les 72h suivant l’exposition et pendant 28 jours

B. AZT + 3TC + LPV/r dans les 72h suivant l’exposition et pendant 21 jours

C. TLD dans les 24h suivant l’exposition et pendant 21 jours

Réponse : A

Explication : La prophylaxie post-exposition débute au plus vite, dans les 72 heures, et dure 28 jours ; le schéma dépend des contre-indications.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 699 — En cas d’accident d’exposition, le traitement ARV prophylactique chez l’enfant de moins de 35 kg est :

A. TDF + 3TC + DTG

B. TDF + 3TC + LPV/r

C. AZT + 3TC + LPV/r

D. Schéma pédiatrique fondé sur âge, poids, formulations disponibles et recommandations actualisées.

Réponse : D

Explication : Le seuil de 35 kg seul ne suffit pas ; le schéma dépend de l’âge, du poids, de la formulation et des recommandations actualisées.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 700 — Indiquez les cas de référence au médecin de prise en charge

A. Co-infections TB/VIH

B. Co-infection hépatite/VIH

C. Anémie avec hémoglobine ≤ 8 g/dl.

D. Patient VIH avec facteurs de co-morbidité

E. Troubles neurologiques, rénaux et parasitaires

Réponse : A, B, C, D, E

Explication : Co-infections, anémie importante, comorbidités et atteintes d’organes justifient un avis médical ; l’Hb s’exprime en g/dl.

Source : COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf, p. 39–40, classes d’antirétroviraux ; connaissances complémentaires pour les particularités thérapeutiques.

Question 701 — Quel est le seuil de bonne observance au TARV ?

A. Le seuil de bonne observance au TARV est de 90%

B. Le seuil de bonne observance au TARV est supérieur à 90%

C. Le seuil de bonne observance au TARV est inférieur ou égal à 90%

D. Viser toutes les doses prescrites et évaluer les oublis avec le patient.

Réponse : D

Explication : L’objectif est de prendre toutes les doses ; aucun seuil universel de 90 % ne définit à lui seul une bonne observance.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 702 — La mauvaise observance se définit par :

A. Acte délibéré ou non de manquer plus d'une dose au cours d'une période d'un mois pour un traitement se prenant deux fois par jour

B. Acte délibéré ou non de manquer plus d'une dose au cours d'une période de 10 jours pour un traitement se prenant deux fois par jour

C. Acte délibéré ou non de manquer une dose au cours d'une période de 10 jours pour un traitement se prenant deux fois par jour

D. Toute prise différente de la prescription doit être évaluée ; aucun seuil calendaire unique ne suffit.

Réponse : D

Explication : Toute dose manquée doit être évaluée ; aucun de ces découpages calendaires n'est une définition générale validée.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 703 — Les causes de la mauvaise observance liées aux médicaments sont :

A. Nombre par prise

B. Au patient

C. Durée

D. Entourage du patient

E. Contraintes horaires

F. À l'âge du patient

Réponse : A, C, E

Explication : Nombre de comprimés, durée et contraintes horaires sont des facteurs liés au traitement.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 704 — Indiquez parmi les éléments suivants ceux qui sont les inconvénients d'une mauvaise observance du TARV

A. Diminution du nombre d'orphelins et enfants rendus vulnérables

B. Échec du TARV

C. Réduction des infections opportunistes

D. Aggravation de la maladie

E. Amélioration de l'espérance de vie

F. Réapparition des infections opportunistes

Réponse : B, D, F

Explication : La mauvaise observance expose à l'échec, à la progression de la maladie et aux infections opportunistes.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 705 — Le bilan initial comporte les examens suivants sauf un, lequel ?

A. Sérologie VIH

B. Charge virale CV

C. NFS

D. ALAT

E. Numération CD4

Réponse : A

Explication : Après confirmation du diagnostic VIH, répéter la sérologie n’évalue pas l’état initial ; le bilan biologique dépend du schéma et du terrain.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Question 706 — Le bilan de suivi d’un malade sous traitement ARV comporte les examens suivants sauf un, lequel ?

A. Sérologie VIH

B. Charge virale CV

C. NFS

D. ALAT

E. Numération CD4

Réponse : A

Explication : La sérologie reste positive et ne mesure pas l’efficacité ; le suivi repose surtout sur la charge virale et la clinique.

Source : Connaissances complémentaires — infectiologie et pharmacologie du VIH ; justification non localisée dans les cours consultés.

Références

Documents de cours : Médecine L2 .pdf ; Medecine L1.pdf ; COURS PHARMACOLOGIE INFAS 2021 definitif 2021.pdf. Les pages utiles sont indiquées sous chaque question concernée.

Les mentions « connaissances complémentaires » désignent une justification fondée sur les connaissances médicales générales, sans attribution à une page de cours non vérifiée. Elles ne constituent pas un corrigé officiel de l’établissement.

OMS, Tuberculosis, fiche du 24 mars 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

CDC, Clinical Testing Guidance for Tuberculosis Tuberculin Skin Test, 31 janvier 2025, rubriques administration et interprétation. https://www.cdc.gov/tb/hcp/testing-diagnosis/tuberculin-skin-test.html

OMS, Guidelines for HIV post-exposure prophylaxis, 22 juillet 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240095137

CDC, Clinical Guidance for PrEP, rubrique délai de protection. https://www.cdc.gov/hivnexus/hcp/prep/index.html

OMS, Dolutegravir 50 mg tablets, résumé des caractéristiques recommandé, interaction avec la rifampicine. https://extranet.who.int/prequal/key-resources/documents/dtg-50mg-tablet-who-recommended-text-smpc

OMS, VIH et sida, fiche du 27 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

NIH, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV, rubrique What to Start. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/what-start-initial-combination-regimens

American Society of Hematology, Blood Safety and Matching, rubrique plasma. https://www.hematology.org/education/patients/blood-basics/blood-safety-and-matching

OMS, Infant feeding for the prevention of mother-to-child transmission of HIV. https://www.who.int/tools/elena/interventions/hiv-infant-feeding

Références externes consultées le 20 octobre 2026. Les recommandations internationales ne remplacent pas un protocole national daté pour les posologies pédiatriques, le PEV ou les schémas locaux de prise en charge.